

## Hoorcollege 1: inleiding

### 1. Wat zijn life events

= **ingrijpende gebeurtenissen** die zich id loop v iemands leven kunnen voordoen, en die als uitzonderlijk of betekenisvol kunnen **worden ervaren**

- ➔ Hebben het potentieel om destabiliserend te zijn & kunnen diepgaande invloed uitoefenen op het functioneren & welzijn v p

**Tools** om life events in kaart te brengen

- Srss (social readjustment rating scale)
- USQ (undergraduate stress questionnaire)
- Lec-5

### Benadering van life events

Biopsychosociale benadering

- Biologisch
- Psychologisch
- Sociaal

Levensloop benadering

- Bij eenzelfde gebeurtenis maar op andere leeftijd = anders mee omgaan (bv sollicitatie)
- Een ingrijpende gebeurtenis kan zwaarder wegen als die volgt op een periode van meerdere veranderingen of stressvolle situaties

**Existentiële benadering**

= iedereen heeft schema's waarmee die betekenis geeft aan zn leven

- ➔ Wanneer een life event daar moeilijk in past gaan we opnieuw in een proces om daaraan betekenis te geven (gaat over richting geven, doel geven om eigen verhaal te begrijpen)
- Doel: motivatie
  - Coherentie: cognitie = betekenis geven
  - Waarde: evaluatie

Maatschappelijke benadering:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| - Individu     | - Exosysteem   |
| - Microsysteem | - Macrosysteem |

### 2. Impact van een life event wordt meebepaald door

De impact van een life event is niet objectief maar subjectief

- Dezelfde gebeurtenis kan totaal anders ervaren worden
- Hangt af van **persoon, context en interpretatie**

### Levensgeschiedenis

- Alle eerdere ervaringen (positief én negatief) vormen een referentiekader
  - Bepalen hoe iemand nieuwe gebeurtenissen inschat & beleeft
  - Ervaringen beïnvloeden verwachtingen ("ik kan dit aan" vs "dit gaat mis")

- Mensen leren niet alleen uit fouten, maar ook uit successen
  - Succeservaringen versterken gevoel van controle & veerkracht
- Eerdere blootstelling aan stressvolle situaties:
  - Kan leiden tot meer copingvaardigheden
  - Zorgt vaak voor minder machteloosheid bij nieuwe events

= levensgeschiedenis beïnvloedt dus interpretatie + coping + emotionele reactie

## **Persoonlijkheidseigenschappen**

Persoonlijkheid bepaalt hoe iemand reageert op stressvolle situaties

➔ Beïnvloedt zowel denken, voelen als gedrag

Voorbeelden:

- “Doeners” → ervaren frustratie bij situaties zonder controle (bv ziekte van ander)
- Gevoelige personen → nemen prikkels sterker op → grotere impact
- Optimistische mensen → zien sneller oplossingen

Persoonlijkheid beïnvloedt:

- ➔ Hoe iemand stress inschat
- ➔ Hoe iemand ermee omgaat (coping)
- ➔ Hoe intens emoties worden ervaren

= persoonlijkheid = belangrijke filter tussen gebeurtenis & reactie

## **Hechtingsstijl**

- Hechting bepaalt hoe iemand omgaat met stress, verlies & relaties
  - Ontstaat in vroege ontw maar blijft invloed hebben op volwassen gedrag
- Verschillende reacties bij hetzelfde life event (vb jobverlies):
  - Angstige hechting = zoekt steun, emotioneel intens, voelt zich onzeker
  - Vermijdende hechting = afstand, onderdrukken emoties, onafhankelijk willen blijven
- **Model van Bartholomew & Horowitz (gebaseerd op 2 dimensies):**
  - Model vanzelf (positief ↔ negatief)
  - Model van anderen (vertrouwen ↔ wantrouwen/vermijding)

= combinatie → 4 hechtingsstijlen
- Gevolg: hechtingsstijl beïnvloedt hoe iemand steun zoekt, hoe emoties worden verwerkt, hoe stress ervaren wordt

## **Gezondheidstoestand**

Fysieke en mentale gezondheid bepalen draagkracht

- ➔ Ziekte = minder energie om met stress om te gaan
- ➔ Eerdere ziekte-ervaring:
  - Kan leiden tot relativering (“dit is minder erg dan vroeger”)
  - Kan ook leiden tot verhoogde kwetsbaarheid

Ook **perceptie** van gezondheid speelt rol

➔ Hoe iemand zijn gezondheid ziet beïnvloedt stressbeleving

= WHO-definitie gezondheid:

- Fysiek + mentaal + sociaal welbevinden
- Kritiek: te ideaal → bijna niemand volledig “gezond”

### 3. Tools

#### Positieve gezondheidstool

= focus op functioneren en welbevinden i.p.v. enkel ziekte

- Centrale vraag: “Wat heb jij nodig om je goed te voelen?”
- 6 domeinen:
  1. Lichaamsfuncties (bv slaap, energie, pijn)
  2. Mentaal welbevinden (gevoel, controle, concentratie)
  3. Zingeving (doel, betekenis, motivatie)
  4. Kwaliteit van leven (geluk, veiligheid, balans)
  5. Meedoen (sociale relaties, steun, erbij horen)
  6. Dagelijks functioneren (zelfzorg, werk, organisatie)

Resultaat = visueel “spinnenweb”

- ➔ Toont sterktes & werkpunten
- ➔ Helpt inzicht krijgen in impact v life events op verschillende levensdomeinen

#### PERMA-model (Seligman)

= model voor subjectief welbevinden (SWB)

SWB = hoe iemand zijn leven ervaart en beoordeelt

Bestaat uit:

- Geluk (korte termijn emoties)
- Levenstevredenheid (algemene evaluatie van leven)

PERMA bestaat uit 5 elementen:

- P = positieve emoties → zich goed voelen
- E = engagement → flow, volledig opgaan in activiteit
- R = relaties → kwaliteit van sociale contacten
- M = meaning → zingeving en doel in leven
- A = achievement → succes en persoonlijke groei

Hogere SWB =

- ➔ Betere fysieke gezondheid
- ➔ Sterkere sociale relaties
- ➔ Meer adaptief gedrag

Maar:

- Te veel positiviteit (euforie) kan nadelig zijn
- Negatieve emoties zijn soms functioneel

Invloed life events op SWB

- Set-point theorie = SWB keert terug naar basisniveau na verstoring
- Affectieve theorie = life events hebben langdurige impact op welzijn

= beide theorieën vullen elkaar aan

## Balkmetafoor (draaglast – draagkracht)

= visueel model om stress te begrijpen

- Draaglast = eisen/stressoren (bv werkdruk, verlies)
- Draagkracht = coping, steun, energie
- ➔ Als draaglast > draagkracht = stress, overbelasting, risico op problemen
- ➔ Als in balans = stabiel functioneren

= kernidee kwetsbaarheid-stressmodel

## 4. Stress

### Definitie van stress

= toestand van druk wanneer eisen groter zijn dan aanpassingsvermogen

Stress kan bekeken worden als:

- Reactie op stimulus (stressor)
- Fysiologische reactie
- Interactie tss persoon & situatie
- Focus op externe gebeurtenissen

### Werking van stress:

- **Stressor**: verandering, beheersbaarheid, voorspelbaarheid, ambiguïteit
- **Stresssysteem**: autonoom zenuwstelsel & HPA-as
- **Stressrespons**: reactie op stress
- **Stress**: + eustress – distress

### Soorten stressoren:

- **Catastrofes** (bv rampen)
- **Levensgebeurtenissen** (bv huwelijk, jobverlies)
- **Dagelijkse ergernissen** (kleine, frequente stress)

Holmes & Rahe:

- SRRS schaal (Life Change Units)
- Cumulatief effect v gebeurtenissen

Beperkingen:

- Subjectieve interpretatie ontbreekt
- Culturele verschillen
- Herinneringsbias

### Stress als transactie (Lazarus)

= stress = resultaat v interactie tss persoon & situatie

- Primaire beoordeling = is het bedreiging, schade of uitdaging?
- Secundaire beoordeling = kan ik hiermee omgaan? (coping + middelen)
- ➔ Copingstrategieën+ hulpbronnen bepalen stressniveau

= stress is dus niet objectief maar afhv interpretatie

## Typen stress



| Acute stress                                                                                                                        | Chronische stress                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Korte, intense reactie</li><li>• Bv rampen, examens</li><li>• Kan leiden tot PTSS</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Langdurige belasting</li><li>• Bv werkstress</li><li>• Kan leiden tot burn-out</li></ul> |

## Burn-out (Maslach):

- 
- Emotionele uitputting
  - Depersonalisatie
  - Verminderde prestaties

## Polyvagaal theorie

= verklaart automatische stressreacties via zenuwstelsel en vertrekt vanuit 3 principes:

- Hiërarchie
- Neuroceptie
- Co-regulatie

## Hiërarchie



|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventrale vagale systeem | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actief bij veiligheid</li><li>• Sociale verbinding, rust</li><li>• In het nu</li></ul>              |
| Sympathisch systeem     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fight or flight</li><li>• Vastzitten in gedachten</li><li>• Verhoogde hartslag, alertheid</li></ul> |
| Dorsale vagale systeem  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Freeze en fawn modus</li><li>• Uit contact</li><li>• Afsluiten, dissociatie, onveilig</li></ul>     |

- Reactie gebeurt automatisch (niet bewust)
- Verschilt per persoon
- Trauma → sneller activatie stresssystemen

## Neuroceptie

= onbewust proces in ons brein dat continu de omgeving scant op gevaar & veiligheid

→ Heeft invloed op welke fase de hiërarchie geactiveerd wordt

## Co-regulatie

= de ander gebruiken om jezelf te kalmeren

→ Link met life events = vaak zakken we fasen in hiërarchie ten gevolge van life event & mensen in werkveld coachen rond life events & impact die het heeft op hun leven

## Window of tolerance

- Hyperarousal (overprikkeling)
- Window of tolerance = genoeg veiligheid
- Hypoarousal (onderprikkeling)

= veranderingen in arousal komt door de **neuroceptie**

## 5. Moderatoren

### Appraisals

Appraisal = taxatie of bepalen vd waarde

- Primair = 1<sup>e</sup> inschatting vd situatie of stressor obvd aard, kwaliteit & het belang voor de persoon
- Secundair = beoordeling v externe of interne hulpbronnen & het vermogen om met de gebeurtenis om te gaan tov de gebeurtenis id primaire appraisal

### Attributies

= iemand zijn perceptie/overtuiging vd oorzaken van overtuigingen, gevoelens, gedrag & handelingen

- Intern – extern
- Stabiel – instabiel
- Globaal – specifiek
- Controleerbaar – oncontroleerbaar

### Locus of control

= mate waarin individu verwacht de uitkomsten v zijn eigen leven te kunnen beïnvloeden

- Interne locus = eigen handelen heeft grote impact op het resultaat
- Externe locus = de relatie tss wat je doet en hoe het resultaat zal zijn zie je als onvoorspelbaar
  - Toeval = mensen gaan ervanuit dat hun leven relatief onafh is v hun eigen gedrag
  - Machtige anderen = geloven dat hun leven bepaald wordt door anderen, overheden, dokters, Goden,...

### Veerkracht

= mogelijkheid v mensen om zich aan te passen aan veranderende situaties, om terug te veren na een life event

➔ = aanpassingsvermogen, veerkracht is de soepelheid daarvan en is een proces

Kenmerken:

- Gebalanceerdheid
- Doorzettingsvermogen
- Zelfvertrouwen
- Zinvolheid
- Existentele eenzaamheid

→ tegenovergestelde v kwetsbaarheid

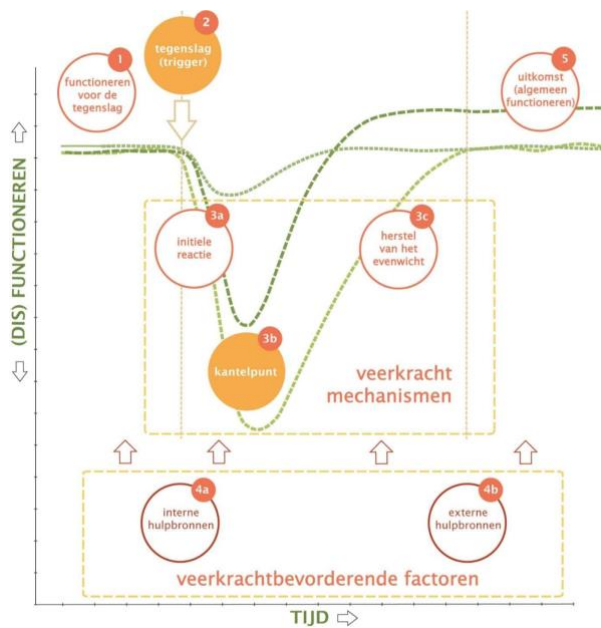
→ beschermende factor

Voorbeelden:

- Optimisme
- Copingvaardigheden
- Sociale steun

→ hoge veerkracht = minder kans op stoornis

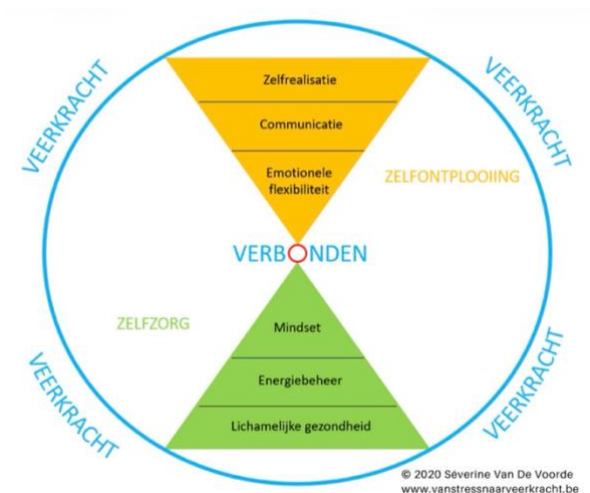
→ maar geen volledige bescherming



### Diabolomodel van veerkracht

= samenhangend overzicht vd belangrijkste methoden om veerkracht in al zijn aspecten te versterken

➔ Elke driehoek bevat 3 sleutels en dan nog een 7<sup>e</sup> daartussen



3 thema's:

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Zelfzorg (basis)</i>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slaap, voeding, energiebeheer</li> <li>• Noodzakelijk fundament</li> </ul>                        |
| <i>Zelfontplooiing</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persoonlijke groei</li> <li>• Emotionele flexibiliteit</li> <li>• Sociale vaardigheden</li> </ul> |
| <i>Verbondenheid (centrale spil)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relaties met anderen &amp; jezelf</li> <li>• Geeft betekenis &amp; steun</li> </ul>               |

➔ Alle onderdelen beïnvloeden elkaar

➔ Zonder zelfzorg geen groei of verbinding

## 6. Stressweerbaarheidsmodel

### Basisidee

= **kwetsbaarheid-stressmodel (diathese-stressmodel)** is een model dat verklaart hoe mentale aandoeningen kunnen ontstaan, waarom sommigen het wel of niet ontw & wrm dezelfde stressor niet bij iedereen hetzelfde effect heeft

- ➔ **Psychische problemen ontstaan door interactie van:**
  - Kwetsbaarheid (aanleg) (diathese/vulnerability)
  - Stressfactoren uit omgeving (life events)
- ➔ Model gaat over balans tss draagkracht & draaglast
- ➔ Metaforen die dit vergelijken = balkenmetafoor & touwmetafoor

### Ontstaan van het model

- Oorspronkelijk ontw im psychotische episodes bij schizofrenie te verklaren
- Gebaseerd op werk v Zubin & Spring

Oudere verklaringsmodellen waren te beperkt:

- Ecologische modellen
- Genetische modellen
- Ontwikkelingsmodellen
- Neurofysiologische modellen
- Leermodellen

= verklaren slechts een deel v psychopathologie

- ➔ “Kwetsbaarheid” als gemeenschappelijk factor die alle modellen verbindt

### Stress binnen het model

Stress = gebeurtenissen/omstandigheden die evenwicht v p verstoren, kan gaan om:

- Negative life events
- Behoren tot etnische minderheidsgroep
- Dagelijkse stress
- Interne factoren (zoals verslaving)
- Socio-economische factoren

!!! Dezelfde situatie wordt n door iedereen als even stressvol ervaren & perceptie v dreiging verschilt

### Kwetsbaarheid

= diathese = predispositie om psychische problemen te ontwikkelen & is biopsychosociaal

- Genetische aanleg
- Bepaalde cognities of gedragspatronen
- Gevoeligheid voor stress

Risicofactor ≠ kwetsbaarheid

- Risicofactor = verhoogt de kans
- Kwetsbaarheid = onderliggend mechanisme dat kan leiden tot psychopathologie

### Inzicht van het model

- Stress alleen is onvoldoende verklaring voor mentale aandoening
- Kwetsbaarheid bepaalt mee of iemand ‘breekt’ onder stress

= combinatie bepaalt risico op psychopathologie

### Touwmetafoor

- Gewicht = stress/draaglast



- Touw = draagkracht v individu & kan:
  - Onveranderd blijven
  - Tijdelijk of blijvend uitrekken
  - Breken

Wanneer coping onvoldoende is -> kans op 'breken' stijgt

## Coping

= cognitieve, emotionele & gedragsmatige strategieën om met stress om te gaan:

- Probleem oplossen
- Steun zoeken
- Emoties reguleren

## Veerkracht

= vermogen om zich aan te passen & te herstellen v stress (tegenovergestelde v kwetsbaarheid)

Voorbeelden v veerkrachtfactoren:

- Optimisme
- Sterk sociaal netwerk
- Altruïsme
- Goede copingvaardigheden

Veerkracht & kwetsbaarheid vormen een continuüm:

- Hoge kwetsbaarheid = weinig stress nodig voor problemen
- Hoge veerkracht = meer stress nodig voor psychopathologie

!!! Zelfs veerkrachtige mensen kunnen klachten ontw bij extreme stress & niemand is immuun

## Risico-veerkrachtmodel

= model houdt rekening met kans op ontw v stoornis & de ernst v symptomen

- Hoge kwetsbaarheid + hoge stress = ernstigere psychopathologie
- Hoge veerkracht = klachten mogelijk, maar vaak minder ernstig

## Uitbreiding: kwetsbaarheid-stress-copingmodel

= Schiele et al breidden model uit nr 3D-model met kwetsbaarheid, stress & coping

➔ = G x E x C model

➔ = genetics x environment x coping

Coping kan impact v genetische kwetsbaarheid & stress bufferen

- Slechte coping = lagere drempel voor ziekte
- Goede coping/hoge zelfeffectiviteit = hogere drempel voor psychopathologie

Klinisch belang

- ➔ Copingvaardigheden zijn veranderbaar & trainbaar (belangrijk in therapie & preventie)
- ➔ Onderzoek toont dat zelfeffectiviteit stijgt door
  - Stressmanagementtraining
  - Cognitieve gedragstherapie
  - Zelfmanagementinterventies

## Hoorcollege 2: ouderschap

### 1. Zwangerschap

Fysieke veranderingen:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>e</sup> trimester | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ochtendmisselijkheid</li><li>• Neurologisch<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Afname volume grijze stof vermoeden verband met hechting (reorganisatie), verbeterde functionele connectiviteit default netwerk (brein in rust)</li><li>➢ Toename witte stof: gelinkt aan verbeteren communicatie tss emotionele &amp; visuele netwerken</li></ul></li><li>• Afvallen of bijkomen</li></ul> |
| 2 <sup>e</sup> trimester | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fysieke veranderingen is zichtbaar voor buitenwereld</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 <sup>e</sup> trimester | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fysieke ongemakken bij moeder komen terug</li><li>• Minder goede slaap</li><li>• Lichaam dat minder beweeglijk is</li><li>• Sneller vermoeid</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

Mentale uitdagingen:

- Hormonale verandering & emoties
- Persoonseigenschappen
- Vroegere zwangerschappen
- Identiteitsvragen

Invloed op:

- Partnerrelatie
- Relatie met eigen ouders
- Belangrijke afwezigen
- Maatschappij
- Werk

Periode rond bevalling

- Voorbereiding en medische complicaties
- Baby blues
- Postnatale depressie & angststoornis
- Postpartum psychose
- Afscheid nemen v (het beeld v) een kind

### 2. Babyblues

= emotionele achtbaan die kort na bevalling kan optreden = tegelijkertijd gelukkig & verdrietig of snel geïrriteerd (50-80% vd vrouwen ervaren deze klachten)

!!! Geen aandoening maar eerder tijdelijke aanpassing vh lichaam (hormonaal)

- ➔ Gevolg vd sterke daling in hormonen progesteron & oestrogeen vlak na geboorte
- ➔ Beginnen vaak al id eerste 2 tot 3 dagen na bevalling & hoogtepunt tss 3<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> dag
- ➔ Normaal na 6<sup>e</sup> week geen sprake meer v babyblues

Symptomen:

- Stemningswisselingen
- Prikkelbaarheid & huilbuien zonder reden
- Vermoeidheid & slaapproblemen
- Angstgevoelens & onzekerheid
- Somberheid & neerslachtigheid

### 3. Verhoogde kans op ontwikkelen van psychische problemen in de perinatale periode

!!! 1/5 vrouwen heeft psychische problemen tijdens zwangerschap & 1<sup>e</sup> levensjaar volgend op de geboorte

#### Depressie & angststoornissen

= meest voorkomende mentale problemen tijdens peripartum

- ➔ Kunnen zich manifesteren net voor of tijdens zwangerschap of tot één jaar na de bevalling
- ➔ Hebben significante impact op verschillende levensgebieden gedurende minstens 2 weken

Cijfers:

- Perinatale depressie: treft ongeveer 7 tot 15% vd moeders tijdens zwangerschap & 10% na bevalling, vergelijkbaar voor partners
- Angststoornis: ongeveer 13% vd moeders

Andere:

- OCS (obsessief-compulsieve stoornis)
  - Treft 2,1-2,4% vd vrouwen
  - Kan zich manifesteren als dwanggedachten om het kind te beschermen, soms als nesteldrang
- PTSS (posttraumatische stressstoornis):
  - Treft 3 tot 9% vd vrouwen, vaak als reactie op een traumatische bevallingservaring met symptomen direct na of later na de bevalling
- Postpartum psychose:
  - Treft 1-2 per 1000 geboortes, met risico v herhaling bij volgende geboortes
  - Symptomen ve psychotische episode zoals wanen & hallucinaties
  - Ongeveer 75% blijft ongediagnosticeerd

### 4. Verlies van een kind (artikel: veerkracht bij gezinnen na verlies van kind)

= artikel onderzoekt welke factoren gezinnen helpen om zich aan te passen na het overlijden ve kind

#### **Verlies van een kind en rouw**

Volgens klassieke rouwmodellen verloopt rouw vaak in verschillende fasen:

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Verdoving & ontkenning       | Ongeloof & emotionele verdoving                                        |
| Geleidelijk besef vh verlies | Intense verdrietgevoelens, huilen, boosheid                            |
| Acute rouwfase               | De pijn vh verlies wordt sterk ervaren                                 |
| Herstelfase                  | Opnieuw energie investeren in relaties, werk & dagelijkse activiteiten |

Modernere modellen benadrukken dat mensen de overleden persoon niet volledig “loslaten”, maar de relatie innerlijk reorganiseren

#### **Gecompliceerde rouw**

Hangt samen met:

- Omstandigheden vh overlijden
- Relaties binnen het gezin
- Leeftijd vh kind
- Sociale context

Bijvoorbeeld:

- Overlijden op jonge leeftijd wordt vaak ervaren als “onnatuurlijk” of “te vroeg”
- Suïcide veroorzaakt vaak extra gevoelens v schaamte, woede & sociale isolatie
- Broers & zussen kunnen gedragsproblemen, angst of depressieve gevoelens ontwikkelen

Vooraf jonge kinderen reageren soms met agressief gedrag of internaliserende klachten

### **Van probleemgericht naar veerkrachtgericht denken**

Vroeger lag de nadruk vooral op problemen en psychopathologie bij rouw. Tegenwoordig kijkt men meer naar sterktes en veerkracht.

Het uitgangspunt is dat gezinnen:

- Copingvaardigheden hebben
- Steunbronnen kunnen gebruiken
- Zich kunnen aanpassen aan moeilijke situaties

!!! theoretisch model hierbij = Resiliency Model of Family Stress, Adjustment and Adaptation: onderzoekt hoe gezinnen omgaan met stress & welke factoren herstel bevorderen

### **Beschermende factoren en herstel factoren**

Het artikel maakt onderscheid tussen:

#### Beschermende factoren

= beschermen gezinnen tegen de negatieve impact v stress

Voorbeelden:

- Open communicatie
- Goede fysieke gezondheid
- Steunende sociale netwerken
- Culturele of religieuze rituelen
- Harmonie binnen het gezin

#### Herstelfactoren

= helpen gezinnen om opnieuw goed te functioneren na een crisis

Voorbeelden:

- Hoop behouden
- Spiritualiteit
- Betekenis geven aan het verlies
- Samen proberen aanpakken

### **Sociale steun als belangrijke factor**

Sociale steun blijkt één van de belangrijkste bronnen v veerkracht te zijn

Er wordt onderscheid gemaakt tss:

- Formele steun = hulpverleners, organisaties, therapie, zelfhulpgroepen
- Informele steun = vrienden, familie, burens, collega's

Ook steun van lotgenoten is belangrijk, omdat zij de ervaring beter begrijpen

### **Onderzoeksmethode**

= onderzoek werd uitgevoerd bij 89 Belgische gezinnen die tss 3 en 6 jaar eerder een kind verloren hadden

De onderzoekers onderzochten onder andere:

- Gezinsveerkracht
- Copingstrategieën
- Sociale steun
- Gevoel v samenhang binnen het gezin

## **Belangrijkste resultaten**

### Gezinssterkte en verbondenheid

Een sterke verbondenheid binnen het gezin bleek cruciaal:

- Elkaar steunen
- Wederzijds vertrouwen
- Samenwerken
- Goede communicatie

72% vd ouders noemde communicatie als belangrijkste hulpbron

### Crisis zien als uitdaging

Gezinnen die de moeilijke situatie probeerden te zien als iets waar ze samen doorheen konden groeien, pasten zich beter aan = niet de crisis ontkennen, maar proberen betekenis te geven ah verlies

### Sociale steun

Zowel ouders als broers/zussen benadrukten het belang van sociale steun

Belangrijkste steunbronnen: vrienden, familie, lotgenoten, collega's, burens, professionele hulpverleners

### Copingstrategieën

Effectieve copingstrategieën waren onder andere:

- Praten over gevoelens
- Spiritualiteit of religie gebruiken
- Betekenis geven aan de situaties
- Lotgenotencontact
- Steun zoeken bij anderen

Ouders hechtten meer belang ah "herdefiniëren" vd situatie, terwijl broers/zussen vaker belang hechtten aan religieuze of spirituele steun

## **Spiritualiteit en betekenisgeving**

Veel gezinnen vonden steun in spiritualiteit:

- ➔ Geloof in God, kerkgang, bezoeken van het graf, muziek, natuur, rituelen

## **Wat helpt gezinnen volgens de ouders zelf?**

De ouders noemden vooral:

- Steun van partner & gezin
- Steun v vrienden & familie
- Communicatie
- Steun v lotgenoten
- Aanwezigheid van andere kinderen
- Professionele hulp
- Herinneringen aan het overleden kind bewaren
- Religie/spiritualiteit
- Positief proberen blijven

Sommigen vonden ook hulp in literatuur over rouw, hobby's, werk, het opschrijven v gevoelens

## 5. Groeiende veerkracht tijdens de perinatale levensfase

Perinatale periode (of peripartum) = tijd vanaf verlangen om zwanger te worden tot een jaar na bevalling

- ➔ Brengt veel lichamelijke & psychologische veranderingen mee
- ➔ Ambivalente gevoelens = mix v vreugde, blijdschap, hoop, angst, onzekerheid, kwetsbaarheid & moeilijke gevoelens

Jong ouderschap als kwetsbare transitieperiode:

- Nieuwe fase: nieuwe ontwikkelingsfase
- Nieuwe gerichtheid
- Transitieproces
- Matrescentie (voor moeders) & patrescentie (voor vaders): vergelijkbaar met adolescentie
- Zoektocht nr identiteit

Overgang nr ouderschap vraagt veel mentaal werk & bestaat uit 3 onderdelen:

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beeldvorming & verwachtingen | Ouders vormen een beeld vd baby & verwachtingen over de zwangerschap, bevalling & kraamperiode -> kan kraamperiode beïnvloeden |
| Aanpassingsvermogen          | Ouders die zich moelijk kunnen aanpassen, hebben meer kans op psychische problemen                                             |
| Engagement of betrokkenheid  | Ouders moeten zich engageren om echt 'ouder' te worden, moeilijkheden hierbij kunne transitie bemoeilijken                     |

Complexe overgang & veel aanpassingen:

- Minder vrijheid
- Andere manier v werken aan carrière
- Veranderingen in relaties
- Nieuw lichaamsbeeld

!!! Vroeger deelden grotere gezinnen de zorg & hadden mannen/vrouwen een realistischer beeld vd hoogte- en dieptepunten vd bevalling/kraamtijd. Tegenwoordig staan (aanstaande) ouders verder af v deze ervaringen, waardoor ze moeilijker kunnen inschatten wat normale veranderingen zijn in deze intense levensfase

Protectieve factoren & effectieve coping perinatale periode:

- Zwanger willen worden
  - Lichaam/genen
  - Zorg voor gezondheid moeder & vader
  - Ondersteuning v kwetsbare groepen
- Prenataal
  - Screening op biopsychosociale risicofactoren
  - Kraamzorg
- Geboorte
  - Bevraging moeder nr wensen
- Postnataal
  - Kangoeroezorg
  - Borstvoeding
  - Kraamzorg

## 6. De eerste 1000 dagen

### Belang vd eerste 1000 dagen

= eerste 1000 dagen ve kind lopen vd bevruchting tot tweede verjaardag

- ➔ Tijdens deze fase ontw vooral de organen & hersenen zich zeer snel, daardoor is het lichaam ook extra kwetsbaar voor negatieve invloeden
- ➔ Een goede ontwikkeling in deze periode heeft voordelen voor de rest vh leven: problemen of tekorten kunnen later soms nog ingehaald worden, maar dat verloopt vaak moeilijker

De eerste 1000 dagen hebben invloed op:

- Lichamelijke gezondheid
- Cognitieve ontwikkeling
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Schoolloopbaan
- Arbeid & maatschappelijke participatie

Ook aandoeningen zoals:

- Obesitas
- Diabetes
- Depressie
- Longziekten
- ➔ Vinden vaak gedeeltelijk hun oorsprong ih vroege leven

### Risicofactoren tijdens de eerste 1000 dagen

- Stress
- Roken
- Alcohol- en drugsgebruik
- Huishoudelijk geweld
- Verwaarlozing of kindermisbruik
- Slechte huisvesting
- Sociale isolatie
- Psychische problemen
- Cc met schadelijke stoffen
- Tekort aan voedingsstoffen

### Sociale ongelijkheid en gezondheid

- ➔ Gezondheidsongelijkheid begint vaak al vóór de geboorte
- ➔ Socio-economische situatie v ouders beïnvloedt zowel gezondheid vd moeder als die vh kind

Mensen met een lagere SES hebben vaker te maken met:

- Premature geboortes
- Laag geboortegewicht
- Roken tijdens zwangerschap
- Overgewicht bij kinderen
- Slechtere perinatale gezondheid

Onderliggende factoren zijn onder andere: stress, angst, depressie, armoede, discriminatie & beperkte toegang tot gezondheidszorg

### Veerkracht

- ➔ Risicofactoren leiden niet automatisch tot negatieve gevolgen: beschermende factoren kunnen ervoor zorgen dat kinderen & gezinnen zich toch positief ontw = veerkracht

Belangrijk hierbij:

- Veerkracht is geen vaste persoonlijkheidseigenschap
  - Het is een dynamisch proces
  - Het kan versterkt worden door steun & beschermende omgevingsfactoren
- ➔ Psychologische veerkracht verwijst naar hoe mensen omgaan met stress via copingmechanismen, goede ondersteuning kan ervoor zorgen dat gezinnen beter met moeilijke situaties omgaan

### Ondersteuning van gezinnen

Tijdens deze periode zijn er bovendien veel contacten met professionals zoals:

- Vroedvrouwen
- Verpleegkundigen
- Artsen
- Hulpverleners

Daardoor vormen de eerste 1000 dagen een belangrijke kans om:

- ➔ Problemen vroeg te detecteren
- ➔ Kwetsbaarheden op te merken
- ➔ Gezinnen tijdig te ondersteunen

### Vroeg investeren loont

Investeren in kwalitatieve zorg en ondersteuning tijdens eerste 1000 dagen heeft een groot maatschappelijk rendement

- ➔ Volgens econoom Heckman leveren investeringen in vroege ontwikkeling meer op dan op latere leeftijd

Vroege ondersteuning (preventieve zorg) kan:

- Gezondheidsproblemen voorkomen
- Kansenongelijkheid verkleinen
- Latere dure zorg verminderen
- Bijdragen aan gezondere samenleving

### Visie van Agentschap Opgroeien

= ondersteunt gezinnen zowel individueel als structureel:

- ➔ Kind en Gezin, kinderopvang, Groeipakket
- ➔ Het agentschap werkt samen met wetenschappers, praktijkwerkers & beleidsmakers om correcte & genuanceerde informatie te verspreiden
- ➔ Het agentschap benadrukt dat communicatie over opvoeding & ouderschap zorgvuldig en genuanceerd moet gebeuren

Het concept van de eerste 1000 dagen is bedoeld om het belang van goede start te benadrukken, en niet om extra druk op ouders te leggen

Daarnaast maakt Opgroeien onderscheid tss:

- Eerste 1000 dagen = focus op het belang van veilige & gezonde start vanaf zwangerschap
- Infant Mental Health (IMH) = bredere zorg voor de psychosociale gezondheid van kinderen tot 5j



## Parent Infant Mental Health (PIMH)

= benadering met helder licht op de perinatale mentale gezondheid waarbij welzijn (aanstaande) ouders als kind centraal staan

- ➔ Streven nr gezonde mentale balans = stevige basis voor hun emotionele welzijn & onderlinge interacties, wat weer v invloed is op welzijn vh kind & directe omgeving
- ➔ Ontw baby hangt af v diverse factoren: kwaliteit relatie met verzorgers, mentale gezondheid vd ouders, gezinsdynamiek & zelfs bredere maatschappelijke context
- ➔ Eerste levensjaren = fundament voor verdere ontw kind
- ➔ Cruciaal = verzorgers zijn responsief & consistent

## 7. Verband tussen sociaal emotionele gezondheid van kinderen & stress, zorgen of spanningen in het gezin (artikel)

### Inleiding

Kinderen die opgroeien in gezinnen met veel stress, zorgen of spanningen hebben een groter risico op sociaal-emotionele problemen. Dit werd onderzocht bij 4.406 tienjarige kinderen in Amsterdam.

Tijdens coronaperiode & andere maatschappelijke crisissen (zoals wooncrisis, energiecrisis & inflatie) nam stress bij gezinnen sterk toe. Stress binnen het gezin wordt daarom gezien als een belangrijke risicofactor voor mentale gezondheid v kinderen

Sociaal-emotionele problemen kunnen leiden tot:

- Slechtere schoolprestaties
- Moeilijkheden ih dagelijks functioneren
- Mentale problemen op latere leeftijd

### Onderzoek

Voor het onderzoek vulden ouders v tienjarige kinderen vragenlijsten in tijdens een preventief gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De sociaal-emotionele gezondheid v kinderen werd gemeten met de SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) & meet onder andere:

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| - Emotionele problemen | - Problemen met leeftijdsgenoten |
| - Gedragsproblemen     | - Prosociaal gedrag              |
| - Hyperactiviteit      |                                  |

Daarnaast werd aan ouders gevraagd of er stress was ih gezin, bv door:

- ➔ Werk, relatieproblemen, geldproblemen, huisvesting, opvoeding & andere zorgen

### Belangrijkste resultaten

#### Verband tussen stress en problemen bij kinderen

Uit het onderzoek bleek een sterk verband tss gezinsstress en sociaal-emotionele problemen bij kinderen

- ➔ 17% vd gezinnen rapporteerde stress

- ➔ 15,1% vd kinderen had een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen

Bij gezinnen mét stress had:

- ➔ 31% vd kinderen problemen

Bij gezinnen zonder stress was dit:

- ➔ 11,5%

= kinderen uit gezinnen met stress hadden dus bijna 3 keer vaker sociaal-emotionele problemen, zelfs na correctie voor achtergrondfactoren bleef het risico veel hoger (RR = 2,63)

#### Welke kinderen hadden vaker problemen?

Sociaal-emotionele problemen kwamen vaker voor bij:

- Jongens
- Kinderen die niet bij beide ouders wonen
- Kinderen met een niet-westerse herkomst
- Kinderen uit buurten met een lage socio-economische status (SES)

Ook stress in gezin kwam vaker voor bij:

- Eenoudergezinnen
- Gezinnen met andere westerse herkomst

#### **Soorten stress**

- ➔ Stress over werk, geld, wonen, relaties & opvoeding kwamen ongeveer even vaak voor
- ➔ Opvoedstress had de sterkste impact
- ➔ Kinderen uit gezinnen met opvoedstress hadden gemiddeld de hoogste probleemscores.

Daarnaast bleek:

- ➔ Hoe meer stressfactoren in gezin aanwezig waren, hoe ernstiger problemen bij het kind werden
- ➔ Er was dus sprake van een cumulatief effect van stress

#### **Beschouwing van de auteurs**

De auteurs benadrukken dat stress binnen het gezin een grote invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen

Ze vermoeden een wederkerige relatie:

- Stress bij ouders kan problemen bij kinderen veroorzaken
- Problemen bij kinderen kunnen op hun beurt opnieuw stress bij ouders verhogen
- ➔ Hierdoor kan een negatieve vicieuze cirkel ontstaan

Volgens de onderzoekers spelen ook maatschappelijke factoren een rol, zoals:

- Wooncrisis      - Prestatiedruk
- Energiecrisis    - Financiële problemen

Deze factoren kunnen de stress in gezinnen verder versterken

## Rol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ heeft een belangrijke taak in het vroeg opsporen van problemen bij kinderen, professionals moeten:

- Stress binnen gezinnen systematisch bevragen
- Stress meenemen in risicotaxatie
- Hierover in gesprek gaan met ouders
- Gezinnen tijdig ondersteunen

## Conclusie

- ➔ Onderzoek toont duidelijk aan dat stress in gezin sterk samenhangt met sociaal-emotionele problemen bij kinderen
- ➔ Hoe meer stress in gezin, hoe groter het risico op problemen bij het kind
- ➔ Belangrijk dat hulpverleners aandacht hebben voor gezinsstress & gezinnen vroeg ondersteunen, vooral in tijden van maatschappelijke crisissen

## 8. Familierflex

= visie binnen de GGZ waarbij familie & naasten actief betrokken worden bij de zorg en herstelproces van een zorggebruiker

- ➔ Uitgangspunt = familie kan pas echt van betekenis zijn wanneer hulpverleners & zorgorganisaties hen zien als een gelijkwaardige partner in de zorg

Samenwerking gebeurt binnen een triade:

- Zorggebruiker
- Familie of belangrijke naasten
- Hulpverlener

De Familierflex wil hulpverleners stimuleren om familie:

- Vriendelijk te onthalen
- Ondersteuning aan te bieden
- Informatie te geven
- Actief te betrekken bij het zorgproces

Familie is vaak een blijvende factor in het leven van cliënt, terwijl professionele hulp meestal tijdelijk is

## Basis van de Familierflex

= gebaseerd op een multidisciplinaire richtlijn rond betrekken van naasten in de GGZ

- ➔ Deze richtlijn werd ontwikkeld door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin & bevat aanbevelingen voor:
  - Hulpverleners
  - Zorgorganisaties
  - Beleidsmakers

Doel = kwaliteitsvolle & meer herstelgerichte hulpverlening creëren

## Aanbevelingen voor hulpverleners

### Basishouding van hulpverleners

Hulpverleners moeten leren samenwerken met familieleden & naasten:

- Familie onthalen en respectvol behandelen
- Informatie geven
- Ondersteuning bieden
- Kinderen & jongeren actief betrekken
- Samenwerken met naasten tijdens het hulpverleningstraject

#### Specifieke situaties

De richtlijn geeft ook aanbevelingen voor moeilijke of bijzondere situaties, zoals:

- Crisissituaties
- Verstoorde relaties tss cliënt & familie
- Suïcidale gedachten of gedrag
- Residentiële opname
- Doorverwijzing of afronding v zorg

Hierbij wordt benadrukt dat familie ook in complexe situaties betrokken moet blijven waar mogelijk

#### Juridische kwesties

- ➔ Wanneer een zorggebruiker beslissingsonbekwaam is
- ➔ Uitzonderingen op informatie delen
- ➔ Situaties waarin de naaste zelf ook zorg nodig heeft

Hierdoor krijgen hulpverleners meer duidelijkheid over hoe ze correct met familie kunnen samenwerken

#### **Aanbevelingen voor zorgorganisaties**

Niet alleen individuele hulpverleners, maar ook organisaties moeten familievriendelijk werken.

Belangrijke aanbevelingen zijn:

- Een duidelijk familiebeleid uitwerken
- Infrastructuur familievriendelijk maken
- Verantwoordelijkheden delen binnen teams
- Ondersteuning aanbieden aan naasten
- Hulpverleners opleiden & trainen
- Het beleid evalueren & bijsturen
- Praktische hulpmiddelen voorzien

De Familiereflex vraagt dus ook een cultuurverandering binnen organisaties

#### **Betekenis voor naasten en familie**

Veel familieleden willen betrokken worden bij het herstelproces, maar voelen zich soms buitengesloten of botsen op terughoudendheid v hulpverleners —> Familiereflex wil men dit veranderen:

- Meer erkenning
- Meer inspraak
- Meer ondersteuning
- Betere samenwerking met hulpverleners

Ook hun eigen welzijn krijgt aandacht, want familieleden ervaren vaak zelf veel stress of belasting

#### **Beperkingen van de richtlijn**

##### Sterke focus op residentiële zorg

- ➔ Wetenschappelijke literatuur waarop de richtlijn gebaseerd is, focust vooral op residentiële GGZ & daardoor herkennen ambulante of mobiele hulpverlening zich soms minder id aanbevelingen

### Algemene aanbevelingen

Omdat richtlijn bruikbaar moest zijn voor veel verschillende sectoren, blijven sommige aanbevelingen erg algemeen:

- Sommige doelgroepen krijgen weinig aandacht
- Concrete toepassingen ontbreken soms
- Specifieke vragen blijven onbeantwoord

### Weinig ruimte voor innovatieve methodes

- ➔ De richtlijn steunt sterk op wetenschappelijk bewijs & daardoor kregen nieuwe of innovatieve praktijken met minder onderzoek minder aandacht

### Beperkte aandacht voor bredere omgeving

- ➔ De richtlijn focust vooral op gezin, familie & vrienden —> andere belangrijke contexten zoals school, werk of buurt worden minder besproken

## **Randvoorwaarden voor goede implementatie**

### Genuanceerde toepassing

- ➔ Hulpverleners moeten rekening houden met wensen vd zorggebruiker, noden v familie & concrete context
- ➔ Beslissingen gebeuren best via shared decision-making (= samen beslissen)

### Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid

Familie mag n gezien worden als “extra hulp”, maar als gelijkwaardige partner met eigen kennis & ervaring

- ➔ Hulpverleners moeten luisteren nr familieleden omdat zij vaak goed weten wat helpt, wat niet helpt & hoe zorggebruiker functioneert buiten de hulpverlening

### Nood aan praktische hulpmiddelen

De richtlijn legt vooral uit wat moet gebeuren, maar minder hoe, drm zijn extra hulpmiddelen nodig zoals:

- Praktische stappenplannen
- Vormingen
- Voorbeelden uit praktijk

### Nood aan een sterk implementatietraject

Alleen een richtlijn publiceren is niet voldoende, er zijn bijkomende acties nodig zoals:

- Opleidingen
- Websites & hulpmiddelen
- Coaching
- Kwaliteitsindicatoren
- Informatiecampagnes

Doel = familiebetrokkenheid een automatische reflex maken

### Nood aan tijd, middelen en capaciteit

Goede samenwerking met familie vraagt tijd & personeel

- ➔ Door lange wachtlijsten & hoge werkdruk is dit vandaag moeilijk in veel GGZ-voorzieningen, zonder extra middelen wordt implementatie moeilijk

#### Evaluatie en opvolging

De richtlijn moet regelmatig geëvalueerd worden, men wil nagaan:

- Of hulpverleners de richtlijn gebruiken
- Of familie zich beter ondersteund voelt
- Of de kwaliteit van zorg verbetert

## **9. Grootouder worden/zijn**

### **Grootouder worden = belangrijke levensfase**

De geboorte van een eerste kleinkind is een grote mijlpaal & grootouders ervaren veel:

- Trots
- Emotionele verbondenheid
- Enthousiasme
- Onzekerheid & vragen over hun rol

Ze moeten zoeken naar een evenwicht tss betrokken zijn maar zich niet opdringen

### **Wie nam deel aan het onderzoek?**

- Relatief jonge grootouders
- Vaker vrouwen dan mannen
- Vaak nog werkend
- Vaak hoger opgeleid
- Meestal in goede gezondheid

Veel grootouders combineren dus nog verschillende rollen:

- Werken
- Zorg voor eigen ouders
- Mantelzorg
- Ondersteuning v kinderen & kleinkinderen
- Hobby's

### **Contact met kleinkinderen**

De meeste grootouders wonen dicht bij hun kleinkind en zien het kind regelmatig. Vaak is er minstens wekelijks cc. Toch wil ongeveer 1 op 5 hun kleinkind vaker zien.

Factoren die contact moeilijker maken:

- ➔ Afstand, werk, gezondheidsproblemen, drukke agenda's v ouders & grootouders

Belangrijk verband:

- ➔ Hoe minder cc grootouders hebben met hun kleinkind, hoe vaker ze aangeven dat ze méér cc willen

### **Opvang en oppas**

Grootouders spelen een belangrijke rol id opvang v jonge kinderen & vaak combineren ouders:

- Professionele opvang
- Opvang door grootouders

Er zijn duidelijke verschillen afh van:

- Werkstatus
- Afstand
- Gezondheid
- Persoonlijke voorkeur

➔ Werkende grootouders kunnen meestal minder structureel helpen, gepensioneerde grootouders nemen vaker vaste opvang op

### **Opvang bij ziekte of noodsituaties**

Grootouders zijn vaak de “back-up” wanneer:

- Het kind ziek is
- De crèche sluit
- Ouders onverwacht hulp nodig hebben

Veel grootouders vinden dit vanzelfsprekend, maar sommigen voelen zich hierdoor ook belast.

### **Afspraken tussen ouders en grootouders**

- ➔ De meeste gezinnen maken vooraf afspraken over: opvang, oppasdagen, noodsituaties, taakverdeling tss beide grootouderparen
- ➔ Goede communicatie voorkomt spanningen
- ➔ Belangrijk inzicht: ook wnr afspraken bestaan, kunnen verborgen verwachtingen toch voor frustraties zorgen

### **Grootouders zoeken evenwicht**

Veel grootouders willen helpen, maar tegelijk ook hun vrijheid behouden

- ➔ Ze willen betrokken zijn & een goede band opbouwen, maar niet volledig verantwoordelijk worden voor de opvoeding
- ➔ Sommigen spreken over “overbevraging” (vooral combinatie v werk, mantelzorg & opvang kan zwaar zijn)

### **Opvoeding**

De meeste grootouders praten af en toe met hun kinderen over opvoeding:

- ➔ Ze geven vooral advies over slapen, eten, ziek zijn, dagelijkse verzorging
- ➔ Toch vinden veel grootouders dat de ouders uiteindelijk zelf moeten opvoeden
- ➔ Proberen meestal opvoedingsstijl v hun kinderen te respecteren, ook al denken ze soms anders

### **Verschillen tussen vroeger en nu**

Veel grootouders vinden dat opvoeden vandaag moeilijker is dan vroeger

- Meer druk op gezinnen
  - Opvangproblemen
  - Combinatie werk-gezin
  - Drukke maatschappij
- ➔ Daarnaast moeten grootouders vandaag langer werken dan vroegere generaties, waardoor opvang moeilijker wordt

## Grootouders voelen maatschappelijke druk

Een belangrijk thema uit de focusgroepen = druk vanuit de maatschappij

Veel grootouders voelen zich “tussen generaties in”:

- Zorgen voor ouders
- Ondersteunen kleinkinderen
- Helpen kinderen
- Zelf blijven werken
- Tijdsdruk & overbelasting

## Relaties binnen families

- ➔ De relatie met zoon of dochter, schoonkind & andere grootouders heeft grote invloed op hoe het grootouderschap ervaren wordt
- ➔ Bij goede communicatie verloopt samenwerking meestal vlotter
- ➔ Complexe gezinssituaties kunnen relatie met kleinkind moeilijker maken

## Afstand en betrokkenheid

Een terugkerend thema: grootouders willen betrokken zijn, maar ook voldoende afstand bewaren

Veel grootouders zeggen dat ze genieten van grootouderschap omdat zij:

- Meer kunnen genieten
- Minder opvoedingsverantwoordelijkheid dragen
- Meer kwaliteitsvolle tijd hebben met het kind

## 10. Pleegzorg & adoptie

### Pleegzorg

- ➔ 40% aanvragen vindt een plaats
- ➔ Ondersteunende pleegzorg
- ➔ Crisispleegzorg (binnen 48u)
  - 7/7 (eigen vraag/jeugdrechter)
  - Optie 1: crisis gaat liggen
  - Optie 2: Perspectiefzoekende pleegzorg
- Perspectief-biedende pleegzorg
- Samenwerking biologische ouder & pleegezin
- Bijkomende soorten pleegzorg:
  - Pleegzorg voor volwassenen
  - Geef de wereld een (t)huis

| Risicofactoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beschermende factoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Uitstellen van beslissing of het pleegkind al dan niet teruggeplaatst wordt bij de ouders</li><li>• Voortijdige beëindiging van plaatsing en/of een overplaatsing van pleegkind</li><li>• Conflicten tussen ouders &amp; pleegouders</li><li>• Pleegouders die veel belasting ervaren bij het opvoeden van pleegkind</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Snelle beslissing of het pleegkind al dan niet teruggeplaatst wordt bij de ouders</li><li>• Een stabiele plaatsing</li><li>• Ouders die de plaatsing verdragen &amp; langzaam accepteren</li><li>• Goede samenwerking tussen ouders &amp; pleegouders</li><li>• Pleegouders met autoritatieve opvoedingsstijl</li></ul> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negatieve opvoedingsstrategieën v pleegouders die kunnen leiden tot een toename v probleemgedrag bij het pleegkind</li> <li>• Mishandeling en/of misbruik vh pleegkind in het pleeggezin</li> <li>• Ziekte v (één v) de ouder(s) of andere problemen waardoor het met een of beide ouders niet goed gaat</li> <li>• Onveilige hechtingsrelatie tss pleegkind &amp; de pleegouders</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pleegouders die goed grenzen kunnen stellen</li> <li>• Pleegouders die veel steun krijgen uit hun sociale omgeving bij het opvoeden vh pleegkind</li> <li>• Veilige hechtingsrelatie tss pleegkind &amp; pleegouders</li> <li>• Veiligheid binnen het pleeggezin</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Adoptiegezin

Adoptie van een gekend kind (bijv. kind van je partner, van familie of een pleegkind)

- ➔ Zonder bemiddeling v erkende adoptiedienst
- ➔ Voorwaarden: gehuwd, wettelijk samenwonend, min 3j feitelijk samenwonend of alleenstaande)
- ➔ Voorbereiding: programma doorlopen, geschikt-verklaring door familierechter
- ➔ Voorwaarden leeftijd: min 25j bij minderjarige & min 15j ouder dan het kind
- ➔ Gesprek met ouders die het kind afstaan, maatschappelijk onderzoek, etc.

Adoptie van een ongekend kind

- ➔ Je weet niet welk kind je zal adopteren
- ➔ Het kind wordt aan jou toegewezen door een adoptiedienst

Adoptie nieuws interlandelijke adoptie

- ➔ De Vlaamse regering heeft besloten om de interlandelijke adoptie definitief stop te zetten. Dit is een beslissing die is genomen op basis van een brede consensus binnen het Vlaams Parlement.
- ➔ De regering heeft als doel om de veiligheid en het welzijn van kinderen te waarborgen,
- ➔ De nieuwe regelgeving gaat in 2027 van start
- ➔ Tussentijd: overgangsfase of uitdoofscenario

Wensouders overwegen juridische stappen tegen adoptiestop: "Onze kinderwens spat op de valreep uiteen" | VRT NWS Nieuws

- ➔ Na beslissing v minister v welzijn stopt interlandelijke adoptie tegen 2027 & komt er in tussentijd een uitdoofscenario
- ➔ Alleen dossiers met concrete match & geldig geschiktheidsattest kunnen nog worden afgerond: tientallen andere trajecten worden stopgezet
- ➔ Kandidaat-adoptieouders reageren verontwaardigd & wijzen op jarenlange procedures die nu abrupt eindigen
- ➔ Enkele wensouders overwegen juridische stappen, onder meer bij Raad van State

## 11. Scheiding

| Risicofactoren                                                                                                                                                                                                                                                 | Beschermende factoren                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huiselijk geweld en kindermishandeling</li> <li>• Ernstige negatieve interacties tss ouders</li> <li>• Psychologische oorlogsvoering tss ouders</li> <li>• Ernstige &amp; langdurige ouderlijke conflicten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Humor vd ouders</li> <li>• Onderlinge genegenheid</li> <li>• Interesse voor de jongere</li> <li>• Positieve onderlinge communicatie</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een instabiele inwonende ouder of ouders</li> <li>• Een slechte band met de inwonende ouder</li> <li>• Het aantal bijkomende veranderingen zoals verhuizing, nieuwe partners, ...</li> <li>• Financiële problemen (ih algemeen achteruitgang in sociaaleconomische status (SES), in het bijzonder als er sprake is v armoede)</li> <li>• Een slechte band met de uitwonende ouder</li> <li>• Een slechte band met de plusouder</li> <li>• Mensen uit het netwerk van beide ouders die de strijd in negatieve zin beïnvloeden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goede band met inwonende ouder</li> <li>• Band met uitwonende ouder (ondersteunende relatie met beide ouders)</li> <li>• Regelmatig contact tss kind &amp; ouder</li> <li>• Er is nog te weinig onderzoek over wrm sommige jongeren beter met scheiding kunnen omgaan dan andere jongeren (link met veerkracht wordt wel benoemd, maar niet bewezen)</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kinderen moeten een goede uitleg krijgen en hebben het volgende nodig:

- Ruimte om te voelen & te praten met ouders of anderen
- Tijd krijgen om te rouwen
- Ouders lossen conflicten op
- Gezien worden in krachten & talenten
- Gehoord worden in behoeften
- Structuur blijft behouden

Wat scheiding doet met ouders:

- Er gaat vaak een heel proces vooraf ad beslissing v tijfel
  - Info & een klankbord
- Voelen zich vaak schuldig & tekortschieten
  - Niet veroordelende luisteraar
- Voelen zelf ook verdriet omwille vh verlies
  - Een luisteraar die stilstaat bij beleving & noden



## Hoorcollege 3: relaties

### 1. Vriendschappen

#### Algemene kenmerken van vriendschap

Vriendschappen zijn vrijwillige relaties: mensen kiezen zelf hun vrienden, in tegenstelling tot familie of collega's MAAR toch zijn ze niet vrijblijvend

Belangrijke kenmerken van vriendschap:

- Wederzijds vertrouwen
- Samen plezier maken
- Zelfonthulling & kwetsbaarheid
- Op elkaar kunnen steunen
- Sociale steun

Vrienden verwachten dat persoonlijke info vertrouwelijk blijft & dat de ander steun biedt wnr nodig

#### Vriendschappen doorheen de levensloop

##### Vroege kindertijd (2-6 jaar)

Kinderen beginnen te begrijpen wat een vriend is

➔ Een vriend is iemand: met wie je speelt, die je leuk vindt & met wie je speelgoed deelt

Kenmerken:

- Vriendschappen wisselen snel
- Toch vaak redelijk stabiele relaties
- Nog weinig stabiel vertrouwen

Kinderen behandelen vrienden positiever dan andere kinderen:

➔ Meer complimenten, meer samenwerking & intensere begroetingen

Belangrijk inzicht:

➔ Wederkerige vriendschappen vormen veilige basis om later nieuwe vriendschappen te ontw

##### Lagere schoolleeftijd

Vriendschappen worden dieper & psychologisch: niet enkel "samen spelen" is belangrijk, maar ook:

➔ Vertrouwen, persoonlijke kwaliteiten & wederzijdse steun

Vertrouwen = belangrijkste kenmerk, vertrouwensbreuk (roddelen, belofte breken, niet helpen) kan grote impact hebben

Evolutie:

- Kleuters → veel "vriendjes"
- Lagere school → kleiner aantal echte vrienden

Kinderen kiezen meestal vrienden die op hen lijken qua:

- Leeftijd
- Sociale achtergrond

- Geslacht
- Gedrag & schoolprestaties
- Etniciteit

Omgeving beïnvloedt dit sterk:

- ➔ Multiculturele klas → meer multiculturele vriendschappen

Veilig gehechte kinderen leren:

- ➔ Empathie, conflicten oplossen & relaties onderhouden

Negatieve kant = agressief gedrag kan versterkt worden binnen vriendschappen

#### Adolescentie (11–18 jaar)

- ➔ Het aantal beste vrienden daalt naar ongeveer 4–6

Belangrijke kenmerken v adolescentievriendschappen:

- Intimiteit
- Loyaliteit
- Wederzijds begrip

Vrienden lijken vaak op elkaar qua:

- Identiteit
- Politieke overtuigingen
- Studiekeuze
- Experimenteergedrag

Meer autonomie:

- ➔ Adolescenten zijn minder bezitterig tegenover vrienden omdat ze elkaars nood aan autonomie begrijpen

Hechte vriendschappen kunnen ook risico's hebben:

- Co-ruminatie
- Samen piekeren & negatieve gevoelens versterken
- Relationale agressie
- Persoonlijke info gebruiken om elkaar te kwetsen

Belangrijk artikel over adolescentievriendschappen:

- ➔ Artikel onderzocht hoe: hechte vriendschappen, sociale acceptatie & populariteit/likeability tijdens adolescentie samenhangen met welzijn op volwassen leeftijd

Belangrijkste conclusie van het artikel:

#### *Vroege adolescentie*

Brede sociale acceptatie ("ik hoor erbij") voorspelt later:

- Minder sociale angst
- Beter fysieke gezondheid
- Minder agressie
- Meer jobtevredenheid

#### *Late adolescentie*

Hechte kwaliteitsvolle vriendschappen voorspellen later:

- Beter romantische relaties
- Minder relationele onzekerheid

- Meer jobtevredenheid

Belangrijk inzicht:

- ➔ In vroege adolescentie is erbij horen belangrijker
- ➔ In late adolescentie worden intieme vriendschappen belangrijker

Het onderzoek toont dus dat verschillende soorten vriendschappen op verschillende leeftijden belangrijk zijn voor het latere welzijn

#### Vroege volwassenheid (18–40 jaar)

- ➔ Vrienden lijken vaak op elkaar qua: leeftijd, geslacht & sociaaleconomische status
- ➔ Vriendschappen ondersteunen: zelfwaarde, mentaal welzijn, autonomie & stressverwerking

Belangrijk blijven: vertrouwen, intimiteit, gedeelde interesses & plezier

#### Middelbare leeftijd (40–65 jaar)

- Vriendschappen worden selectiever
- Minder investeren in oppervlakkige relaties & beschermen waardevolle vriendschappen sterker
- Aantal dichte vrienden neemt af richting late volwassenheid

#### Late volwassenheid (65+)

Door minder werkverplichtingen stijgt het belang van vriendschappen opnieuw

- ➔ Vriendschappen voorspellen positieve emoties & levenstevredenheid

Ouderen verkiezen:

- Oude, vertrouwde vriendschappen boven nieuwe contacten
- Vrienden wonen vaker dichtbij
- Door overlijden van leeftijdsgenoten ontstaan vaker intergenerationele vriendschappen.

### **Evolutie van vriendschap**

Vriendschappen verlopen meestal in 3 fasen:

- Ontstaan
- Onderhouden
- Beëindigen

Hoeveel vrienden hebben mensen?

- ➔ Onderzoek van de Universiteit Utrecht toont dat:  
→ 70% vd vriendschapsnetwerken zich om de 7 jaar vernieuwt

Dat betekent niet dat oude vrienden verdwijnen, maar wel dat hun functie verandert

- ➔ Bijvoorbeeld: vroegere hartsvriend → later vooral uitgaansvriend

## Kernzaken om te onthouden voor examen

- Vriendschap = vrijwillig maar niet vrijblijvend
- Vertrouwen en sociale steun zijn centraal
- Vriendschappen worden met de leeftijd selectiever en intiemer
- Kinderen kiezen vaak gelijkaardige vrienden
- Adolescentievriendschappen draaien sterk rond intimiteit en loyaliteit
- Hechte vriendschappen kunnen zowel positief als negatief zijn (co-ruminatie)
- Vroege adolescentie → sociale acceptatie belangrijk
- Late adolescentie → kwaliteitsvolle hechte vriendschappen belangrijk
- Vriendschappen beïnvloeden welzijn doorheen het hele leven

## 2. Siblings

### Wat maakt siblingrelaties uniek?

#### Langstdurende relatie

De siblingrelatie is vaak de langste relatie in iemands leven

- Vriendschappen of partnerrelaties kunnen eindigen
- De band tussen siblings blijft bestaan, zelfs bij weinig contact of emotionele afstand

#### Veel tijd samen

➔ Tijdens de kindertijd brengen siblings meestal meer tijd met elkaar door dan met wie ook

#### Delen van middelen en aandacht

- ➔ Siblings moeten: speelgoed, ruimte & aandacht v ouders delen
- ➔ Dit kan zowel verbondenheid als conflicten veroorzaken

#### Belangrijke ontwikkelingscontext

➔ De siblingrelatie helpt bij de sociale, emotionele & cognitieve ontwikkeling

Omdat siblings ongeveer gelijkwaardig zijn, kunnen kinderen hier oefenen met:

- Sociale vaardigheden
- Samenwerking
- Conflicthantering
- Empathie

De siblingrelatie vormt dus een belangrijke sociale leeromgeving.

### Ambivalente relatie

= siblingrelatie heeft zowel positieve als negatieve kanten

- Positieve aspecten: vriend, vertrouwenspersoon, bondgenoot, steunfiguur
- Negatieve aspecten: jaloezie, ruzie, vijandigheid, agressie

Dus: warmte en conflict kunnen tegelijk aanwezig zijn binnen dezelfde relatie

## Factoren die samenhangen met minder gunstige siblingrelaties

### Geslacht

- Jongens vaker betrokken zijn bij siblinggeweld
- Jongens vaker fysieke agressie gebruiken
- Meisjes vaker verbaal of psychologisch geweld gebruiken

### Leeftijd

Siblinggeweld komt vooral voor in kindertijd (tot ongeveer 10 jaar)

- Conflicten nemen meestal af naarmate siblings ouder worden

### Sociaaleconomische status (SES)

Siblinggeweld kan voorkomen in alle sociale klassen, maar gezinnen met lagere SES vertonen gem meer

- Mogelijke verklaring: meer stress, minder middelen & meer spanningen binnen het gezin

### Type siblingrelatie

Biologische siblings:

- ➔ Ervaren gemiddeld meer warmte & hechtere relaties
- ➔ Maar doordat ze meer contact hebben, ontstaat soms ook meer kans op conflicten

Half- en stiefsiblings:

- ➔ Ervaren gemiddeld minder warmte & meer conflict
- ➔ Mogelijke verklaringen:
  - Geen biologische verwantschap
  - Verschillen in normen & opvoeding
  - Stress in nieuw-samengestelde gezinnen
  - Conflicten rond geld, aandacht & middelen

## Onderzoek bij Vlaamse jongeren (JOP-monitor 2023)

Het Jeugdonderzoeksplatform onderzocht siblingrelaties bij Vlaamse jongeren van 12–18 jaar, van de 5463 jongeren hadden 3795 minstens één broer of zus

### Siblingwarmte

Werd onderzocht via:

- Complimenten geven/krijgen
- Luisteren
- Elkaar helpen

Resultaat: grote meerderheid vd jongeren:

- Krijgt regelmatig steun van siblings
- Geeft ook zelf steun aan siblings

### Siblingconflict

Werd onderzocht via:

- Fysieke agressie
- Verbale agressie



Resultaten:

- Ongeveer 1 op 5 jongeren heeft maandelijks of wekelijks conflict met een sibling
- Ongeveer 5% ervaart dagelijks fysieke of verbale agressie
- Ongeveer 3% pleegt dagelijks agressie tegenover een sibling

Belangrijk inzicht

- ➔ Siblingrelaties zijn vaak tegelijkertijd warm én conflictueus
- ➔ Een broer of zus kan tegelijk: een steunfiguur én een bron van stress of ruzie zijn

### 3. Partnerrelaties

- ➔ Monogaam: gehuwd, samenwonend, lat relatie
- ➔ Polygamie
- ➔ Polyamorie

Triangulatietheorie van Sternberg:



### 4. Discriminatie, racisme & seksisme

#### Discriminatie

= wnr personen of groepen zonder rechtvaardiging anders behandeld worden obv beschermde criteria

- ➔ Heeft een link met een beschermend criterium
- ➔ Vond plaats op een domein waarop de wetgeving v toepassing is
- ➔ Vond plaats in vorm v verboden gedrag
- ➔ Maakt een onderscheid dat niet gerechtvaardigd is

Oorzaken v discriminatie:

- Socialisatie
- Persoonlijke ervaring
- Representatie

## Racisme

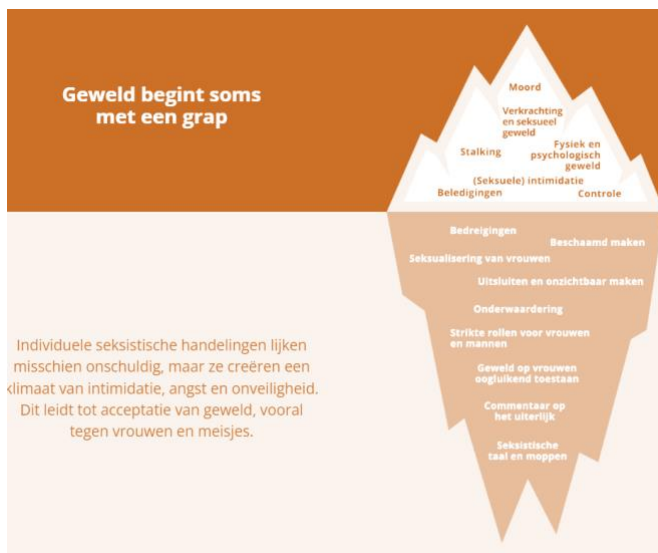
“Een systeem v dominantie, macht & privileges gebaseerd op raciale groepsaanduidingen waar leden vd dominante groep creëert of accepteert hun maatschappelijke privileges door structuren, ideologie, waarden & gedrag dat de bedoeling of het effect heeft om te vertrekken niet-dominante groepsleden relatief uitgesloten v macht, achting, status en/of gelijke toegang tot maatschappelijke middelen. ”

= structurele ongelijkheid, geen juridisch concept, antiracismewet verbiedt onderscheid obv:

- Zogenaamd ras
- Huidskleur
- Nationaliteit
- Afkomst
- Nationale/etnische afstamming

→ Micro agressie = micro aanval, belediging, invalidatie

## Seksisme



= gedrag waarbij iemand of een groep gediscrimineerd wordt obv geslacht

## 5. Gender (artikel: mental health (international journal of transgender health))

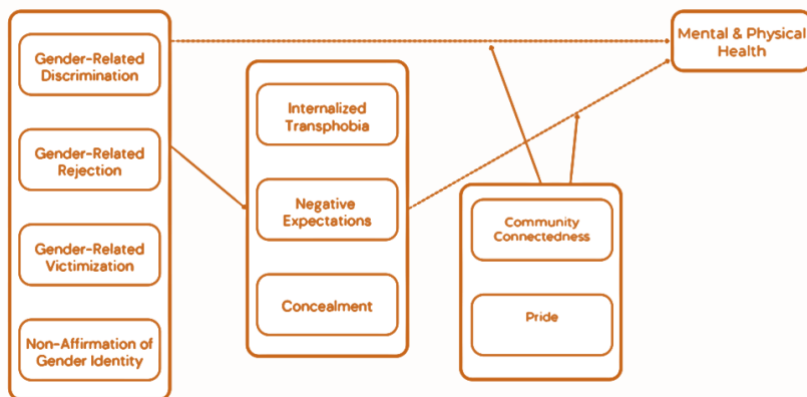
### Algemeen (powerpoint hoorcollege)

#### Gender

= “waar sekse (biologisch geslacht) gaat over natuur & iets zegt over lichamelijke verschillen, gaat gender over cultuur & zegt iets over onze maatschappelijke ideeën, normen & verwachtingen rond mannelijkheid & vrouwelijkheid”

## Transgender en genderdiverse individuen

### Het minderheidsstressmodel



Beschermende factoren tegenover minderheidsstress:

- 'Pride', 'community connectedness'
- Het begrijpen, accepteren & tevreden zijn met eigen genderidentiteit
- Je genderidentiteit in je eigen woorden kunnen omschrijven
- Het ervaren v emotionele stabiliteit, zelfvertrouwen & een gevoel v controle over eigen leven
- Steunend netwerk v vrienden/familie
- Positieve rolmodellen via (sociale)media

Negatieve coping:

- ➔ Jezelf isoleren, gevoelens v schaamte, angst voor negatieve reacties

Positieve coping:

- Gesprekken over lichaamsbeeld & genderidentiteit (& heteronormativiteit)
- Inzetten v beschermende factoren
- Mindfulness, meditatie, 'kleine gelukjes'
- Connectie ervaren dmv 'safe spaces'

### **Inleiding — begrijpen in eigen woorden**

Het hoofdstuk wil hulpverleners begeleiden in hoe ze transgender & genderdiverse personen correct ondersteunen op vlak van mentale gezondheid

!!! Niet elke transgender heeft psychotherapie of mentale hulp nodig, sommigen hebben enkel medische genderbevestigende zorg nodig, terwijl anderen wel ondersteuning kunnen gebruiken

= transgender zijn op zich is dus géén psychische aandoening

### Waarom komen mentale problemen vaker voor?

- ➔ TGD-persoon hebben vaker last v depressie, angst & suicidaliteit

Maar volgens het artikel komt dit vooral door externe factoren zoals:

- Discriminatie      - Sociale afwijzing
- Geweld             - Minority stress

- Stigma

### Rol van genderbevestigende zorg

Het artikel benadrukt dat:

- Genderbevestigende medische zorg
- Genderbevestigende chirurgie
- Sociale steun

de mentale gezondheid vaak verbeteren

- ➔ Psychische klachten verminderen vaak wnr mensen zich erkend en ondersteund voelen

### Visie op hulpverlening

Hulpverleners moeten:

- Luisteren zonder vooroordelen
- Autonomie respecteren
- Mensen helpen hun eigen pad te bepalen

= niet beslissen in plaats vd cliënt

- ➔ Belangrijk: niet alle transgender personen willen dezelfde zorg, sommigen willen chirurgie of hormonen, anderen niet

## **Statements & Recommendations**

### Mentale klachten aanpakken als ze toestemming verhinderen

Kernidee = wnr mentale problemen ervoor zorgen dat iemand geen geïnformeerde toestemming kan geven voor behandeling, moeten die problemen eerst aangepakt worden

- ➔ Bijvoorbeeld: ernstige psychose & zware cognitieve problemen kunnen maken dat iemand risico's & gevolgen niet goed begrijpt

Belangrijke nuance:

- ➔ Angst of depressie mogen niet automatisch een reden zijn om genderbevestigende zorg uit te stellen, zolang iemand nog wél beslissingen kan nemen

= men kijkt dus naar bekwaamheid tot consent, niet gewoon naar de aanwezigheid van mentale klachten.

### Ondersteuning bij perioperatieve zorg

Kernidee = wnr mentale problemen het moeilijk maken om een operatie goed voor te bereiden of nazorg te volgen, moet extra ondersteuning aangeboden worden

Waarom? Na chirurgie moet iemand bijvoorbeeld:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| - Afspraken opvolgen | - Medicatie nemen    |
| - Wondzorg uitvoeren | - Controles bijwonen |

Mentale problemen of middelengebruik kunnen dit bemoeilijken

- ➔ Mentale problemen betekenen niet dat iemand geen genderbevestigende zorg mag krijgen
- ➔ Ze tonen vooral aan dat: extra begeleiding nodig kan zijn

### Impact van mentale klachten op chirurgische uitkomst beoordelen

Kernidee = hulpverleners moeten bekijken hoe mentale problemen uitkomst van specifieke operatie kunnen beïnvloeden (niet elke operatie vraagt dezelfde voorbereiding of nazorg)

Mentale klachten kunnen invloed hebben op:

- Planning
- Afspraken nakomen
- Opvolging van instructies
- Herstelproces

Daarom moet ondersteuning aangepast worden aan situatie van persoon

### Psychosociale en praktische steun voorzien

Kernidee = hulpverleners moeten nagaan welke praktische & sociale steun iemand nodig heeft vóór, tijdens en na genderbevestigende chirurgie

Mogelijke noden:

- Stabiele huisvesting
- Financiële steun
- Hulp van familie/vrienden
- Praktische hulp tijdens herstel
- Vervoer

Sociale steun helpt mensen beter door het traject

### Stoppen met roken/nicotine vóór chirurgie

Kernidee = TGD-personen moeten ondersteund worden om te stoppen met roken vóór genderbevestigende chirurgie

Waarom? Roken verhoogt risico's zoals:

- Slechtere wondgenezing
- Necrose
- Infecties
- Complicaties na chirurgie

### Hormoonbehandeling behouden tijdens opname

Kernidee = hormoonbehandeling moet tijdens psychiatrische of medische opname meestal verdergezet worden

Waarom? Stoppen met hormonen kan:

- Mentale gezondheid verslechteren
- Dysforie vergroten
- Kwaliteit van leven verminderen

Alleen bij medische tegenindicaties mag tijdelijk gestopt worden

### Respect voor naam, voornaamwoorden en genderidentiteit

Kernidee = in zorginstellingen moeten hulpverleners:

- ➔ Correcte naam gebruiken, correcte voornaamwoorden gebruiken & toegang geven tot passende kamers/badkamers

Waarom belangrijk? Discriminatie in zorg leidt tot:

- Stress
- Meer suïcidaliteit
- Vermijding van zorg
- Slechtere mentale gezondheid

= respectvolle behandeling vermindert schade

### Sociale steun stimuleren

Kernidee = hulpverleners moeten TGD-personen helpen sociale steun op te bouwen & te behouden

➔ Sociale steun kan komen v vrienden, familie, partners, peers & LGBTQ+-gemeenschap

Effect v sociale steun:

- Beschermst mentale gezondheid
- Verhoogt veerkracht
- Vermindert effecten v discriminatie
- Verbeterd welzijn & levenskwaliteit

### Psychotherapie niet verplicht maken

Kernidee = psychotherapie mag geen verplichte voorwaarde zijn voor genderbevestigende behandeling

Therapie kan wél nuttig zijn voor:

- Coping
- Coming-out
- Zelfacceptatie
- Omgaan met stress

Belangrijk probleem = verplichte therapie kan:

- Toegang tot zorg vertragen
- Een extra drempel vormen
- Gatekeeping versterken

### Conversietherapie afwijzen

Kernidee = “Conversion therapy” of pogingen om iemands genderidentiteit te veranderen mogen niet aangeboden worden

Waarom?

- ➔ Onderzoek toont dat conversietherapie niet werkt & schadelijk is
- ➔ Het hangt samen met:
  - Meer depressie
  - Meer suicidaliteit
  - Meer middelenmisbruik
  - Slechter welzijn

Standpunt van organisaties:

- ➔ Veel grote medische & psychologische organisaties verwerpen conversietherapie
- ➔ Artikel benadrukt dat genderidentiteit niet “hersteld” of “veranderd” moet worden

### Belangrijk algemeen inzicht van het hoofdstuk

Het hoofdstuk vertrekt vanuit een genderaffirmatieve benadering:

- Respect voor identiteit
- Ondersteuning ipv controle
- Autonomie vd persoon
- Mentale zorg als ondersteuning, niet als obstakel

De focus ligt op:

- Welzijn verbeteren
- Discriminatie verminderen
- Veilige & toegankelijke zorg aanbieden

## 6. In-group VS out-group

Out – group – homogeniteit

= mensen vinden dat ze als groep erg verschillen vd anderen maar ook dat anderen allemaal hetzelfde zijn

Redenen wrm mensen scherp & vijandig reageren wnr ze met andere groep worden geconfronteerd

- ➔ Contrast = neiging om verschillen tss groepen te vergroten
- ➔ Assimilatie = verschillen tss groepen verkleinen

### In-group

= groep waartoe iemand behoort en zich mee identificeert

- |                 |              |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| - Interesses    | - Etniciteit | - Geslacht/gender   |
| - Overtuigingen | - Religie    | - Seksuele voorkeur |

### Out-group

= elke groep waar iemand zich niet toe behoort

- ➔ Verleidelijk om over te gaan tot polarisatie tss in-group en out-group
- ➔ Mensen hebben vaak (on)bewust minder empathie of positieve gevoelens voor out-group leden & kunnen deze groepen door in-group-out-group mechanismen & biases negatief beoordelen

### De inleefoefening van Jane Elliot

‘Blue eyes / brown eyes exercise’: bedoelt om kinderen te laten inleven ih gevoel v anders behandeld te worden

- Kinderen met bruine ogen zouden ‘beter’ zijn dan lln met blauwe ogen = bedoelt om discriminatie te vertalen nr de klasgroep
- Groep gaat zich superieur gedragen & namen arrogante houding aan tov andere groep lln
- Gedrag v blauwogigen veranderde: gingen zich schuchter opstellen & schoolresultaten leden onder situatie
- Week later rollen omgedraaid: duidelijke gedragsveranderingen MAAR minder uitgesproken
  - Wnr zelf discriminatie ondervonden, minder snel geneigd om zelf discriminerend gedrag te stellen nr anderen toe

Conclusie = laat zien hoe vooroordelen tot stand kunnen komen & zet aan tot nadenken over racistische motieven

### Minimale groepssituatie

Minimale groepssituatie experimenten = ‘in-group – favoritisme’ = eigen groep wordt systematisch beoordeeld

- ➔ Staat tov benadelen v anderen: ‘out-group – ondermijning’

### Centrale versus perifere route ten aanzien van de out-group

IAT test (implicit associations test) = in deze test opdracht om zo snel mogelijk te beslissen wnr je woord of afbeelding ziet

Stereotyperend associaties: 2 niveaus v attitudevorming (Gladwell)

- Bewuste oordelen/ deel waar we zelf over beslissen: probleem hebben met duidelijke vormen v racisme & discriminatie waarbij mensen minder rechten & kansen krijgen
- Attitudes op onbewust niveau (AIT)
  - Automatische impulsieve associaties nog voordat dat we kans krijgen erover na te denken
  - Nauwelijks of weinig controle + vaak n bewust v eigen automatische associaties/ onbewuste attitudes
  - Beïnvloeding vanuit maatschappij + wnr anders willen denken nog steeds geleerd om associaties te leggen

## 7. Inclusieve zorg?

Dit onderzoek gaat over hoe zorgprofessionals omgaan met de mentale gezondheid van jongeren met een migratieachtergrond en in welke mate zij cultuursensitief werken. Het is een verkennend kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met professionals.

### Inleiding — begrijpen en in eigen woorden kunnen uitleggen

#### Centrale boodschap:

Jongeren met een migratieachtergrond ervaren vaker:

- ➔ Discriminatie, racisme, prestatiedruk & drempels nr hulpverlening

= heeft negatieve invloed op hun mentale gezondheid & toch maken zij minder gebruik v formele hulpverlening dan jongeren zonder migratieachtergrond

Waarom is cultuursensitieve zorg belangrijk? Veel jongeren geven aan dat ze:

- Zich niet altijd begrepen voelen
- Veel moeten uitleggen over hun achtergrond
- Nood hebben aan herkenning & vertrouwen

= daardoor voelen sommige jongeren zich veiliger bij hulpverlener met gelijkaardige culturele achtergrond

#### Belangrijke ideeën uit de inleiding:

Mentale gezondheid staat onder druk, veel jongeren ervaren:

- Stress
- Angst
- Prestatiedruk
- Depressieve gevoelens

Bij jongeren met migratieachtergrond komt daar vaak nog discriminatie bovenop, onderzoek benadrukt dat:

- Dagelijkse discriminatie
- Uitsluiting
- Microagressies

een duidelijke negatieve impact hebben op:

- Welzijn
- Zelfbeeld
- Sense of belonging
- Mentale gezondheid

Sociale steun & zingeving zijn beschermende factoren, jongeren halen steun uit:

- Familie
- Spiritualiteit
- Gemeenschap
- Verbondenheid
- Geloof



Jongeren ervaren te weinig cultuursensitieve zorg, velen vinden dat hulpverlening:

- Te weinig rekening houdt met hun leefwereld
- Onvoldoende divers is
- Hun cultuur niet goed begrijpt

### **Welke methode werd gebruikt?**

- ➔ Kwalitatief verkennend onderzoek
- ➔ Onderzoekers wilden vooral ervaringen, meningen & perspectieven v professionals begrijpen
- ➔ Semigestructureerde interviews bij 19 zorg- en hulpverleners zoals: therapeuten, student counselors, hulpverleners, leerplichtambtenaren, coaches & systeemtherapeuten

Werving v respondenten:

- ➔ Professionals werden gevonden via netwerk vd onderzoekers & de sneeuwbalmethode (= geïnterviewden brachten nieuwe deelnemers aan)

Dataverzameling:

- Interviews gebeurden online via Microsoft Teams
- Gesprekken werden opgenomen & getranscribeerd
- Respondenten gaven toestemming

Analyse: de onderzoekers gebruikten een thematische analyse:

- Transcripties coderen
  - Thema's zoeken
  - Patronen analyseren
- ➔ Ze werkten tot er "saturatie" was = er kwamen geen nieuwe inzichten meer bij

## **Hoofdstuk 4 — ervaringen van professionals**

### Aandacht voor cultuur- en diversiteitssensitief werken

Belangrijkste idee:

- ➔ Er is volgens veel professionals nog te weinig aandacht voor cultuursensitief werken in opleidingen, protocollen & praktijk

Professionals mét migratieachtergrond benoemen dit veel sterker dan professionals zonder migratieachtergrond

- Er is weinig aandacht voor cultuursensitief werken in opleiding en praktijk
- Professionals zonder migratieachtergrond zien culturele sensitiviteit soms minder als meerwaarde
- Goede diagnostiek moet rekening houden met culturele context
- "Eerlijke diagnostiek" is belangrijk

### Rol van de eigen migratieachtergrond van professionals

Belangrijkste idee = professionals met een migratieachtergrond ervaren vaak:

- Meer herkenning
- Sneller vertrouwen
- Diepere gesprekken

Ze worden ook vaker gezien als rolmodellen

- ➔ Professionals met migratieachtergrond voelen dat jongeren en ouders hen sneller begrijpen
- ➔ Zij ervaren vaak effectievere communicatie

- ➔ Jongeren zien hen als inspiratie of rolmodel

### Aansluiting vinden bij jongeren

Belangrijkste idee = een goede vertrouwensband is essentieel, professionals benadrukken:

- Écht luisteren
- Jongeren begrijpen zonder oordeel
- Hun leefwereld kennen
- Hun taal spreken

School wordt gezien als een heel belangrijke plek voor vroegdetectie van problemen:

- Schoolhulpverlening is belangrijk voor vroegsignalering
- Verbinding met ouders helpt problemen sneller herkennen
- Jongeren moeten gehoord worden zonder oordeel
- Er moet aandacht zijn voor zelfstandigheid & eigen regie

### Begrip en empathie in hulpverlening

Belangrijkste idee = empathie & begrip zijn cruciaal in hulpverlening, professionals zeggen dat:

- Warmte
- Vertrouwen
- Begrip tonen
- Extra kansen geven

jongeren kan helpen om niet uit te vallen of verder vast te lopen

- ➔ Empathie is een belangrijke sleutel tot succesvolle hulpverlening
- ➔ Begrip tonen kan verergering van problemen voorkomen
- ➔ Jongeren voelen zich sterker ondersteund wanneer ze echt gehoord worden

### Racisme en discriminatie als stressoren

Belangrijkste idee = professionals met migratieachtergrond benoemen discriminatie vaak spontaan als grote stressfactor

- |                                                                                                                     |                          |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Stagediscriminatie</li><li>• Uitsluiting</li><li>• Microagressies</li></ul> | Deze ervaringen schaden: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zelfbeeld</li><li>• Welzijn</li><li>• Mentale gezondheid</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- ➔ Racisme & discriminatie worden gezien als belangrijke oorzaken v slechtere mentale gezondheid
  - ➔ Professionals zonder migratieachtergrond herkennen dit minder snel
  - ➔ Discriminatie wordt nog onvoldoende erkend binnen de zorg

### Gepercipieerde behoeften van jongeren

- ➔ Jongeren willen begrepen worden, niet veroordeeld worden & veilig hun verhaal kunnen doen
- ➔ Jongeren willen laagdrempelige & cultuursensitieve hulp
- ➔ Veiligheid & vertrouwen zijn essentieel
- ➔ Geloof & spiritualiteit werken beschermend voor mentale gezondheid

### Gepercipieerde worstelingen van jongeren

Jongeren ervaren vaak:

- Prestatiedruk
- Financiële problemen
- Schaamte rond hulp zoeken
- Taalbarrières
- Moeite om emoties te bespreken

### **Conclusie — wat moet je kennen**

Inclusieve zorg vraagt méér dan alleen een open houding

Goede zorg voor jongeren met een migratieachtergrond vraagt:

- Cultuursensitiviteit
- Erkenning v discriminatie
- Respresentatie binnen hulpverlening
- Empathie & vertrouwen

- Kennis v leefwereld & context

Wat blijkt uit het onderzoek?

Professionals met migratieachtergrond:

- Zien vaker het belang van cultuursensitief werken
- Herkennen discriminatie sneller
- Voelen meer aansluiting met jongeren

Professionals zonder migratieachtergrond:

- Leggen meer nadruk op “algemene openheid”
- Benoemen discriminatie minder spontaan

Inclusieve zorg betekent:

- Jongeren echt begrijpen binnen hun context
- Rekening houden met cultuur, migratie, religie & discriminatie
- Jongeren veilig laten voelen
- Ondersteuning bieden zonder oordeel

### 1. Transitie naar de kleuterschool

Artikel: Challenges in the transition to kindergarten and children's well-being through elementary school: Do school transition supports matter?

#### Intro

De overgang naar de kleuterklas/kindergarten is hun eerste kennismaking met formeel onderwijs & brengt:

- Nieuwe regels
- Hogere verwachtingen
- Meer sociale & emotionele eisen

met zich mee

De ervaringen tijdens deze overgang hebben invloed op:

- Schoolse prestaties
- Emotioneel welzijn
- Sociaal functioneren
- Verdere schoolloopbaan

Kinderen die moeilijkheden ervaren bij de start van school lopen meer risico op:

- Lagere schoolprestaties
- Gedragsproblemen
- Emotionele problemen

#### Transition challenges

= moeilijkheden die kinderen ervaren bij de overgang naar school, bijvoorbeeld:

- Niet naar school willen
- Emotionele stress
- Huilen of angstig zijn
- Moeite met aanpassen
- Doen alsof ze ziek zijn

Deze moeilijkheden tonen psychologische stress tijdens de overgang.

#### Rol van de school

Scholen proberen kinderen en ouders te ondersteunen via “transition supports”, zoals:

- Info geven aan ouders
- Oriënteringsmomenten
- Klasbezoeken organiseren
- Huisbezoeken
- Oudercontacten
- Gespreide instapdagen

Deze ondersteuning moet de overgang vlotter maken

#### **The current study**

##### Doel 1

= nagaan of overgangsmoeilijkheden bij de start v kindergarten samenhangen met:

- Schoolprestaties
- Sociaal-emotioneel functioneren

op korte termijn (einde kindergarten) én lange termijn (tot vijfde leerjaar)

##### Doel 2

= onderzoeken hoe overgangsondersteuning van scholen invloed heeft op:

- Overgangsmoeilijkheden
- Schoolprestaties
- Sociaal-emotioneel welzijn

De onderzoekers bekeken twee modellen:

- Mediatiemodel = ondersteuning → minder overgangsproblemen → betere ontwikkeling
- Moderatiemodel = ondersteuning beschermt kinderen tegen negatieve gevolgen v overgangsproblemen

## **Methode**

- ➔ Grootchalig longitudinaal onderzoek
- ➔ Men volgde kinderen over meerdere jaren: vanaf kindergarten tot het vijfde leerjaar
- ➔ Onderzoekers gebruikten gegevens v 13.390 kinderen uit de Amerikaanse studie: ECLS-K:2011
- ➔ Steekproef was nationaal representatief & cultureel divers

Welke gegevens verzamelden ze?

- ➔ Overgangsproblemen
- ➔ Ouders vulden vragenlijsten in over schoolweigering, angst, verdriet & stressreacties bij de start v kindergarten

## Transition supports

Leerkrachten gaven aan welke ondersteuning de school aanbood:

- Info voor ouders
- Oriëntaties
- Klasbezoeken
- Gespreide schoolstart
- Huisbezoeken

## Schoolse en sociaal-emotionele uitkomsten

- ➔ Men onderzocht lezen, wiskunde, leerhouding, internaliserend gedrag (angst, verdriet) & externaliserend gedrag (agressie, boosheid)

## Analyse

De onderzoekers gebruikten:

- Statistische modellen
- Padanalyses
- Latent class analysis (LCA)

om groepen scholen met verschillende soorten ondersteuning te vinden

## **Results**

### Overgangsproblemen voorspellen latere moeilijkheden

Kinderen met meer overgangsproblemen:

- Scoorden lager op lezen en wiskunde
- Hadden meer emotionele problemen
- Hadden slechtere leerhoudingen
- Hadden meer gedragsproblemen

aan het einde van kindergarten.

Langetermijneffecten: negatieve effecten bleven zichtbaar tot ih vijfde leerjaar:

- Lagere wiskundeprestaties
- Slechtere leerhouding
- Meer internaliserende problemen

### Drie soorten scholen qua ondersteuning

- Minimal supports (29%) = weinig ondersteuning:
  - Beperkte info
  - Weinig extra activiteiten
- High basic supports (63%) = veel basissteun:
  - Info naar ouders
  - Klasbezoeken
  - Ouderoriëntatie
- Intensive supports (9%) = veel uitgebreide ondersteuning:
  - Huisbezoeken
  - Gespreide schoolstart
  - Verkorte schooldagen

### Belangrijkste bevinding

Kinderen in scholen met “high basic supports”:

- Hadden minder overgangsproblemen
- Deden het beter academisch
- Hadden beter sociaal-emotioneel welzijn

Verrassende bevinding:

- “Intensive supports” werkten niet beter dan minimale ondersteuning
- Dus: méér of intensere ondersteuning betekent niet automatisch betere resultaten

### Geen buffering-effect

- ➔ Ondersteuning beschermde kinderen niet tegen negatieve gevolgen v overgangsproblemen
- ➔ Dus: transition supports voorkomen vooral problemen, maar lossen bestaande problemen niet noodzakelijk op

### Welke ondersteuning werkte het best?

Vooral effectief:

- ➔ Informatie nr ouders sturen
- ➔ Kinderen vooraf de klas laten bezoeken

Deze eenvoudige maatregelen verminderden overgangsproblemen.

### **Discussion**

- ➔ Een moeilijke overgang naar kindergarten heeft zowel onmiddellijke & langdurige negatieve gevolgen voor kinderen
- ➔ Eerste schoolervaring beïnvloedt leren, motivatie, emotioneel welzijn & verdere schoolloopbaan

Daarom moeten scholen investeren in een goede overgang

### Wat werkt volgens het onderzoek?

Vooral:

- Duidelijke communicatie met ouders
- Klasbezoeken vooraf
- Basisvormen v ondersteuning
- ➔ Niet noodzakelijk zeer intensieve of complexe maatregelen

Belangrijke interpretatie:

- ➔ Transition supports werken vooral preventief & vóór of tijdens de overgang

- ➔ Maar beschermen kinderen niet automatisch wanneer er al ernstige overgangsproblemen zijn

## 2. Naar de lagere school & het middelbaar

De overgang van de kleuterklas naar de lagere school is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Bij deze overgang wordt vaak gekeken of een kind cognitief “klaar” is voor het lager onderwijs, maar tegenwoordig is er ook meer aandacht voor het sociaal-emotionele aspect. Men kijkt dus niet enkel naar schoolse vaardigheden, maar ook naar vragen zoals:

- Kan het kind aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten?
- Voelt het zich goed in een nieuwe omgeving?
- Kan het omgaan met nieuwe verwachtingen?

Dit is extra belangrijk bij kinderen die cognitief sterk functioneren en eventueel een klas zouden kunnen overslaan. Dan moet men nadenken of het kind sociaal-emotioneel even ver staat als cognitief.

### Veranderingen in de lagere school

#### Meer structuur en discipline

In vergelijking met de kleuterklas:

- Zijn er vaste lestijden
- Zijn er duidelijke pauzemomenten
- Moeten kinderen langer stilzitten
- Moeten ze wachten op hun beurt
- Gelden meer gedragsregels

- ➔ Ook huiswerk & evaluaties worden ingevoerd: toetsen, taken, groepswerken, deadlines

Kinderen moeten dus zelfstandiger & verantwoordelijker worden

#### Sociale veranderingen

Veel kinderen komen in een nieuwe klas terecht en kennen niet iedereen, daardoor moeten ze:

- Nieuwe vriendschappen opbouwen
- Hun plaats vinden in de groep
- Leren samenwerken

Er wordt in klas & op de speelplaats meer gewerkt met:

- Groepswork
- Competitie
- Prestaties vergelijken

#### Minder ruimte voor spel

Voor veel kinderen voelt de overgang aan als een verlies van vrije speeltijd:

- Minder tijd voor vrij spel
- Meer focus op leren en presteren

Dit kan frustraties veroorzaken. Kinderen moeten:

- Langer concentreren
- Stilzitten
- Zelfredzaam zijn
- Hun agenda & materiaal beheren

#### Belang van de context

- ➔ Bij overgangsmomenten moet men altijd rekening houden met de thuissituatie, de ouder-kindrelatie & opvoeding thuis

De ondersteuning v ouders heeft een grote invloed op:

- Schoolse prestaties
- Sociaal functioneren
- Het aanpassen ad nieuwe schoolomgeving

Wnr ouders goed geïnformeerd & ondersteund worden:

- ➔ Verloopt de overgang vlotter
- ➔ Ontstaat meer communicatie tss ouders & leerkrachten

### **Overgang naar de middelbare school**

De overstap nr het middelbaar brengt opnieuw grote veranderingen mee, dee verwachtingen uit lagere school worden verder uitgebreid & jongeren krijgen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

#### Grotere en complexere schoolomgeving

- ➔ Middelbare scholen zijn vaak groter, drukker & minder overzichtelijk
- ➔ Jongeren moeten verschillende lokalen vinden, omgaan met meerdere leerkrachten & zich aanpassen aan verschillende lesstijlen en verwachtingen
- ➔ Vaak gaan jongeren vanaf dan ook zelfstandig nr school: met de fiets, te voet, openbaar vervoer

#### Hogere schoolse verwachtingen

- ➔ De leerstof wordt moeilijker, abstracter, uitgebreider
- ➔ Daarnaast stijgt de druk: meer toetsen, meer taken, examens die zwaarder doorwegen

Er wordt verwacht dat jongeren:

- Zelfstandig plannen
- Deadlines respecteren
- Studeren
- Verantwoordelijkheid opnemen

#### Meer keuzevrijheid

Ih middelbaar moeten jongeren keuzes maken:

- Studierichtingen
- Vakkenpakketten

Die keuzes kunnen invloed hebben op hun verdere schoolloopbaan en toekomst

- ➔ Meer keuzevrijheid betekent dus ook meer verantwoordelijkheid

#### Sociale veranderingen

Ook sociaal verandert er veel:

- Nieuwe klasgroepen
- Nieuwe vrienden
- Verlies v oude vriendengroepen

Jongeren moeten opnieuw hun plaats zoeken binnen een nieuwe sociale omgeving

#### Stress rond schoolkeuze

In sommige Vlaamse steden zijn bepaalde scholen populairder dan andere, daardoor werken scholen soms met:

- Inschrijvingsbeperkingen
- Ordeningscriteria

Niet iedereen kan naar zijn eerste keuze gaan & dit kan leiden tot:

- ➔ Stress, teleurstelling, onzekerheid



- ➔ Sommige jongeren komen daardoor niet samen terecht met vrienden uit de lagere school, wat de overgang extra moeilijk kan maken

### 3. Overgang naar het hoger onderwijs/op kot

De overgang naar het hoger onderwijs is een belangrijke life event waarbij jongvolwassenen geconfronteerd worden met veel veranderingen tegelijk. Studenten moeten niet alleen wennen aan een nieuwe schoolomgeving, maar vaak ook aan een nieuwe woonomgeving, nieuwe sociale contacten en meer zelfstandigheid.

Veel studenten laten tijdens deze periode hun vertrouwde sociale netwerk achter & moeten een nieuw netwerk opbouwen. Daardoor ervaren veel eerstejaarsstudenten tijdens de eerste weken of maanden gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid, heimwee & stress

Voor sommige studenten betekent deze overgang ook het verlaten van het ouderlijk huis. In België en Nederland verblijven studenten vaak “op kot” en gaan ze in het weekend naar huis. In landen zoals de VS wonen studenten meestal permanent dicht bij de campus. Dit kan gevoelens van heimwee versterken, maar stimuleert tegelijk ook:

- Autonomie
- Zelfstandigheid
- Persoonlijke groei

#### Nieuwe verwachtingen in het hoger onderwijs

Studeren aan een hogeschool of universiteit vraagt veel zelfredzaamheid

In tegenstelling tot het secundair onderwijs:

- Zijn lessen vaak niet verplicht
- Moeten studenten zelf hun planning maken
- Is er minder controle
- Ligt de nadruk sterk op examens

De evaluaties wegen vaak zwaarder door dan in middelbaar onderwijs

Studenten moeten:

- Zelfstandig studeren
- Keuzes maken
- Deadlines halen
- Verantwoordelijkheid opnemen

Daarnaast combineren veel studenten verschillende rollen:

- ➔ Student, werknemer, vriend(in), partner, lid van studentenvereniging

Het vinden van evenwicht tussen studie, sociale contacten & ontspanning kan moeilijk zijn en invloed hebben op het psychisch welzijn

#### Identiteitsontwikkeling

De periode van hoger onderwijs is ook een fase van sterke identiteitsontwikkeling, studenten denken na over:

- Hun toekomst
- Hun loopbaan
- Hun waarden & normen
- Wie ze willen zijn

Voor sommige studenten werkt deze uitdaging stimulerend & bevordert ze:

- ➔ Autonomie, zelfvertrouwen & zelfsturing

Andere studenten voelen zich:

- ➔ Overweldigd, onzeker & gestrest

Hierdoor kunnen:

➔ Faalangst, burn-outklachten & mentale problemen ontstaan of verergeren

### **Het onderzochte programma: “Transitions”**

Het artikel onderzoekt een programma dat de mentale veerkracht v eerstejaarsstudenten probeert te versterken. Het programma heet Transitions en combineert:

- Mentale gezondheidseducatie (mental health literacy)
- Life skills

Het doel is studenten beter te leren omgaan met:

- Stress
- Veranderingen
- Mentale problemen
- Hulp zoeken

### Introduction

De inleiding legt uit dat:

- Veel mentale problemen ontstaan tijdens de adolescentie & jongvolwassenheid
- De overgang nr het hoger onderwijs een kwetsbare periode is
- Studenten vaak negatieve emoties ervaren tijdens deze overgang

Belangrijk:

- ➔ Niet elke negatieve emotie betekent automatisch een psychische stoornis
- ➔ Het artikel benadrukt dat studenten soms: normale stress verkeerd interpreteren als een mentale stoornis OF echte mentale problemen juist niet herkennen

Daarom is “mental health literacy” belangrijk:

= kennis over mentale gezondheid, stress, psychische stoornissen & hulp zoeken

Volgens de auteurs kan een programma dat:

- Informatie geeft over mentale gezondheid
- Én tegelijk praktische levensvaardigheden aanleert

studenten helpen tijdens deze overgang

### Methode

= quasi-experimenteel cohortonderzoek

Studenten uit vijf Canadese hogescholen/universiteiten werden verdeeld in:

- Interventiegroep → kreeg het programma “Transitions”
- Controlegroep → kreeg het programma nog niet
- ➔ In totaal namen 2397 studenten deel
- ➔ Er werd gemeten vóór het programma, onmiddellijk erna & opnieuw na 2 maanden

Men onderzocht:

- Kennis over mentale gezondheid
- Stigma
- Hulpzoekgedrag
- Stress
- Algemene gezondheid

### Procedure

Het programma bevatte info over:

- Studievaardigheden
- Omgaan met uitstelgedrag
- Stressmanagement
- Mentale gezondheid
- Relaties
- Identiteit
- Seksualiteit
- Campusondersteuning

- Hulp zoeken

Studenten kregen ongeveer twee weken tijd om het materiaal te lezen

De uitvoering verschilde per instelling:

- Soms zelfstandig lezen
  - Soms klassikale uitleg
  - Soms workshops of spelvormen
- ➔ Belangrijk: het programma was flexibel inzetbaar afh vd schoolcontext

### Survey and data analysis

De onderzoekers gebruikten vragenlijsten om vijf zaken te meten:

#### 1: Kennis

- Mentale gezondheid
- Stress
- Mentale stoornissen
- Coping

#### 2: Stigma

- Hoe studenten denken over mentale problemen.

#### 3: Hulpzoekattitudes en gedrag

- Willen studenten hulp zoeken?
- Zoeken ze effectief hulp?

#### 4: Algemene gezondheid

#### 5: Ervaren stress

Daarna werden statistische analyses uitgevoerd om:

- Interventiegroep en controlegroep te vergelijken
- Veranderingen doorheen de tijd te onderzoeken

### Results

Studenten die deelnamen aan Transitions:

- Hadden meer kennis over mentale gezondheid
- Zochten vaker effectief hulp
- Hadden minder stigma rond mentale problemen
- Ervaarden minder stress
- Stonden positiever tegenover hulp zoeken

Er werd geen duidelijke verbetering gevonden in algemene gezondheid

- ➔ Volgens de onderzoekers kan dit komen doordat de opvolgperiode v 2 maanden te kort was

Een belangrijke bevinding:

- ➔ Studenten id interventiegroep zochten 2,75 keer vaker hulp dan studenten id controlegroep

### Discussion

Onderzoekers besluiten dat het programma nuttig kan zijn tijdens de overgang nr het hoger onderwijs

- Mentale gezondheidseducatie werkt preventief
- Stigma vermindert
- Studenten leren normale stress beter begrijpen
- Stress vermindert

Het programma werkte in verschillende scholen & via verschillende werkvormen = flexibel inzetbaar is

De onderzoekers benadrukken ook beperkingen:

- Geen volledig gerandomiseerd onderzoek
- Uitval v deelnemers tijdens follow-up
- Weinig diverse populatie

### Conclusion

De conclusie = transitions kan een waardevol hulpmiddel zijn om:

- Studenten beter te ondersteunen
- Mentale gezondheid te versterken
- Stress tijdens de overgang nr het hoger onderwijs te verminderen

Het programma kan deel uitmaken ve bredere preventieve aanpak rond studentenwelzijn op campussen

Zou dit programma nuttig zijn in Vlaanderen?

Waarom wel:

- Vlaamse studenten ervaren gelijkaardige stressfactoren: examens, prestatiedruk, eenzaamheid, kotleven, identiteitsontwikkeling
- Veel studenten weten onvoldoende wnr stress “normaal” is & wnr professionele hulp nodig is
- Het programma combineert psycho-educatie, praktische vaardigheden & preventie
- Het kan stigma rond mentale problemen verminderen
- Het programma is flexibel inzetbaar tijdens onthaalweken, in begeleidingstrajecten & via workshops of online modules

Mogelijke beperkingen in Vlaanderen:

- Studenten nemen mogelijk niet vrijwillig deel
- Er is nood aan tijd, begeleiding & financiering
- Niet elke student staat open voor mentale gezondheidseducatie
- Culturele verschillen kunnen aanpassing van het programma nodig maken

## **4. Impact van pesten**

Pesten is geen “onschuldige kinderfase”, maar een ernstige negatieve ervaring die nog jarenlang gevolgen kan hebben. Onderzoek toont aan dat slachtoffers v pesten zelfs tientallen jaren later nog psychologische, sociale & economische problemen kunnen ervaren

De longitudinale Britse National Child Development Study volgde kinderen vanaf 1958 tot op volwassen leeftijd & toonde aan dat kinderen die gepest werden op 7- en 11-j op hun 50ste nog steeds vaker:

- Depressieve klachten hebben
- Minder sociale steun ervaren
- Een lagere levenskwaliteit rapporteren

Daarnaast werd in het hoorcollege ook het artikel van Pabian et al. besproken, dat focust op hoe jongvolwassenen zelf de langetermijnimpact van pesten ervaren.

### **Introduction**

De auteurs vertrekken vanuit de vaststelling dat zowel traditioneel pesten als cyberpesten veel voorkomen bij jongeren. Pesten wordt gedefinieerd als:

➔ Intentioneel agressief gedrag dat herhaaldelijk voorkomt waarbij machtsonevenwicht bestaat

Cyberpesten verschilt v traditioneel pesten omdat het:

- Anoniem kan gebeuren
- Online zichtbaar blijft

- Altijd en overal mogelijk is
- Minder gecontroleerd wordt door volwassenen
- ➔ Het artikel benadrukt dat eerdere studies vooral keken naar de frequentie & ernst van pesten
- ➔ Maar minder aandacht besteedden aan hoe slachtoffers zelf de impact van pesten ervaren

De auteurs stellen dat deze subjectieve beleving ("perceived impact") mogelijk belangrijker is voor latere mentale gezondheid dan de objectieve ernst van het pesten.

### **Bullying victimization and self-esteem, social interaction anxiety and life satisfaction**

Het artikel bespreekt drie belangrijke gevolgen van pesten:

#### Lager zelfbeeld (self-esteem)

= slachtoffers van pesten ontwaken:

- Onzekerheid
  - Negatieve zelfevaluaties
  - Minder zelfvertrouwen
- ➔ Zelfbeeld ontwikkelt zich sterk via feedback van anderen = wie langdurig negatief behandeld wordt, kan dit internaliseren

Studies tonen aan dat slachtoffers:

- ➔ Lager zelfbeeld hebben tijdens adolescentie
- ➔ En zelfs tot 40 jaar later lagere zelfwaardering kunnen ervaren

#### Sociale angst (social interaction anxiety)

Slachtoffers ontwaken:

- Angst om beoordeeld te worden & sociale interacties
- Wantrouwen tegenover anderen

Ze kunnen vrezen:

- Uitgelachen & uitgesloten te worden
- Negatief geëvalueerd te worden

Pesten beïnvloedt dus niet alleen het zelfbeeld, maar ook hoe veilig iemand zich voelt in sociale relaties

#### Minder levenstevredenheid (life satisfaction)

- ➔ Slachtoffers rapporteren vaker minder tevredenheid met hun leven, minder welzijn & geluk
- ➔ Langdurig gepest worden kan het algemene levensperspectief negatief beïnvloeden

### **Processes that explain the relationship between bullying victimization and negative mental health and wellbeing outcomes**

Het artikel bespreekt verschillende mechanismen die verklaren waarom pesten zulke langdurige gevolgen heeft

#### Sociale steun

- ➔ Minder steun van vrienden, familie & leerkrachten kan de negatieve gevolgen versterken
- ➔ Sociale steun werkt beschermend tegen depressie, angst & stress

#### Veerkracht (resilience)

- ➔ Veerkracht helpt jongeren omgaan met moeilijke ervaringen

Slachtoffers van ernstig pesten ontwikkelen soms:

- Minder copingvaardigheden
- Minder psychologische weerbaarheid

### Zelfeffectiviteit (self-efficacy)

= het geloof dat men moeilijke situaties aankan

Pesten kan leiden tot:

- Gevoelens v machteloosheid
- Minder vertrouwen in eigen kunnen

### Subjectieve impact ("perceived impact")

De auteurs stellen dat:

- ➔ Niet alleen het pesten zelf belangrijk is, maar vooral hoe iemand die ervaring achteraf interpreteert
- ➔ Twee personen kunnen hetzelfde meemaken, maar de impact totaal anders beleven

Een sterk negatieve interpretatie hangt samen met:

- Meer angst
- Lager zelfbeeld
- Minder levenskwaliteit

Daarnaast bespreken de auteurs ook: "posttraumatic growth"

= positieve groei na negatieve ervaringen

- ➔ Sommige slachtoffers voelen zich later sterker, weerbaarder & empathischer

### **The present study**

Doel vd studie = onderzoeken hoe de ervaren negatieve & positieve impact v pesten samenhangt met:

- Zelfbeeld
  - Sociale angst
  - Levenstevredenheid
- ➔ De studie gebeurde bij Vlaamse jongeren, Nederlandse jongeren tss 18 & 26 jaar

De onderzoekers formuleerden drie hypothesen:

| Hypothese 1                                                                                                                                                                        | Hypothese 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hypothese 3                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| = meer intense pestervaringen hangen samen met: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lager zelfbeeld</li><li>• Meer sociale angst</li><li>• Minder levenstevredenheid</li></ul> | = sterkere negatieve ervaren impact hangt samen met: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lager zelfbeeld</li><li>• Meer sociale angst</li><li>• Minder levenstevredenheid</li></ul> Een sterkere positieve ervaren impact hangt samen met: <ul style="list-style-type: none"><li>• Hoger zelfbeeld</li><li>• Minder sociale angst</li><li>• Meer levenstevredenheid</li></ul> | = ervaren impact v pesten verklaart gedeeltelijk de relatie tss pestervaringen & latere mentale gezondheid |

### **Method**

- ➔ De studie gebruikte retrospectieve vragenlijsten bij Vlaamse en Nederlandse jongvolwassenen
- ➔ Vlaamse steekproef: 1010 jongeren
- ➔ Nederlandse steekproef: 650 jongeren

Men onderzocht:

- Intensiteit v pesten
- Ervaren negatieve impact
- Ervaren positieve impact
- Zelfbeeld
- Sociale angst
- Levenstevredenheid

➔ Er werden zowel gesloten vragen als open vragen gebruikt

## Results

### Negatieve impact

Een sterkere negatieve ervaren impact hing samen met:

- Lager zelfbeeld
- Meer sociale angst
- Minder levenstevredenheid

Hoe ernstiger het pesten, hoe groter de ervaren negatieve impact

### Positieve impact

- Sterker geworden
- Weerbaarder
- Empathischer
- Beter anderen helpen

Maar: negatieve impact bleef veel sterker samenhangen met mentale problemen

### Open antwoorden van slachtoffers

Veel slachtoffers beschreven:

- Wantrouwen
- Onzekerheid
- Sociale angst
- Moeilijkheden met relaties
- Depressieve gevoelens

Anderen beschreven positieve groei:

➔ Assertiever, sterker, meer begrip voor anderen

## Discussion

De belangrijkste conclusie = niet alleen de pestervaring zelf, maar vooral manier waarop slachtoffers die ervaring later beleven en interpreteren, verklaart langdurige gevolgen

Het artikel toont dat:

- Pesten diepe psychologische sporen nalaat
- Deze sporen nog zichtbaar zijn tijdens jongvolwassenheid
- Subjectieve beleving cruciaal is

Belangrijk:

- ➔ Studie vond weinig directe effecten v pesten op mentale gezondheid
- ➔ Effecten liepen vooral via de ervaren negatieve impact
- ➔ Dit ondersteunt traumatheorieën = betekenis die iemand geeft aan negatieve ervaring beïnvloedt het psychisch welzijn sterk
- ➔ Sommige slachtoffers ervaren positieve groei, maar neemt negatieve gevolgen niet volledig weg

## 5. Nieuwe job, ontslag & werkloosheid

### Veranderen van job als life event

Mensen veranderen v werk om verschillende redenen:

- Betere carrière mogelijkheden
- Hoger loon
- Betere werk-privébalans
- Kortere woon-werkafstand
- Meer aansluiting bij persoonlijke waarden & interesses

Een jobwissel kan:

- ➔ Vrijwillig & goed gepland zijn
- ➔ Ontstaan door ontslag of gevoel v “geen andere keuze hebben”

### Uitdagingen bij een jobverandering

Zoeken nr een nieuwe job vraagt vaak veel tijd & energie en gaat regelmatig gepaard met:

- Onzekerheid
- Stress
- Twijfels
- Angst voor het onbekende

Bij een nieuwe functie ontstaat vaak tijdelijk extra druk:

- ➔ Werknemers willen zich bewijzen
- ➔ Ze moeten wennen aan nieuwe verwachtingen, collega's & routines

Soms zijn er ook financiële risico's:

- Periode zonder inkomen
- Minder werkzekerheid
- Verlies v anciënniteit
- Minder gunstige arbeidsvoorwaarden

### Positieve gevolgen van een jobwissel

Een nieuwe job kan:

- Beter aansluiten bij persoonlijke waarden
- Meer motivatie geven
- Zorgen voor meer werktevredenheid
- Meer toekomstperspectief bieden
- Zorgen voor betere balans tss werk & privé

Onderzoek toont aan dat zulke veranderingen vaak langdurige positieve effecten hebben op het welzijn, vooral wnr:

- Jobinhoud beter past bij de persoon
- Werkdruk beter beheersbaar is
- Men meer betekenis ervaart ih werk

### Ontslag als ingrijpende gebeurtenis

Ontslag betekent:

- ➔ Verlies v werk, noodzaak om nieuw werk te zoeken & risico op werkloosheid

Werk heeft namelijk meerdere functies:

- Inkomen voorzien
- Structuur geven ah dagelijks leven
- Sociale contacten bieden
- Bijdragen aan identiteit & status
- Verbinding geven met de samenleving

### Ontslag hoeft niet altijd negatief te zijn

= kan soms ook als opluchting voelen, bijvoorbeeld:

- Wanneer iemand al lang ongelukkig is op het werk



- Maar zelf de stap niet durft zetten om te vertrekken
- ➔ In zo'n situatie kan ontslag een nieuwe start mogelijk maken of leiden tot persoonlijke groei of een betere job

### **Impact van werkloosheid op welbevinden**

Werkloosheid heeft meestal sterke negatieve invloed op het subjectieve welbevinden

- ➔ Verlies van inkomen, structuur & sociale contacten
- ➔ Verminderd gevoel v eigenwaarde
- ➔ Onzekerheid over toekomst

Onderzoek toont aan dat het soms tot 3 jaar duurt voor het oorspronkelijke welbevinden herstelt, vooral wnr iemand weinig kansen ziet op nieuw werk:

- Daalt het levensgeluk sterker
- Ervaart men meer stress & hopeloosheid

### Afschrikeffect

= mensen die ooit ontslagen zijn geweest, blijven vaak bang om opnieuw hun job te verliezen

- ➔ Zelfs wnr ze opnieuw werk hebben blijft er onzekerheid bestaan & voelen ze zich minder veilig op professioneel vlak

### **Angst voor ontslag**

- ➔ Voortdurende onzekerheid over werk zorgt vaak voor stress, piekeren, spanning & verminderde levenskwaliteit

De negatieve impact hangt sterk samen met hoe iemand zijn kansen op nieuw werk inschat:

- ➔ Wnr iemand denkt: "ik zal moeilijk opnieuw werk vinden" stijgt psychologische belasting

## **6. Burn-out**

### **Wat is burn-out?**

Burn-out is een toestand v:

- Cynisme of afstand nemen van het werk
- Verminderd gevoel van competentie of effectiviteit
- Emotionele uitputting
- Mentale uitputting

Begrip ontstond id jaren 1970 & werd vooral gebruikt bij mensen in zorg- en hulpverlenende beroepen  
Later werd duidelijk dat burn-out in bijna alle beroepen kan voorkomen

Volgens Maslach & Leiter ontstaat burn-out wnr er langdurige stress is id relatie tss persoon & het werk

- ➔ Gaat dus niet enkel om "te hard werken", maar vooral om langdurige mismatch tss werknemer & werkomgeving

### **Kernsymptomen van burn-out**

Maslach beschrijft 3 centrale dimensies van burn-out:

#### Emotionele uitputting

= gevoel volledig leeg, moe & opgebruikt te zijn

Kenmerken:

- Geen energie meer
- Emotioneel uitgeput

- Overbelasting
- Gevoel “ik kan niet meer”

### Cynisme/depersonalisatie

= afstand nemen v/h werk, cliënten of collega's

Mensen:

- Worden afstandelijker
- Verliezen betrokkenheid
- Reageren cynisch
- Beschermen zichzelf emotioneel

Vooraf in zorgberoepen kan dit zich uiten in onpersoonlijk omgaan met cliënten of patiënten

### Verminderde persoonlijke bekwaamheid

= gevoel minder competent of succesvol te zijn

- Twijfelen aan eigen kunnen
- Gevoel niet goed genoeg te presteren
- Minder zelfvertrouwen
- Verminderde motivatie

### **Burn-out ≠ gewone stress**

- ➔ Stress betekent vaak “te veel van alles”
- ➔ Burn-out eerder: leegte, uitputting en afstand

Chronische stress kan uiteindelijk leiden tot burn-out wnr er onvoldoende herstelmomenten zijn, het lichaam blijft dan langdurig in toestand v paraatheid

### **Ontwikkeling van burn-out**

= geleidelijk

Mogelijk verloop:

- Hoge motivatie & engagement
- Toenemende werkdruk
- Emotionele uitputting
- Cynisme & afstand nemen
- Verminderd functioneren

Mensen met burn-out starten vaak net als zeer geëngageerde werknemers:

- Perfectionistisch
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Betrokken
- Hoge verwachtingen v zichzelf

Na langdurige overbelasting ontstaat echter uitputting.

### **Belangrijke oorzaken van burn-out**

Maslach en Leiter beschrijven 6 domeinen waarin een mismatch tussen persoon en werk kan ontstaan.

#### Werkload (werkbelasting)

= te veel werk of te weinig herstel

- Hoge werkdruk
  - Te weinig personeel
  - Constant deadlines
  - Geen rustmomenten
- = sterk verbonden met emotionele uitputting

#### Controle

= te weinig autonomie of inspraak

- Weinig beslissingsvrijheid
  - Gevoel geen controle te hebben
  - Strikte regels zonder inspraak
- = verhoogt stress & machteloosheid

### Reward (beloning)

= te weinig waardering

- Loon
- Respect
- Erkenning
- Waardering v collega's of leidinggevenden

### Community

= problemen in sociale relaties op het werk

- Conflicten
- Pesten
- Slechte teamsfeer
- Gebrek aan steun

Sociale steun werkt normaal beschermend tegen stress

### Fairness

= gevoel v onrechtvaardigheid

Mensen ervaren meer stress wnr:

- Regels niet eerlijk zijn
  - Anderen bevoordeeld worden
  - Beslissingen onduidelijk zijn
- = tast vertrouwen aan

### Values (waarden)

= conflict tss persoonlijke waarden & werkcontext

- Werk moeten doen waar men niet achter staat
  - Commerciële druk die botst met eigen normen
  - Gevoel geen zinvol werk meer te doen
- Kan leiden tot innerlijke spanning

### **Individuele factoren**

Niet iedereen ontw even snel burn-out, factoren die risico verhogen:

- Perfectionisme
- Lage zelfwaardering
- Neuroticisme
- Weinig copingvaardigheden
- Externe locus of control

→ Ook persoonlijkheid speelt dus een rol, maar burn-out wordt vooral gezien als een probleem vd interactie tss persoon & werkomgeving

### **Gevolgen van burn-out**

#### Psychische gevolgen

- Depressieve gevoelens
- Prikkelbaarheid
- Concentratieproblemen
- Angst
- Emotionele instabiliteit

#### Lichamelijke gevolgen

- Slaapproblemen
- Hoofdpijn
- Vermoeidheid
- Verhoogde kans op cardiovasculaire problemen
- Verzwakt immuunsysteem

#### Gevolgen op werkvlak

- Lagere prestaties
- Absenteïsme
- Meer fouten
- Verloopintentie
- Minder werktevredenheid

### Sociale gevolgen

- Conflicten thuis
- Minder energie voor relaties
- Sociale terugtrekking

### **Engagement als tegenovergestelde**

Maslach beschrijft “engagement” als het positieve tegenovergestelde v burn-out

- ➔ Energie, betrokkenheid, enthousiasme, voldoening, absorptie ih werk
- ➔ Wnr mensen voldoende steun ervaren, autonomie hebben & zich gewaardeerd voelen stijgt engagement & daalt burn-out

## Hoorcollege 5: verlies

### 1. Verlies van een thuis

Verhuizen brengt vaak een verlies van een thuis met zich mee. Mensen laten niet alleen een huis achter, maar ook een plek waar veel herinneringen en gevoelens aan verbonden zijn. In een woning beleven mensen belangrijke momenten, zoals gezinsmomenten, relaties of vriendschappen. Daardoor kan verhuizen echt als een verlieservaring aanvoelen. Men neemt afscheid van een hoofdstuk in het leven en maakt tegelijk ruimte voor nieuwe herinneringen op een andere plek.

### 2. Vrijwillige migratie

#### Verhuizen als ingrijpend life event

Mensen verhuizen naar het buitenland om verschillende redenen:

- Betere werkmogelijkheden
  - Relatie of gezin
  - Studies
  - Pensioen in een warmer land
  - Een droom najagen
  - Nieuwe kansen & ervaringen zoeken
- ➔ Verhuis naar een ander land brengt bijna altijd grote veranderingen & aanpassingen met zich mee
- ➔ Het kan kansen bieden op persoonlijke groei, het wereldbeeld verruimen & nieuwe sociale contacten creëren
- ➔ Maar kan ook stress, onzekerheid, verlieservaringen & aanpassingsmoeilijkheden veroorzaken

#### Aanpassen aan een nieuwe cultuur

Één van de grootste uitdagingen is wennen aan andere cultuur

Elk land heeft:

- Eigen normen & waarden
- Andere communicatiestijlen
- Andere sociale gewoonten
- Andere verwachtingen

Mensen moeten zich aanpassen aan:

- Nieuwe omgangsvormen
  - Andere levensstijlen
  - Andere regels & systemen
- ➔ Dit proces vraagt flexibiliteit, openheid & tijd

Sommige mensen ervaren hierbij:

- Cultuurshock
- Onzekerheid
- Verwarring
- Frustratie

Taalbarrière:

Wanneer iemand de taal nog niet goed spreekt:

- Ontstaan sneller misverstanden
  - Voelt men zich minder zelfstandig
  - Wordt sociaal contact moeilijker
- ➔ Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie, eenzaamheid & onzekerheid
- ➔ Taal leren helpt vaak om sneller verbinding te maken met de nieuwe omgeving

## Praktische uitdagingen

Een verhuis naar het buitenland brengt vaak veel administratie & praktische regelingen met zich mee

- Visum aanvragen
- Verzekeringen afsluiten
- Werkvergunning regelen
- Nieuwe gezondheidszorg leren kennen
- Huisvesting zoeken

➔ Dit bureaucratische proces kan stressvol, vermoeiend & tijdsintensief zijn

Ook werk vinden kan moeilijk zijn:

- Andere arbeidsmarkt
- Andere werkcultuur
- Diploma's worden niet altijd erkend

## Emotionele impact

Een verhuis naar het buitenland betekent vaak afscheid nemen v:

- Familie
- Vertrouwde omgeving
- Vrienden
- Gewoontes & routines
- Huisdieren

➔ Hoewel technologie helpt om contact te houden blijft fysieke afstand vaak moeilijk

➔ Mensen kunnen heimwee ervaren, verdriet voelen, zich eenzaam voelen & het gevoel hebben "tss twee werelden" te leven

Belangrijk:

➔ Het gemis wordt niet alleen gevoeld door degene die verhuist, maar ook door familie & vrienden die achterblijven

## Nieuwe kansen en groei

Mogelijke positieve gevolgen:

- Breder kijk op de wereld
- Nieuwe sociale contacten
- Persoonlijke ontwikkeling
- Professionele kansen
- Meer zelfstandigheid

Veel mensen leren:

- Flexibeler omgaan met veranderingen
- Zelfstandiger functioneren
- Omgaan met onzekerheid

➔ Een buitenlandse ervaring kan dus bijdragen aan identiteitsontwikkeling & persoonlijke groei

## Geluk en migratie

Veel mensen vertrekken naar het buitenland met het idee daar gelukkiger te zullen zijn

Onderzoekers van Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) onderzochten dit:

- ➔ Mensen met een migratieachtergrond zijn gemiddeld iets gelukkiger dan vergelijkbare mensen die niet verhuisden
- ➔ Het verschil bedraagt ongeveer 0,5 punt op een schaal van 0 tot 10

Deze stijging in geluk:

- Is vooral zichtbaar tijdens de eerste vijf jaar na de verhuis
- Blijft daarna eerder stabiel

- ➔ Dit suggereert dat migratie voor veel mensen positieve effecten kan hebben op het welzijn

### **Belangrijke kanttekening**

Niet iedereen ervaart een verhuis naar het buitenland op dezelfde manier.

De impact hangt af van:

- Persoonlijkheid
- Copingvaardigheden
- Sociale steun
- Financiële situatie
- Reden v migratie
- Taalvaardigheid
- Ervaringen in nieuwe land

- ➔ Voor sommigen betekent migratie vrijheid, groei & kansen  
➔ Voor anderen verlies, stress & ontworteling

### **3. Onvrijwillige migratie**

Mensen die gedwongen moeten migreren, komen vaak terecht in moeilijke leefomstandigheden zoals tentenkampen of grootschalige opvangcentra. Daar moeten ze samenleven met veel andere mensen, wat veel aanpassing vraagt & extra stress kan veroorzaken

Het onderzoek “Sources of resilience for refugee youth in Ethiopia” onderzocht hoe jonge vluchtelingen in Ethiopië veerkracht ontwikkelen. De onderzoekers gebruikten focusgroepen & interviews met jongeren, leerkrachten, hulpverleners & begeleiders

Belangrijkste bronnen v veerkracht

#### **Sociale steun**

- ➔ Jongeren haalden veel steun uit familie, vrienden, leerkrachten, begeleiders & leeftijdsgenoten met gelijkaardige ervaringen  
➔ Sociale steun hielp hen omgaan met stress, verdriet en moeilijke ervaringen, vooral cc met andere vluchtelingen zorgde voor herkenning & begrip  
➔ Niet-begeleide jongeren & jongeren met een beperking ervaarden vaker eenzaamheid & minder ondersteuning

#### **Werk en zinvolle activiteiten**

Werk gaf jongeren:

- Een gevoel v eigenwaarde
  - Mogelijkheid om het gezin financieel te helpen
  - Structuur
  - Afleiding v stress
- ➔ Veel jongeren deden kleine jobs zoals verkopen, werken op bouwerven of handeldrijven  
➔ Er waren ook risico's: kinderarbeid, schooluitval & onveilige werkomstandigheden

#### **Onderwijs**

School bood jongeren:

- Toekomstperspectief
- Structuur
- Sociale contacten
- Kansen om hobby's & interesses te ontw

Onderwijs hielp jongeren om zich aan te passen aan leven in kamp & meer zelfvertrouwen op te bouwen

- ➔ Sommige, bv met een beperking, ervaarden wel discriminatie of onvoldoende ondersteuning

## Religie

Religie speelde voor veel jongeren een belangrijke rol:

- ➔ Bidden gaf rust & hoop
- ➔ Religieuze bijeenkomsten zorgden voor verbondenheid
- ➔ Religieuze leiders hielpen soms bij conflicten
- ➔ Hielp jongeren omgaan met stress en negatieve gevoelens

## Betrokkenheid bij de gemeenschap

Positieve contacten met de lokale bevolking zorgden voor:

- Meer verbondenheid
- Gevoel v veiligheid
- Sociale steun

Samen werken, vieren & activiteiten doen hielp jongeren integreren, toch ervoeren sommigen ook discriminatie & uitsluiting

Belangrijk uit de discussie:

- ➔ Onderzoek toont dat veerkracht geen vaste eigenschap is, maar ontstaat door de wisselwerking tss jongeren & hun omgeving
- ➔ Familie, school, werk, religie & gemeenschap spelen allemaal een belangrijke rol
- ➔ Vluchtelingen mogen niet enkel als kwetsbaar of getraumatiseerd mogen bekeken worden
- ➔ Ondanks moeilijke ervaringen beschikken veel jongeren over kracht, mogelijkheden & copingstrategieën

## Opiniestuk “Van energie naar kracht”

= legt uit dat veel vluchtelingen bij aankomst in een nieuw land veel motivatie & hoop hebben, migratie voelt voor velen als een nieuwe kans ih leven

- ➔ Die energie kan echter omslaan in frustratie wnr mensen onvoldoende kansen krijgen om een nieuw leven op te bouwen

## Belangrijke inzichten

Opvang en sociale contacten:

- Kleinschalige opvang werkt beter dan grote geïsoleerde centra
- Contact met de samenleving helpt integratie
- Langdurige isolatie kan psychische problemen versterken

Taal:

- ➔ Perfect taalgebruik verwachten kan uitsluiting veroorzaken
- ➔ Taal moet vooral een middel zijn om contacten op te bouwen & zich te ontw

Werk zorgt voor:

- Zelfvertrouwen
- Integratie
- Zelfstandigheid
- Gevoel iets bij te dragen ad samenleving

Negatieve beeldvorming:

- ➔ Vluchtelingen worden vaak bekeken vanuit tekorten & kwetsbaarheid -> daardoor blijven ze soms gezien worden als “anders”, ook wnr ze goed geïntegreerd zijn

Sociaal werkers = kunnen brug vormen tss vluchtelingen & hulpverlening. Belangrijk daarbij is:

- Luisteren zonder oordeel
- Begrip tonen voor de leefwereld vd persoon
- Responsief handelen



#### 4. Verhuis naar woonzorgcentrum

Veel oudere volwassenen stellen een verhuis naar woonzorgcentrum zo lang mogelijk uit

- ➔ Maatschappelijk wordt thuis blijven wonen sterk aangemoedigd, bijvoorbeeld via thuiszorg, mantelzorg & hulpmiddelen zoals trapliften, alarmknoppen en zorgtechnologie

#### Negatief beeld van woonzorgcentra

Doordat mensen langer thuis blijven wonen, zijn bewoners van WZC's vandaag vaak zorgbehoevender dan vroeger

- ➔ Hierdoor zien veel mensen een WZC als:
  - “De laatste halte”
  - Een plaats waar men pas terechtkomt wanneer andere opties uitgeput zijn
- ➔ Ook het financiële kostenplaatje zorgt ervoor dat mensen de verhuis uitstellen

38% van 60-plussers heeft een negatief beeld van WZC's

- ➔ Dat beeld komt vooral voor bij mensen die nooit in een WZC komen of niemand kennen die er verblijft
- ➔ Mensen die wel regelmatig op bezoek gaan of er vrijwilligen, hebben meestal een positievere kijk

Belangrijk voor toekomstige bewoners zijn:

- Behoud van zelfstandigheid
- Een thuisgevoel
- Verbondenheid met medebewoners & personeel

#### Verlieservaringen bij de verhuis

Veel oudere volwassenen brengen jarenlang veel tijd thuis door, zeker na pensionering of bij verminderde mobiliteit

De verhuis naar een WZC betekent vaak:

- Afscheid nemen van vertrouwde omgeving
- Afstand doen van persoonlijke spullen
- Minder persoonlijke ruimte
- ➔ Dat kan sterk als verlies ervaren worden: welke spullen hou je? Wat geef je weg? Wat willen kinderen of kleinkinderen nog meenemen?
- ➔ De overstap van private woning naar gemeenschappelijke ruimtes is groot

#### Verlies van autonomie

Thuis wonen geeft vaak een gevoel van controle & autonomie:

- Zelf bepalen wat je eet
- Mensen uitnodigen wanneer je wil
- Eigen routines behouden
- Inrichting kiezen volgens eigen smaak

In een WZC moet men zich aanpassen aan:

- Vaste maaltijden
- Gedeelde leefruimtes
- Regels rond bezoek
- Minder privacy
- ➔ Hoewel veel WZC's inzetten op keuzevrijheid, blijven bepaalde zaken door anderen bepaald
- ➔ Ook financiële afhankelijkheid kan moeilijk zijn, bijvoorbeeld wanneer kinderen facturen moeten regelen

#### Dementie en onbegrepen gedrag

Bij ouderen met dementie of vergeetachtigheid kan een verhuis zeer ontregelend zijn

- ➔ De vertrouwde omgeving verdwijnt en maakt plaats voor een onbekende omgeving, nieuwe mensen & verwarrende situaties

Dit kan leiden tot:

- Desoriëntatie in tijd & ruimte
- Angst en onrust
- Meer vergeetachtigheid

Sommige bewoners vertonen dan gedrag dat moeilijk te begrijpen is:

- ➔ Proberen weg te lopen, roepen & agressief gedrag = onbegrepen gedrag

### **Impact op familie en mantelzorgers**

Stressfactoren:

- Gesprekken voeren over de opname
- Financiële regelingen
- Praktische organisatie vd verhuis

Familieleden kunnen:

- Twijfelen aan de beslissing
- Zich schuldig voelen
- Bang zijn dat ze “niet genoeg gedaan hebben”

Er kan ook conflict ontstaan binnen de familie, bv wnr:

- Kinderen opname noodzakelijk vinden
- Een partner thuis wil blijven zorgen

De verhuis maakt vaak deel uit van langer rouwproces:

- ➔ Rollen veranderen, kinderen zorgen voor ouders, oude gewoontes verdwijnen

### **Culturele verschillen**

Er is steeds meer aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond in WZC's.

- ➔ Bij eerstegeneratiemigranten spelen vaak cultuur, religie, gewoonten, herinneringen aan land v herkomst een grote rol in welbevinden

### **Verschillen in kijk op zorg**

Onderzoek toont aan dat oudere volwassenen met een migratieachtergrond:

- Vaker bezorgd zijn om zorgbehoevend te worden
- Minder snel professionele hulp inschakelen
- Vaker rekenen op familie zorg

90% vd niet-Belgen ziet zorgen voor ouders als een morele plicht

- ➔ In sommige culturen wordt professionele hulp dus zo lang mogelijk vermeden en krijgt familiale zorg een zeer belangrijke plaats

### **Veerkracht bij ouderen**

#### Individuele veerkracht

= persoonlijke mogelijkheden vd oudere zelf om met uitdagingen, verliezen & veranderingen om te gaan

- Optimisme
- Doorzettingsvermogen
- Flexibiliteit
- Emotieregulatie

- Zelfvertrouwen
- Probleemoplossende vaardigheden

### Interactionele veerkracht

= veerkracht die ontstaat in relatie met anderen & de omgeving

- Sociale steun geven & ontvangen
- De name ad maatschappij
- Verbondenheid met anderen
- Erkenning krijgen & geven
- Betekenisvolle relaties

## **5. Ouder worden/zijn**

De 2<sup>e</sup> levenshelft gaat vaak gepaard met verschillende verlieservaringen & grote veranderingen

### **Lichamelijke veranderingen en beperkingen**

- Verminderde mobiliteit
- Afhankelijk worden v hulp
- Chronische pijn
- Bedlegerigheid.

Voor veel ouderen is het moeilijk om:

- Hulpbehoevend te worden
- Afhankelijk te zijn v anderen

Ook uiterlijke veranderingen kunnen een impact hebben:

- Ouder worden zichtbaar id spiegel
- Verlies v jong uiterlijk
- Veranderingen in lichaamsbeeld

Voor mensen die veel belang hechtten aan uiterlijk kan dit emotioneel zwaar zijn

### **Pensionering**

Voor sommigen betekent pensioen:

- ➔ Vrijheid, rust, meer tijd voor hobby's & familie

Voor anderen brengt het uitdagingen mee:

- Zoeken nr een nieuwe daginvulling
- Verlies v structuur
- Verlies v doel of identiteit

Werk biedt vaak meer dan alleen inkomen:

- Sociaal contact
- Cc met jongere generaties
- Erkenning
- Steun v collega's

Daarnaast moet men soms leren loslaten:

- ➔ Plaats maken voor jongere collega's & accepteren dat anderen zaken anders aanpakken

### **Familiale veranderingen**

Lege nestfase = Kinderen verlaten het ouderlijk huis, wat kan leiden tot:

- ➔ Verdriet, een gevoel v leegte & veranderingen binnen de partnerrelatie

Grootouderschap kan:

- ➔ Vreugde & betekenis geven, maar soms ook nieuwe verantwoordelijkheden meebrengen

Langdurige partnerrelatie vraagt:

- Aanpassing
- Omgaan met veranderingen bij elkaar
- Zorg opnemen voor elkaar

### **Verandering in maatschappelijke rol**

Sommige ouderen ervaren dat ze door de maatschappij als “minder waardevol” worden gezien

- ➔ Dit kan leiden tot gevoelens v uitsluiting, minder erkenning & het gevoel niet meer mee te tellen
- ➔ Ouderen krijgen soms te maken met stereotypen over ouderdom

### **Verhuizing**

Veel ouderen worden op hoge leeftijd geconfronteerd met een verhuis:

- ➔ Nr een serviceflat of nr een woonzorgcentrum

Vaak gebeurt dit niet vrijwillig, maar uit noodzaak door:

- ➔ Gezondheidsproblemen, zorgbehoefte, verlies v zelfstandigheid

Zo'n verhuis kan een grote verlieservaring zijn:

- Afscheid vd vertrouwde thuis
- Verlies v autonomie
- Aanpassen ae nieuwe omgeving

### **Overlijden van geliefden**

Naarmate mensen ouder worden, worden ze vaker geconfronteerd met verlies door overlijden:

- ➔ Partner, familieleden, vrienden, kennissen

De reactie op betekenisvol verlies noemen = rouw

Kenmerken v rouw

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ontkenning            | - Schuldgevoelens      |
| - Verdriet              | - Agressieve gevoelens |
| - Depressieve gevoelens | - Angst                |

Herhaald verlies op oudere leeftijd kan een sterke invloed hebben op:

- ➔ Mentale gezondheid, gevoelens v eenzaamheid, algemeen welbevinden

## **6. Palliatieve zorg**

= benadering die kwaliteit v leven verbetert v patiënten & hun families die te maken hebben met problemen die gepaard gaan met levensbedreigende ziekten, door het voorkomen & verlichten v lijden via vroege herkenning, zorgvuldige beoordeling & behandeling v pijn & andere problemen – fysiek, psychosociaal & spiritueel

- ➔ Biedt verlichting v pijn & andere belastende symptomen
- ➔ Bevestigt het leven & beschouwt sterven als een normaal proces
- ➔ Heeft niet als doel de dood te bespoedigen of uit te stellen
- ➔ Integreert psychologische & spirituele aspecten v zorg
- ➔ Biedt ondersteunend systeem om patiënten te helpen zo actief mogelijk te leven tot ad dood

Psychologische symptomen komen zeer vaak voor bij mensen in palliatieve zorg

- ➔ Ze zijn moeilijker te herkennen dan fysieke klachten & zorgen vaak voor discussie over wat “normaal” is en wat behandeling vraagt

Psychosociale aspecten vd zorg voor stervenden, ongeacht diagnose, omvatten behoefte aan:

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Begrip         | v symptomen, de aard vd ziekte & het stervenproces            |
| Acceptatie     | ongeacht stemming, sociale vaardigheden of uiterlijk          |
| Zelfrespect    | betrokkenheid bij besluitvorming                              |
| Veiligheid     | gevoel v geborgenheid                                         |
| Erbij horen    | de wens om zich nodig te voelen & geen last te zijn           |
| Liefde         | uitingen v genegenheid & menselijk cc zoals aanraking         |
| Spiritualiteit | een verklaring v betekenis & doel, religieus & niet-religieus |
| Hoop           | op verbetering in welk aspect v hun leven of bestaan dan ook  |

Belangrijk idee

- Verdriet, angst, stress & depressie kunnen tegelijk aanwezig zijn
- Depressie is geen normaal onderdeel v sterven
- Mensen mogen niet alleen gelaten worden met hun psychisch lijden

### Wat is normaal?

Wanneer iemand hoort dat hij ongeneeslijk ziek is, zijn emoties zoals:

- Verdriet
- Slechter slapen
- Huilen
- Veranderde eetlust
- Angst

een normale reactie op verlies & naderend afscheid = rouwreactie

- ➔ Toch is het soms moeilijk om het verschil te zien tss:
  - Normale rouw
  - Angst
  - Een depressieve stoornis
- ➔ Culturele & persoonlijke overtuigingen spelen hierbij een grote rol

### Ervaring van de patiënt

Mensen in palliatieve zorg krijgen te maken met:

- Slecht nieuws
- Veranderingen binnen gezin & relaties
- Lichamelijke klachten
- Verlies v controle
- Veel medische afspraken
- Angst voor achteruitgang & dood
- Onzekerheid

Daarnaast kunnen ook:

- Werk
- Financiën
- Sociale contacten
- Rollen bij het gezin

sterk veranderen

- ➔ Veel mensen zoeken daarom nr betekenis, controle, hoop & een nieuw doel ih leven

### Distress (psychische spanning)

Psychische klachten kunnen zich op verschillende manieren tonen:

- Lichte stress
- Ernstige angst

- Overweldigende emotionele spanning

Soms uit psychische spanning zich vooral via lichamelijke klachten

Belangrijk is:

- ➔ De ervaring vd patiënt begrijpen
- ➔ Aandacht hebben voor lichamelijke, sociale, emotionele & spirituele factoren

## Demoralisatie

- Verlies v hoop
- Verlies v betekenis
- Zich gevangen voelen
- Neerslachtigheid
- Het gevoel een last te zijn

Het komt vaak voor bij:

- Chronische ziekte
- Afhankelijkheid
- Sociaal isolement
- Verlies v waardigheid

Behandeling = vooral psychologische ondersteuning:

- Cognitieve gedragstherapie
- Acceptance and commitment therapy
- Mindfulness.

## Angst

Angst is zeer begrijpelijk bij mensen die het levenseinde naderen, ze zijn vaak bang voor:

- De dood
- Het stervensproces
- Pijn
- Verlies v controle
- Impact op familie

Mogelijke lichamelijke signalen

- Hartkloppingen
- Zweten
- Misselijkheid
- Beven
- Kortademigheid

Er moet ook aandacht zijn voor:

- Suïcidale gedachten
- Invloed v medicatie
- Alcohol- of druggebruik
- Slecht gecontroleerde pijn of andere symptomen

## Depressie

Depressie komt veel voor in palliatieve zorg

- ➔ Wordt vaak onvoldoende herkend & behandeld

Depressie beïnvloedt:

- Levenskwaliteit
- Sociale relaties
- Therapietrouw
- Symptoomcontrole

Mensen kunnen:

- Zich terugtrekken
- Zich waardeloos voelen
- Hoop verliezen
- Minder deelnemen aan zorg

Moeilijkheid bij diagnose = veel symptomen v depressie lijken op klachten v ernstige ziekte:

- Vermoeidheid
- Slaapproblemen
- Gewichtsverlies
- Concentratieproblemen

## Barrières om depressie te herkennen

Bij patiënten = spreken soms niet over hun emoties omdat:

- Ze niemand willen belasten
- Schaamte of stigma ervaren
- Denken dat verdriet “normaal” is

Bij hulpverleners = problemen:

- Onvoldoende opleiding
- Angst voor moeilijke gesprekken
- Onvoldoende herkenning v symptomen

## Assessment (beoordeling)

- ➔ Goede beoordeling start met luisteren, moeilijke vragen durven stellen, suïcidale gedachten bespreken

Belangrijke signalen v ernstige depressie:

- Aanhoudende sombere stemming
- Geen plezier meer ervaren
- Hopeloosheid
- Schuldgevoelens
- Sociale terugtrekking
- Doodswens

De “gouden standaard” blijft een uitgebreid klinisch gesprek

### Niet-medicamenteus

- Gesprekken & counseling
- Duidelijke informatie geven
- Sociale steun
- Familie betrekken
- Hoop & betekenis helpen zoeken

Ook kunnen helpen:

Levensverhaal bespreken

- Muziektherapie
- Massage
- Aromatherapie
- Ontspanningstechnieken

### Medicatie

- Antidepressiva
- Soms kortdurend benzodiazepines bij angst

Belangrijk:

- ➔ Vroeg genoeg starten + rekening houden met prognose & levenskwaliteit

## 7. Afscheid en verlies van een dierbare + artikel

### Levenseinde

A: het niet opstarten of stoppen van een zinloos geworden behandeling

- Medische wetenschap maakt steeds meer mogelijk maar dat betekent niet dan elke medische handeling altijd moet doorgevoerd worden
- Men kan ervoor kiezen om een behandeling niet op te starten of stoppen indien:
  - Behandeling niet langer zinvol of doeltreffend is
  - Behandeling de levenskwaliteit vd patiënt aantast
- Zo wordt therapeutische hardnekkigheid vermeden

## B: opdrijven van pijnstilling tijdens de stervenfasen en palliatieve sedatie

- Indien enorme pijn ah einde vh leven kan pijnstillende medicatie worden opgedreven om zo toch pijnvrij te kunnen overlijden
  - Het is wel mogelijk dat dit zonder bedoeling het stervenproces verkort
- Wnr lijden zo ernstig is kan er tegelijk met het verderzetten v medicatie gekozen worden om patiënt diep & continu te sederen —> communicatie belangrijk!
- Palliatieve sedatie wordt ook het verlichten vh stervenproces genoemd

## C: euthanasie

= het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op uitdrukkelijke vraag vd patiënt die zelf ok aan aantal voorwaarden voldoen:

- Meerderjarig of de wilsbekwame minderjarige (met uitdrukkelijke toestemming vd wettelijke vertegenwoordigers vd wilsbekwame minderjarige patiënt)
- Handelingsbekwaam (wilsbekwaam)
- Ondraaglijk fysiek of psychisch lijden (de verruiming vd wet v 28/02/14 stelt dat er bij de wilsbekwame minderjarige sprake dient te zijn v ondraaglijk "fysiek" lijden)
- Vrijwillig, duurzaam & aanhoudend verzoek uitgaande vd patiënt zélf (schriftelijk verzoek) & voor de wilsbekwame minderjarige patiënt geldt bovendien "en met uitdrukkelijke toestemming vd wettelijke vertegenwoordigers"
- Een medisch uitzichtloze (ongeneeslijke) aandoening hebben:
  - Terminale aandoening (verplichte raadpleging ve 2de arts & voor de wilsbekwame minderjarige bovendien verplichte advies ve kinder- / jeugdpsychiater of een psycholoog)
  - Niet terminale aandoening (verplichte raadpleging van een 2de én 3de arts\* én een maand wachttijd tss het schriftelijk verzoek en de uitvoering vd euthanasie) - uitsluitend v toepassing op meerderjarigen
- Voorafgaande wilsverklaring: enkel geldig bij onomkeerbare coma & niet v toepassing voor de wilsbekwame minderjarige

## D: levenseinde zonder wettelijk kader

**Hulp bij zelfdoding** waarbij de arts een dodelijk middel geeft of voorschrijft aan iemand met een ernstig gezondheidsprobleem. De patiënt neemt dit middel in op een tijdstip dat hij/zij zelf bepaalt en waarbij de arts verder niet betrokken wordt. Hulp bij zelfdoding is echter tot op vandaag niet wettelijk

**Levensbeëindiging zonder verzoek**, is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere zonder uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene. Hiervan kan zeer uitzonderlijk sprake zijn bij een ernstig en onbehandelbaar lijden van een wilsbekwame patiënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een diep demente patiënt waarbij de arts doelbewust en disproportioneel de medicatie opdrijft. Hoewel men dit handelen soms als 'barmhartige stervenshulp' omschrijft wordt deze vorm van levensbeëindiging juridisch met doodslag of moord gelijkgesteld.

## **Inleiding**

Dit onderzoek v Bonanno et al. gaat over de vraag hoe mensen omgaan met het verlies ve partner. Lange tijd werd gedacht dat intense rouw een normale & bijna onvermijdelijke reactie is na een overlijden. Volgens klassieke rouwmodellen zou iemand eerst veel verdriet ervaren & daarna geleidelijk herstellen. Het artikel toont echter dat rouw veel complexer & individueler verloopt.

De onderzoekers wilden:

- Nagaan welke verschillende rouwpatronen bestaan na partnervlies
- Onderzoeken welke factoren vóór het overlijden samenhangen met die reacties



- Bekijken of “weinig zichtbare rouw” echt problematisch is

Belangrijk:

- ➔ Het onderzoek focust sterk op resilience = mensen die ondanks het verlies relatief stabiel blijven functioneren
- ➔ De auteurs bekritiseren het idee dat iedereen intens moet rouwen om gezond te verwerken

## Methode

= prospectieve longitudinale studie

- ➔ Deelnemers werden al onderzocht vóór het overlijden v hun partner & daarna opnieuw opgevolgd

Deelnemers

- 205 oudere volwassenen
- Allemaal hadden ze een ernstig zieke partner
- Men volgde hen:
  - Vóór het overlijden
  - 6 maanden na het overlijden
  - 18 maanden na het overlijden

Wat onderzochten ze? Ze bekeken onder andere:

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| - Depressieve klachten       | - Copingstijl      |
| - Gevoelens v rouw           | - Wereldbeeld      |
| - Persoonlijkheid            | - Relatiekwaliteit |
| - Afhankelijkheid vd partner |                    |

Sterkte vh onderzoek

= omdat mensen al vóór het overlijden onderzocht werden, konden onderzoekers beter onderscheiden:

- Chronische depressie
  - Normale rouw
  - Langdurige rouwreacties
- ➔ Dat maakt deze studie methodologisch erg sterk

## Resultaten

Verschillende rouwpatronen, de onderzoekers vonden meerdere trajecten v rouw:

Resilience (meest voorkomend):

- |                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| - Ongeveer 46%                                | - Konden emoties reguleren    |
| - Mensen bleven relatief stabiel functioneren | - Bleven sociaal functioneren |
| - Weinig depressieve klachten                 |                               |

Common grief = dit patroon kwam veel minder vaak voor dan vroeger gedacht:

- Klassieke rouwreactie
- Eerst sterke verdrietreacties
- Daarna geleidelijk herstel

Chronic grief:

- Langdurige intense rouw
- Veel verdriet en depressieve gevoelens
- Moeilijk herstel

Deze groep:

- ➔ Was vaak sterk afh. v. partner
- ➔ Had meer angst om de partner te verliezen

Chronic depression:

- Mensen die al vóór het overlijden depressief waren
- Klachten bleven bestaan na het verlies

= niet alle psychische problemen na verlies zijn “rouw”

Depressed-improved:

- ➔ Kleine groep
- ➔ Voelde zich na het overlijden psychisch beter
- ➔ Mogelijke verklaring = de zorgsituatie vóór het overlijden was zeer belastend

Delayed grief = bijna niet gevonden:

- ➔ Dus = het idee dat mensen pas veel later beginnen rouwen kreeg weinig steun

Factoren die samenhangen met resilience

Mensen met een resiliënt patroon:

- Konden de dood beter aanvaarden
- Hadden minder emotionele afhankelijkheid
- Hadden vaker een stabiel wereldbeeld
- Geloofden vaker dat de wereld begrijpbaar/rechtvaardig is

Belangrijk = mensen met weinig zichtbare rouw waren niet koud, ongehecht of emotioneel afstandelijk

- ➔ Dat stereotype wordt dus weerlegd

## **Discussie**

De auteurs besluiten dat:

- Er geen “juiste” manier van rouwen bestaat
- Intense zichtbare rouw niet noodzakelijk nodig is voor verwerking
- Veel mensen ondanks groot verlies toch veerkracht tonen

Het artikel benadrukt dat hulpverleners voorzichtig moeten zijn met:

- Het pathologiseren v. normale reacties
- Verwachtingen opleggen over hoe iemand “moet” rouwen

= rouw is zeer individueel

## **Belangrijk om te kennen voor het examen**

- Resilience is het meest voorkomende patroon
- Common grief komt minder vaak voor dan gedacht
- Delayed grief werd amper gevonden
- Dependency hangt samen met chronic grief
- Preloss factoren zijn heel belangrijk

Sterke punten v. onderzoek:

- Prospectief onderzoek
- Deelnemers werden vóór het overlijden al onderzocht
- Meerdere meetmomenten

Belang van artikel = veranderde sterk hoe men vandaag naar rouw kijkt:

- ➔ Minder focus op “iedereen moet intens rouwen”
- ➔ Meer aandacht voor individuele verschillen & veerkracht

## Hoorcollege 6: omgaan met life events

### 1. Area model

AREA-model werd ontw door Wilson en Gilbert & beschrijft hoe mensen omgaan met life events en emotionele gebeurtenissen

- Attent = aandacht richten op de gebeurtenis
- React = eerste emotionele reactie op de gebeurtenis
- Explain = proberen betekenis te geven aan wat gebeurd is
- Adapt = aanpassen ad nieuwe situatie

Centrale gedachte vh model = betekenisgeving is cruciaal is

- ➔ Mensen proberen te begrijpen wrm iets gebeurd is & wat het betekent voor hun leven
- ➔ Hoe beter iemand betekenis kan geven ae gebeurtenis, hoe makkelijker de aanpassing verloopt

#### Attent

Bij een life event gaat de aandacht automatisch nr de gebeurtenis = hoe belangrijker of schokkender het event, hoe sterker de aandacht erop gericht blijft

- Mensen denken er veel aan
- Gebeurtenis krijgt emotionele aandacht
- Vooral onverwachte of ingrijpende gebeurtenissen nemen veel mentale ruimte in

#### React

Daarna volgt een eerste reactie & dit kan:

- Emotioneel zijn (verdriet, angst, boosheid, opluchting...)
- Lichamelijk zijn (stressreacties, spanning...)
- Cognitief zijn (piekeren, verwarring...)

Intensiteit vd reactie verschilt v persoon tot persoon

#### Explain

= volgens het model de belangrijkste fase, mensen proberen:

- Betekenis te geven aan het life event
  - Te begrijpen waarom het gebeurd is
  - Het in hun levensverhaal te plaatsen
- ➔ Wnr iemand een verklaring vindt die logisch aanvoelt, vermindert meestal de emotionele impact

#### Adapt

Na verloop v tijd probeert iemand zich aan te passen ad nieuwe situatie:

- Een nieuw evenwicht zoeken
  - Leren omgaan met veranderingen
  - De gebeurtenis integreren ih dagelijkse leven
- ➔ Adaptatie betekent niet dat het verlies of de gebeurtenis “verdwijnt”, maar wel dat iemand verder leert functioneren

## Factoren die betekenisgeving beïnvloeden

### Hoe nieuw de ervaring is

- ➔ Hoe nieuwer een gebeurtenis, hoe moeilijker betekenisgeving vaak verloopt & hoe meer vragen iemand heeft

### Bij herhaalde ervaringen:

- Verloopt betekenisgeving sneller
- Weet iemand beter wat te verwachten
- Raakt men meestal minder lang uit balans
- ➔ Eerdere ervaringen helpen dus latere coping

### De mate van variatie

### Hoe meer een gebeurtenis lijkt op eerdere ervaringen:

- Hoe makkelijker iemand ze kan plaatsen
- Hoe minder intens het zoekproces naar betekenis vaak is

= gelijkaardige ervaringen zorgen voor herkenbaarheid

### Hoe onverwacht de gebeurtenis is

### Onverwachte gebeurtenissen:

- ➔ Zijn moeilijker te verwerken
- ➔ Geven minder tijd op mentale voorbereiding
- ➔ Verstoren het gevoel v controle sterker

= daardoor verloopt aanpassing vaak moeilijker

### De mate van zekerheid

### Onzekerheid maakt betekenisgeving moeilijker

- ➔ Bijvoorbeeld: niet weten hoe een situatie zal aflopen of onduidelijkheid over de toekomst

### Dit kan leiden tot:

- Uitstel van verwerking
- Blijvende stress
- Piekeren
- ➔ Zekerheid helpt mensen om emotioneel te verwerken

### Verklarende coherentie

### Sommige gebeurtenissen zijn makkelijker te verklaren dan andere.

- ➔ Wnr iets logisch, begrijpbaar, of verklaarbaar lijkt, dan is de impact vaak korter

### Moeilijk verklaarbare gebeurtenissen:

- Blijven langer emotioneel doorwerken
- Kunnen meer verwarring oproepen

### Persoonlijke attributie

### Manier waarop iemand oorzaken toeschrijft beïnvloedt de verwerking, mensen stellen zich vragen zoals:

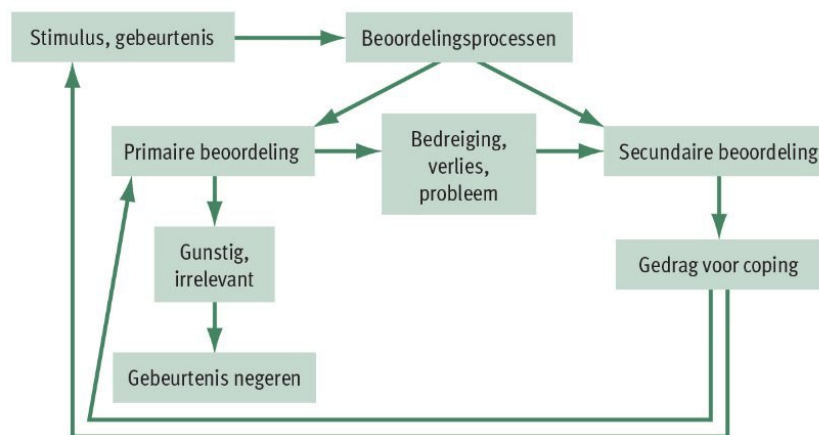
- “Ligt het aan mij?”
- “Had ik dit kunnen voorkomen?”
- “Waarom overkomt mij dit?”

Deze interpretaties beïnvloeden:

- Emoties
- Coping
- Betekenisgeving
- Aanpassing aan life events

➔ Negatieve zelfattributies kunnen verwerking bemoeilijken

## 2. Transactionele theorie



FIGUUR 10.1 Het eerste transactionele stressmodel van Lazarus

Bron: Vrij naar Lovallo, 1997

### Transactionele theorie van stress (Lazarus)

= stelt dat stress niet ontstaat door een gebeurtenis zelf, maar door de manier waarop iemand die gebeurtenis beoordeelt

- ➔ Stress = resultaat van voortdurende wisselwerking (transactie) tuss de persoon en omgeving
- ➔ Twee mensen kunnen dezelfde gebeurtenis meemaken, maar toch totaal verschillende hoeveelheid stress ervaren

Voorbeeld:

- ➔ Een examen kan voor de ene student een bedreiging zijn & voor een andere student kan hetzelfde examen een uitdaging zijn

#### Primaire beoordeling (Primary appraisal)

Bij de primaire beoordeling stelt iemand zichzelf de vraag:

- ➔ “Wat betekent deze gebeurtenis voor mij?”

= men beoordeelt of de situatie belangrijk is voor het eigen welzijn

Er zijn drie mogelijke beoordelingen:

#### Schade of verlies

= er is al iets verloren gegaan of beschadigd

Voorbeelden:

- Ontslag
- Overlijden van een dierbare
- Relatiebreuk

### *Bedreiging*

= men verwacht dat er in toekomst iets negatiefs zal gebeuren

Voorbeelden:

- Bang zijn voor een examen
- Angst voor een operatie
- Vrees voor ontslag

### *Uitdaging*

= men ziet de situatie als moeilijk, maar denkt dat men ze aankan

Voorbeelden:

- Starten met een nieuwe job
- Beginnen aan een opleiding
- Verhuizen

Een gebeurtenis die niet als belangrijk wordt gezien, veroorzaakt meestal geen stress

### Secundaire beoordeling (Secondary appraisal)

= na de eerste beoordeling bekijkt iemand welke middelen beschikbaar zijn om met situatie om te gaan

Vragen die hierbij gesteld worden:

- Kan ik dit aan?
- Wie kan mij helpen?
- Welke mogelijkheden heb ik?
- Heb ik voldoende kennis of vaardigheden?

Interne hulpbronnen:

- Zelfvertrouwen
- Doorzettingsvermogen
- Ervaring
- Probleemoplossende vaardigheden

Externe hulpbronnen:

- Sociale steun
- Professionele hulp
- Familie en vrienden
- Financiële middelen

Hoe meer hulpbronnen iemand ervaart, hoe minder stress doorgaans wordt ervaren

### Wanneer ontstaat stress?

- ➔ Een situatie als belangrijk en bedreigend wordt beoordeeld
- ➔ Iemand denkt onvoldoende middelen te hebben om ermee om te gaan

Formule:

- Hoge eisen + weinig hulpbronnen = veel stress
- Hoge eisen + voldoende hulpbronnen = minder stress

Stress is dus geen eigenschap van de gebeurtenis zelf, maar vd beoordeling ervan

### **Smith & Lazarus: emoties als gevolg van beoordelingen**

= werkten de theorie verder uit & stelden dat verschillende emoties ontstaan uit verschillende combinaties v beoordelingen

### Motivationale relevantie

Hier beoordeelt iemand:

- ➔ Hoe belangrijk is deze gebeurtenis voor mijn doelen, waarden & behoeften?
- ➔ Hoe belangrijker de gebeurtenis, hoe sterker de emotionele reactie

Voorbeeld:

- ➔ Een examen dat bepaalt of je afstudeert → hoge relevantie

#### Motivationele congruentie

= hier bekijkt men of de gebeurtenis overeenkomt met eigen doelen

- Hoge congruentie = de gebeurtenis helpt om doelen te bereiken.
  - Positieve emoties
- Lage congruentie = de gebeurtenis verhindert het bereiken v doelen
  - Negatieve emoties & stress

Voorbeeld:

- ➔ Je wil slagen maar behaalt een slecht resultaat

#### Verantwoordelijkheid

= men probeert te bepalen wie verantwoordelijk is voor de situatie

- ➔ Anderen verantwoordelijk = woede, frustratie
- ➔ Jezelf verantwoordelijk = schuldgevoelens, schaamte

#### Probleemgerichte copingmogelijkheden

= hier beoordeelt iemand of de situatie nog veranderd kan worden

- ➔ Situatie lijkt veranderbaar = hoop, optimisme
- ➔ Situatie lijkt niet veranderbaar = angst, machteloosheid

#### Emotiegerichte copingmogelijkheden

= hier beoordeelt iemand of hij of zij de emoties aankan

- ➔ Voldoende vertrouwen = minder stress
- ➔ Weinig vertrouwen = meer angst & spanning

#### Toekomstverwachting

= de verwachtingen over de toekomst beïnvloeden eveneens emoties

- ➔ Positieve verwachting = hoop
- ➔ Negatieve verwachting = verdriet, wanhoop

### **Coping**

= verwijst naar alle inspanningen die iemand levert om met een stressvolle situatie om te gaan

- ➔ Na primaire & secundaire beoordeling kiest iemand een copingstrategie

#### Probleemgerichte coping

= men probeert het probleem rechtstreeks aan te pakken

- ➔ Doel = de situatie veranderen

Voorbeelden:

- Studeren voor een examen
- Planning maken
- Informatie verzamelen
- Hulp organiseren

#### Emotiegerichte coping

= men probeert de emoties die door de situatie ontstaan te reguleren

- ➔ Doel = beter omgaan met emoties



Voorbeelden:

- Praten met vrienden
- Huilen
- Ontspanning zoeken
- Gevoelens uiten

#### Vermijdende coping

= men probeert de situatie of gevoelens tijdelijk te vermijden

➔ Deze strategie kan tijdelijk helpen maar lost het probleem meestal niet op

Voorbeelden:

- Ontkennen
- Afleiding zoeken
- Uitstellen

#### **Welke gebeurtenissen worden sneller als stressvol ervaren?**

- Op handen zijn = de gebeurtenis komt zeer dichtbij
  - Voorbeeld: examen morgen
- Onverwacht zijn = men had de gebeurtenis niet zien aankomen
  - Voorbeeld: plots overlijden
- Onvoorspelbaar zijn = men weet niet wat er zal gebeuren
  - Voorbeeld: ontslag
- Onduidelijk zijn = er is onzekerheid over de persoonlijke rol, mogelijke gevolgen, risico's
- Ongewenst zijn
  - Voorbeeld: gedwongen verhuis
- Niet controleerbaar zijn = men heeft het gevoel geen invloed te hebben
  - Voorbeeld: ernstige ziekte, luidruchtige burens
- Grote levensveranderingen veroorzaken
  - Voorbeelden: eerste kind, verhuis, nieuwe job, scheiding

#### **Kritiek op de theorie van Lazarus**

##### Onduidelijke relatie tussen beoordelingen

= het is niet altijd duidelijk hoe primaire & secundaire beoordeling precies samenhangen

##### Mogelijk cirkelredenering

= sommige onderzoekers vinden dat het model moeilijk te testen is

➔ Stress wordt verklaard door copingmogelijkheden, terwijl copingmogelijkheden deels worden afgeleid uit hoeveel stress iemand ervaart

##### Stress ontstaat niet altijd door onvoldoende hulpbronnen

= onderzoek toont dat stress soms ook kan ontstaan wnr iemand voldoende copingmogelijkheden heeft

➔ Alleen het feit dat een gebeurtenis heel belangrijk is, kan soms al voldoende zijn om stress op te wekken

##### Meer onderzoek nodig

= onderzoekers geven aan dat de interactie tss:

- Primaire beoordeling
- Secundaire beoordeling
- Coping

nog verder onderzocht moet worden

### 3. Sense of coherence

Sense of coherence-model (SOC) v Aaron Antonovsky stelt dat er 3 elementen zijn die bijdragen ad mogelijkheid v mensen om met life events & de daaraan gerelateerde stress om te gaan

= globale levensoriëntatie die bepaalt hoe iemand de wereld & zijn ervaringen ziet

#### **Comprehensability = begrijpelijkheid**

- ➔ De mate waarin mensen hun leven als begrijpelijk ervaren (Ik begrijp/ snap waarom dit gebeurt)

#### **Manageability = hanteerbaarheid**

- ➔ De ervaring dat het leven hanteerbaar is
- ➔ Gevoel dat je voldoende middelen & hulpbronnen hebt om met uitdagingen om te gaan
- ➔ Je hebt de ervaring dat je eigen & je externe hulpbronnen in evenwicht zijn met de eisen v/h leven
- ➔ Ik heb de vaardigheden, steun & tijd om dit aan te pakken

#### **Meaningfulness = betekenisvolheid**

- ➔ In hoeverre ervaar je de stressor of life event als betekenisvol, als de moeite waard om mee om te gaan?
- ➔ Dit is belangrijk dus ik wil ervoor gaan

### 4. Palliatief palet

#### **Palliatief palet**

= concept ontw door Michael Portzky binnen de context v coping & veerkracht

- ➔ Woord palliatief betekent hier verzachtend

Palliatieve activiteit:

= activiteit die ervoor zorgt dat negatieve gevoelens, stress of gepieker tijdelijk onderbroken worden

- ➔ De activiteit vraagt zoveel aandacht dat iemand even minder bezig is met zijn problemen & hierdoor kan de stressbalans opnieuw meer in evenwicht komen

Palliatief palet:

= omvat alle activiteiten die iemand gebruikt om spanning te verminderen & zich beter te voelen

- ➔ Werkt preventief & helpt voorkomen dat stress zich opstapelt

#### **Het palliatief palet als continuüm**

- ➔ Palliatief palet bestaat uit brede waaier aan activiteiten
- ➔ Niet alle activiteiten zijn even gezond of even wenselijk
- ➔ Portzky beschrijft continuüm dat v zeer positieve activiteiten tot zeer destructieve activiteiten

#### Positieve palliatieve activiteiten

= activiteiten die ontspanning bieden & bijdragen ah welzijn

Voorbeelden:

- |                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Sporten          | - Hobby's uitvoeren               |
| - Wandelen         | - Film kijken                     |
| - Lezen            | - Sociale cc onderhouden          |
| - Muziek luisteren | - Ontspannen met vrienden/familie |

- Muziek maken

Deze activiteiten:

- Verminderen stress
- Laden mentale batterij opnieuw op
- ➔ Hoe meer positieve activiteiten iemand gebruikt, hoe beter stressbalans in evenwicht blijft
- Versterken het welzijn
- Verhogen de veerkracht

#### Minder gunstige palliatieve activiteiten

Sommige activiteiten zijn op zich positief, maar kunnen problematisch worden wnr ze extreem of dwangmatig uitgevoerd worden

Voorbeelden:

- Extreem veel sporten
- Dwangmatig masturberen
- Voortdurend vluchten in ontspanning zonder problemen aan te pakken

De activiteit dient dan niet langer als gezonde ontspanning, maar wordt een manier om moeilijke gevoelens of problemen te vermijden

#### Destructieve palliatieve activiteiten

Ah einde vh continuüm bevinden zich activiteiten die wel tijdelijk stress verminderen, maar ernstige negatieve gevolgen hebben

Voorbeelden:

- Alcoholmisbruik
- Druggebruik
- Automutilatie
- Zelfbeschadiging
- Risicogedrag
- Suïcidale gedachten
- Suïcideplanning
- ➔ Portzky beschouwt suïcideplanning als de meest destructieve palliatieve activiteit
- ➔ Bij sommige mensen werkt gedachte dat hun problemen binnenkort voorbij zullen zijn tijdelijk stressverlagend -> dit maakt de activiteit echter bijzonder gevaarlijk & zorgwekkend

### **De Utrechtse Coping Lijst (UCL)**

Portzky bespreekt de subschaal palliatief reactiepatroon uit de Utrechtse Coping Lijst (UCL)

Deze schaal bevat zowel:

- ➔ Positieve activiteiten (bv. sporten)
- ➔ Negatieve activiteiten (bv. meer drinken of roken)

= hierdoor ontstaat een probleem

Een hoge score kan betekenen dat iemand:

- Veel gezonde activiteiten uitvoert
- Veel destructieve activiteiten uitvoert
- Of een combinatie v beide gebruikt

= interpretatie vd score wordt daardoor moeilijk

- ➔ Portzky vindt dat deze schaal onvoldoende onderscheid maakt tss gezonde & ongezonde manieren om met stress om te gaan

### **De P3-schaal**

Om dit probleem op te lossen ontw Portzky de P3-schaal (Portzky's Palliatieve Paletschaal)

Doel:

- ➔ Het volledige palliatieve palet in kaart brengen
- ➔ Positieve & destructieve activiteiten v elkaar onderscheiden
- ➔ Een beter beeld krijgen van hoe iemand met stress omgaat

Bij de P3-schaal worden activiteiten geordend v:

- Meest positief
- Naar steeds destructiever

De persoon geeft aan hoe vaak hij of zij deze activiteiten uitvoert

#### Gezond profiel

Bij psychisch gezonde personen ziet men meestal:

- Veel positieve activiteiten
- Weinig destructieve activiteiten

De curve wordt nr het einde toe vlak -> dit wijst op:

- Een gezonde stressregulatie
- Voldoende ontspanning
- Een goede balans tussen spanning & herstel

#### Ongunstig profiel

Bij kwetsbare personen of psychiatrische patiënten ziet men vaker:

- Minder positieve activiteiten
- Meer destructieve activiteiten

Soms stijgt de curve zelfs naar het einde toe -> dit wijst op:

- Verhoogde psychische kwetsbaarheid
- Ongezonde coping
- Verhoogd risico op ernstige problemen

= dergelijk profiel wordt beschouwd als een belangrijk alarmsignaal

### **Verband tussen palliatief palet en veerkracht**

Er bestaat een duidelijke relatie tss veerkracht & het palliatief palet

#### Hoge veerkracht

- Gebruiken meer positieve palliatieve activiteiten
- Herstellen sneller v stress
- Beschikken over gezondere copingstrategieën

#### Lage veerkracht

- Gebruiken vaker destructieve palliatieve activiteiten
- Lopen meer risico op depressie
- Hebben meer psychische klachten
- Lopen meer risico burn-out
- Lopen meer risico op suïcidaal gedrag

Portzky stelt dat de relatie tss lage veerkracht & destructieve activiteiten bijzonder sterk is

### **Het belang van een gezond palliatief palet**

Volgens Portzky is een gezond palliatief palet één vd belangrijkste beschermende factoren voor mentale gezondheid

Negatieve gebeurtenissen zullen zich altijd voordoen

- Stress op het werk
  - Conflicten
  - Ziekte
  - Verlieservaringen
  - Financiële problemen
- ➔ Voor deze negatieve gebeurtenissen hoeft men meestal weinig moeite te doen; ze komen vanzelf.

Positieve activiteiten daarentegen vragen een bewuste investering

= mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontspanning & herstel

- ➔ Portzky benadrukt dat niemand anders ervoor zal zorgen dat jouw stressbalans in evenwicht blijft
- ➔ Wie zijn palliatief palet verwaarloost, krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd

## **Werk, stress en burn-out**

Portzky beschrijft hoe veel mensen onvoldoende investeren in ontspanning.

Dit ziet men vooral bij:

- Artsen
- Psychologen
- Verpleegkundigen
- Hulpverleners
- Zelfstandigen
- Vrije beroepen

Veel van deze mensen:

- Blijven werken ondanks ziekte
- Plaatsen hun eigen behoeften op de achtergrond
- Nemen weinig rust
- Stellen ontspanning uit

= presentisme = aanwezig blijven werken terwijl men eigenlijk ziek of uitgeput is

- ➔ Hierdoor ontstaat een onevenwicht tss belasting & herstel
- ➔ Dit verhoogt het risico op burn-out, psychische klachten & langdurige uitval

## **Palliatief palet bij psychiatrische patiënten**

Bij sommige psychiatrische patiënten ziet men een bijzonder wisselend patroon

Portzky beschrijft dit onder andere bij p met een borderline persoonlijkheidsstoornis:

- ➔ Wnr het goed gaat gebruiken zij vaak positieve activiteiten
- ➔ Wnr hun emotionele toestand verslechtert schakelen zij sneller over nr destructieve activiteiten
  - Zelfbeschadiging
  - Middelengebruik
  - Suïcidale gedachten

= belangrijk dat mensen leren herkennen wnr zij richting destructieve deel v hun palliatief palet evolueren

- ➔ Herkennen v deze waarschuwingssignalen kan helpen om tijdig hulp te zoeken

## **Palliatief palet en rouw**

Na een verlies trekken mensen zich vaak terug uit:

- ➔ Sociale contacten, hobby's, ontspannende activiteiten

Soms gebeurt dit omdat men denkt dat ontspanning niet past binnen een rouwproces

- ➔ Portzky waarschuwt hiervoor = rouw betekent niet dat iemand voortdurend verdrietig moet zijn

Positieve activiteiten:

- Verminderen de stressbelasting
- Helpen de draagkracht behouden
- Ondersteunen het herstelproces

= ontspanning & verdriet kunnen naast elkaar bestaan

### Rouw na langdurige ziekte

Wnr iemand jarenlang voor een zieke partner zorgt:

- ➔ Is het rouwproces vaak al vóór het overlijden begonnen
- ➔ Is er vaak sprake v langdurige belasting & stress

Na het overlijden kan een ontspannende activiteit soms zelfs als een vorm v opluchting ervaren worden

- ➔ Betekent niet dat men niet vd overledene hield, maar wel dat een lange periode v zorg & spanning ten einde komt

### Sociale versus emotionele eenzaamheid

Sociale eenzaamheid = een tekort aan sociale contacten

- ➔ Weinig mensen rondom zich
- ➔ Weinig sociale interacties
- ➔ Deze vorm v eenzaamheid kan vaak verminderen door meer sociale contacten, deelname aan activiteiten, uitbreiding vh netwerk

Emotionele eenzaamheid = het gemis van één specifieke persoon.

- ➔ Een overleden partner, een beste vriend, een zielsverwant
- ➔ Deze vorm v eenzaamheid is moeilijker op te lossen
- ➔ Meer sociale contacten nemen het gemis niet weg, drm moet hulpverlening rekening houden met specifieke vorm v eenzaamheid die iemand ervaart

### **Van kennis naar actie**

- ➔ Het is niet genoeg om boeken te lezen, info te verzamelen, te weten wat gezond is

Men moet de kennis ook daadwerkelijk toepassen

= positieve activiteiten moeten een vast onderdeel worden vh dagelijks leven

- ➔ Wie wacht tot hij volledig uitgeput is, heeft vaak veel meer inspanningen nodig om opnieuw in evenwicht te komen

### **Belangrijkste conclusie**

Palliatief palet verwijst nr alle activiteiten die iemand gebruikt om stress & negatieve gevoelens tijdelijk te verminderen

Een gezond palliatief palet:

- |                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| - Bevat voldoende positieve activiteiten | - Versterkt de veerkracht              |
| - Helpt de stressbalans herstellen       | - Beschermst tegen psychisch problemen |

Een ongezond palliatief palet:

- Bevat meer destructieve activiteiten
- Verhoogt het risico op burn-out, depressie en suïcidaliteit

Centrale boodschap v Portzky

= mensen moeten actief investeren in positieve palliatieve activiteiten, omdat deze een belangrijke buffer vormen tegen stress & bijdragen ae betere mentale gezondheid

## 5. Coping

### Wat is coping?

= de manier waarop mensen omgaan met stressvolle of ingrijpende gebeurtenissen

Volgens Lazarus & Folkman

- ➔ Ontstaat stress wnr iemand het gevoel heeft dat zijn draagkracht niet voldoende is om de eisen vd situatie (draaglast) aan te kunnen
- ➔ Coping zijn dan de bewuste inspanningen die iemand doet om die stress te verminderen.

Belangrijke kenmerken v coping:

- Cognitieve, emotionele & gedragsmatige reacties op een stressor
- Gericht op het verminderen v stress
- Dynamisch proces = coping verandert afhankelijk vd situatie
- Doelbewust & intentioneel
- Aangeleerd = eerdere ervaringen beïnvloeden hoe iemand later met stress omgaat
- Kan gericht zijn op de stressor zelf of op de emoties die de stressor oproept

### Stijlen van coping en strategieën voor coping

#### Probleemgerichte coping

= gericht op het probleem of de stressor zelf

Doel:

- ➔ De oorzaak vd stress aanpakken
- ➔ De situatie veranderen
- ➔ Meer controle krijgen

Voorbeelden:

- Informatie zoeken
- Een plan maken
- Problemen actief oplossen
- Praktische hulp zoeken
- Bron v stress rechtstreeks aanpakken

#### Emotiegerichte coping

= gericht op de emoties die door de stressor worden veroorzaakt

Doel:

- ➔ Negatieve gevoelens reguleren
- ➔ Emotioneel evenwicht herstellen

Voorbeelden:

- Emotionele steun zoeken
- Positieve herinterpretatie
- Acceptatie
- Emoties uiten
- Bidden
- Mediteren

#### Controlegerichte coping

= actieve coping

Doel:

- ➔ Controle krijgen over de situatie
- ➔ Het probleem aanpakken

Voorbeelden:

- Informatie verzamelen
- Actief oplossingen zoeken
- Actie ondernemen
- Plannen maken

### Vermijdende coping

= de stressor vermijden of minimaliseren

Doel = tijdelijk ontsnappen aan stress

Voorbeelden:

- Afleiding zoeken
- Niet aan het probleem denken
- Vermijden vd situatie
- Middelengebruik
- Weglopen vh probleem

### Betekenisgerichte coping

= betekenis proberen geven aan moeilijke gebeurtenis

Doel:

- ➔ Persoonlijke groei vinden in moeilijke situaties
- ➔ Nieuwe doelen & prioriteiten ontw
- ➔ Hoop behouden.

Voorbeelden:

- Zoeken nr lessen uit de gebeurtenis
- Nieuwe levensdoelen formuleren
- Positieve betekenis geven aan verlies/ziekte
- Posttraumatische groei ontw

### Belangrijke opmerking: flexibiliteit

- ➔ Er bestaat geen copingstijl die altijd de beste is
- ➔ Vaak worden probleemgerichte & emotiegerichte coping tegelijk gebruikt

= adaptieve coping betekent dat iemand flexibel kan wisselen tss verschillende strategieën afh v:

- De situatie
- De ernst vd stressor
- Eerdere ervaringen
- Eigen mogelijkheden

### **Functies van coping**

Volgens Cohen & Lazarus heeft coping vijf belangrijke functies:

|                                        |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schadelijke omstandigheden verminderen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De impact vd stressor proberen verkleinen</li> <li>• Het probleem aanpakken of beheersbaar maken</li> </ul>                           |
| Aanpassen aan negatieve gebeurtenissen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leren omgaan met moeilijke situaties</li> <li>• Gebeurtenis leren verdragen wnr ze niet veranderd kan worden</li> </ul>               |
| Positief zelfbeeld behouden            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelfvertrouwen beschermen</li> <li>• Gevoel v eigenwaarde behouden ondanks tegenslagen</li> </ul>                                     |
| Emotioneel evenwicht bewaren           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angst, verdriet, boosheid of spanning verminderen</li> <li>• Emotionele stress reguleren</li> </ul>                                   |
| Goede relaties behouden                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbonden blijven met anderen</li> <li>• Sociale steun behouden</li> <li>• Blijven functioneren binnen de sociale omgeving</li> </ul> |



## 6. Rouw (deel 1: inleiding & oudere modellen)

### Wat is rouw?

= normale reactie op verlies

➔ Het gaat niet alleen over het overlijden van dierbare, maar over elke betekenisvolle verlieservaring

Mensen kunnen rouwen om:

- Het verlies van dierbare
- Echtscheiding of relatiebreuk
- Verlies van job
- Verlies door omstandigheden zoals een verhuis
- Verlies van gezondheid

Bij rouw kunnen verschillende emoties voorkomen:

- Verdriet
- Jaloezie
- Onmacht
- Schuldgevoelens
- Eenzaamheid
- Angst
- Boosheid
- Opstandigheid

Belangrijk:

- ➔ Er bestaat geen juiste manier van rouwen
- ➔ Iedereen rouwt op zijn eigen manier
- ➔ De manier waarop iemand rouwt wordt beïnvloed door opvoeding, cultuur, religie & de omgeving

### Rouwen is iets wat je leert

Kinderen leren omgaan met verlies door:

- Hun ouders of zorgfiguren
- Bredere omgeving
- De reacties van familie
- Culturele & religieuze invloeden

Wie weinig leert omgaan met verlieservaringen, kan later sterker overweldigd worden door grote verliezen

Rouw wordt dus mee gevormd door:

- Opvoeding
- Religie
- Cultuur
- Maatschappelijke normen

### Het fasenmodel van Kübler-Ross

Volgens Kübler-Ross doorlopen mensen na een verlies vijf fasen om uiteindelijk tot aanvaarding te komen

#### Ontkenning

= de persoon wil of kan de realiteit nog niet onder ogen zien

- De waarheid afwijzen
- Beschermingsmechanisme tegen de pijn
- Tijd winnen om het verlies geleidelijk te verwerken
- "Dit kan niet waar zijn."

#### Protest of machteloze woede

= de persoon verzet zich tegen wat gebeurd is

- Woede
- Schuld geven aan anderen
- Frustratie
- Gevoelens van onmacht

➔ Onder de boosheid zit vaak verdriet & machteloosheid

### Onderhandelen en vechten

= de persoon probeert het verlies ongedaan te maken

- “Als ... dan ...” denken
- Beloftes doen
- Zoeken nr manieren om het verlies terug te draaien
- “Als ik dit doe, komt alles misschien weer goed.”

### Verdriet en depressieve klachten

= de realiteit vh verlies dringt volledig door

- Intens verdriet
  - Terugtrekken uit sociale cc
  - Machteloosheid
  - Depressieve gevoelens
- ➔ De persoon beseft dat het verlies definitief is

### Aanvaarding

= de persoon erkent de realiteit vh verlies

- Het verlies krijgt een plaats
- Het leven wordt opnieuw opgenomen
- Men leert verder leven met het verlies

Aanvaarding betekent niet dat het verlies niet meer pijn doet, maar wel dat men ermee leert leven

### Kritiek op het model van Kübler-Ross

- ➔ Model is zeer bekend, maar wetenschappelijk zijn er beperkingen
- Er is geen bewijs dat iedereen deze fasen doorloopt
  - Niet iedereen doorloopt alle fasen
  - De volgorde ligt niet vast
  - Mensen kunnen tss fasen heen & weer bewegen
  - De duur & intensiteit verschillen sterk per persoon
- ➔ Drm wordt het model vandaag vooral gezien als beschrijving v mogelijke reacties op verlies, niet als vast stappenplan

### **Het viertakenmodel van Worden**



Worden beschouwd rouw niet als een reeks fasen, maar als vier taken die een rouwende moet vervullen

- ➔ Deze taken kunnen door elkaar lopen & worden niet noodzakelijk in een vaste volgorde uitgevoerd

### Rouwtaak 1: Erkennen van het verlies

= de persoon erkent dat het verlies werkelijk gebeurd is

- Het verlies hoeft nog niet aanvaard te zijn
- Men beseft wel dat het een feit is

Voorbeelden:

- Niet meer denken dat de persoon elk moment terugkomt
- Over de overledene spreken in de verleden tijd
- Erkennen dat de situatie definitief veranderd is

#### Rouwtaak 2: Herkennen en ervaren van de pijn

= de persoon laat de emoties toe die bij het verlies horen

- Verdriet ervaren
- Pijn toelaten
- Gevoelens onder ogen zien

Vaak wordt het verdriet hier dieper:

- Niet alleen het gemis van een rol
- Maar ook het gemis van de persoon zelf

Hier begrijpen mensen soms niet waarom ze zich plots nog verdrietiger voelen

#### Rouwtaak 3: Verkennen en aanpassen

= persoon leert leven zonder wat of wie verloren werd & hierbij groeit vaak opnieuw het zelfvertrouwen

- Aanpassing aan het nieuwe leven
- Ontw v nieuwe vaardigheden
- Zoeken nr nieuwe routines

Voorbeelden:

- Nieuwe taken opnemen
- Zelf zaken regelen die vroeger door de ander werden gedaan
- Nieuwe rituelen ontw: verjaardag herdenken of vaste manier vinden om belangrijke dag door te brengen

#### Rouwtaak 4: Verbinden

= de persoon leert opnieuw vh leven houden terwijl het verlies een plaats krijgt

- Het verlies wordt niet losgelaten
- Er ontstaat een blijvende band met wat verloren is

Voorbeelden:

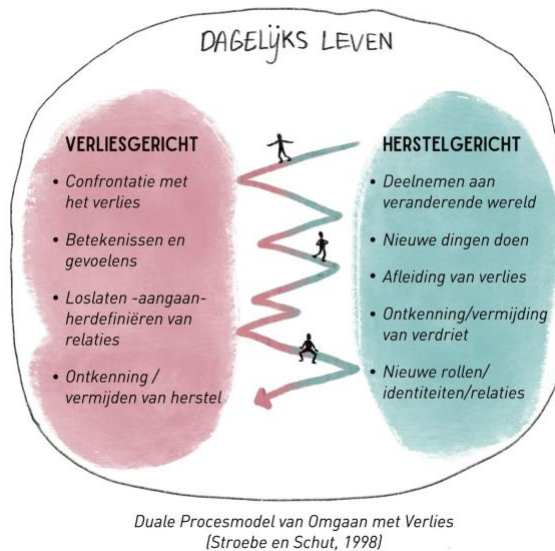
- Over de overledene blijven praten
- Herinneringen bewaren
- Voorwerpen van de overledene dragen
- Betekenis vd persoon meenemen in verdere leven

Bij een scheiding kan dit betekenen:

- Respectvol over de ex-partner spreken
  - De gezamenlijke geschiedenis erkennen
- ➔ Het doel is niet vergeten, maar verder leven mét de herinnering

## 7. Rouw (deel 2: recente modellen & visies op rouw)

### Het Duale Procesmodel (Stroebe & Schut)



= één vd meest gebruikte moderne rouwmodellen

- ➔ Volgens Stroebe & Schut verloopt rouw niet in vaste fasen, maar beweegt een rouwende voortdurend heen en weer tss twee processen:
- Verliesgerichte coping
  - Herstelgerichte coping

= dynamisch slingerproces waarbij iemand afwisselt tss aandacht voor verlies & voor het verdere leven

#### Verliesgerichte coping

= focus volledig op het verlies zelf & persoon wordt geconfronteerd met:

- Het gemis
- De pijn vh verlies
- De emoties die daarbij horen

Kenmerken:

- |             |                   |                         |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| - Verdriet  | - Wanhoop         | - Angst                 |
| - Verlangen | - Prikkelbaarheid | - Depressieve gevoelens |

Belangrijke processen:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confrontatie met het verlies  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het verlies onder ogen zien</li> <li>• Erkennen wat er gebeurd is</li> </ul>                                                                                                            |
| Betekenis geven aan gevoelens | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begrijpen wat het verlies betekent</li> <li>• Gevoelens plaatsen en verklaren</li> <li>• Sluit aan bij het AREA-model: betekenisgeving helpt om verlies draaglijker te maken</li> </ul> |
| Relaties herdefiniëren        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het verlies niet vergeten</li> <li>• Een nieuwe manier vinden om verbonden te blijven</li> <li>• Een evenwicht zoeken tss verder leven &amp; herinneringen bewaren</li> </ul>           |
| Vermijding van herstel        | <p>Sommige mensen blijven volledig in verlies hangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activiteiten stopzetten</li> </ul>                                                                                            |

|  |                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen toekomst meer zien</li> <li>• Het gewone leven niet meer opnemen</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Herstelgerichte coping

= hier verschuift aandacht naar het leven na het verlies

➔ De focus ligt op aanpassing, nieuwe rollen & verder leven

Belangrijke processen:

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deelname aan een veranderde wereld      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het leven gaat verder ondanks het verlies</li> <li>• Opnieuw deelnemen aan maatschappij</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nieuwe dingen doen                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuwe ervaringen opdoen</li> <li>• Dingen voor de eerste keer doen zonder de persoon of situatie die verloren ging</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Afleiding van verlies                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Even niet bezig zijn met verdriet</li> <li>• Genieten zonder schuldgevoel</li> </ul> <p>Voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op restaurant gaan</li> <li>- Op vakantie gaan</li> <li>- Wandelen</li> <li>- Afspreken met vrienden</li> </ul> <p>➔ Belangrijk = afleiding is niet hetzelfde als ontkenning</p> |
| Nieuwe rollen en identiteit ontwikkelen | <p>Door verlies veranderen rollen vaak</p> <p>Voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weduwe of weduwnaar worden</li> <li>• Alleenstaande ouder worden</li> <li>• Zelf taken opnemen die vroeger door de partner werden gedaan</li> </ul>                                                                                                                 |

### De slingerbeweging

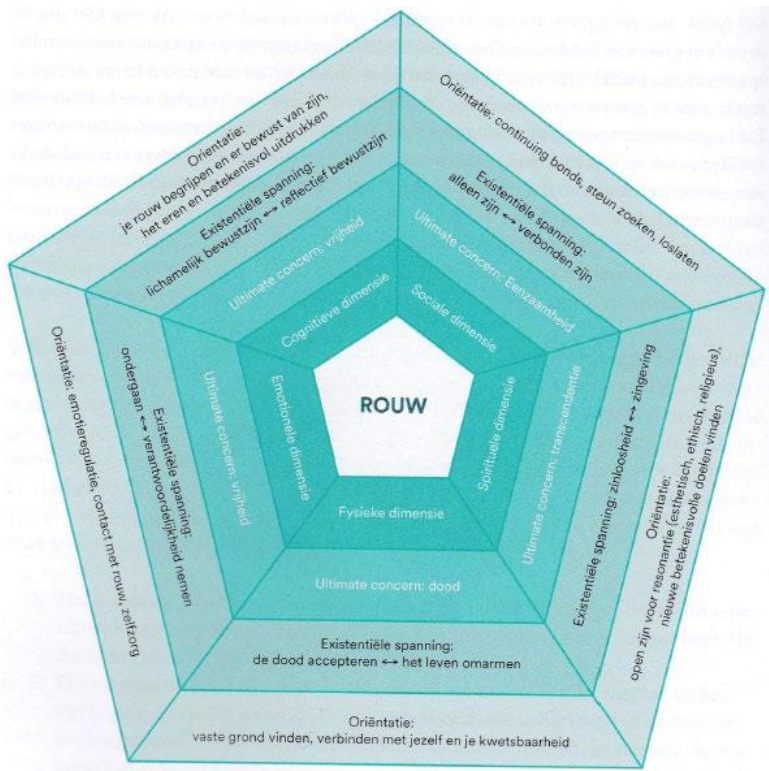
= de kern van het model:

➔ Een rouwende beweegt voortdurend tussen verliesgerichte & herstelgerichte coping

Je staat als het ware:

- Met één been in de wereld van verlies
  - Met één been in de wereld die verder draait
- ➔ Door voortdurend heen & weer te bewegen ontstaat langzaam een nieuw evenwicht
- Geen vaste volgorde
  - Geen eindpunt
  - Iedereen slingert op zijn eigen manier

## Het Integratief Procesmodel (IPM)



### Wat is het IPM?

= Integrated Process Model of Loss and Grief (IPM) werd ontw door Mai-Britt Guldin & Carlo Leget

- ➔ Momenteel één vd meest recente rouwmodellen
- ➔ Het model combineert inzichten uit oudere & nieuwere rouwtheorieën

### Uitgangspunten:

- Verlies is v nature existentieel
- Rouw is uniek voor iedere persoon
- Rouw kan niet volledig opgelost worden
- Er bestaat geen vaste volgorde v rouwreacties
- Iedereen zoekt op eigen manier nieuw evenwicht

### Centrale visie van het IPM

= volgens het model confronteert verlies ons met fundamentele levensvragen

Iedere mens krijgt te maken met spanningen rond:

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| - Leven en dood                | - Verantwoordelijkheid & overgave |
| - Controle en machteloosheid   | - Betekenis & zinloosheid         |
| - Verbondenheid en eenzaamheid |                                   |

= deze spanningen zijn universeel, maar watat verschilt tss mensen is:

- ➔ Hoe ze ermee omgaan
- ➔ Welke dimensie op de voorgrond komt
- ➔ In welke volgorde dit gebeurt

## **De vijf dimensies van het IPM**

### De fysieke dimensie

- Vermoeidheid
- Slaapproblemen
- Spanning
- Verlies v eetlust
- Energieverlies

Soms ook:

- Verhoogde bloeddruk
- Verminderde weerstand

Existentieel perspectief = confrontatie met:

- Dood
- Eindeigheid
- Verlies van rollen
- Verlies v relaties
- Verlies v idealen

Centrale spanning tss:

- ➔ Het leven omarmen & de dood en eindigheid accepteren

### De emotionele dimensie

- Verdriet
- Woede
- Schuldgevoelens
- Wanhoop
- Verlangen

Existentiële spanning tss:

- ➔ Verantwoordelijkheid nemen voor emoties & zich overgeven aan emoties

Belangrijk:

- ➔ Emoties toelaten & tegelijk voorkomen dat je er volledig door overspoeld wordt
- ➔ Dus = voelen én zelfzorg toepassen

### De cognitieve dimensie

- Ongeloof
- Concentratieproblemen
- Vergeetachtigheid
- Rumineren
- Magisch denken

Existentieel perspectief:

- ➔ Vrijheid en verantwoordelijkheid

Centrale spanning tss:

- ➔ Reflectief bewustzijn & belichaamd bewustzijn

Dit betekent:

- ➔ Enerzijds nadenken over het verlies
- ➔ Anderzijds voelen wat er lichamelijk gebeurt
- ➔ Persoon leert begrijpen hoe gedachten & lichaam elkaar beïnvloeden tijdens rouw

### De sociale dimensie

- Veranderingen in sociale relaties
- Herdenkingsrituelen

- Moeilijkheden in communicatie
- Zoeken nr steun

Rouw gebeurt nooit alleen

- ➔ Speelt zich af binnen relaties, families, culturen & gemeenschappen

Existentieel perspectief:

- ➔ Isolatie

Centrale spanning tss:

- ➔ Alleen zijn & verbonden blijven

De uitdaging is:

- ➔ De band met de overledene behouden & tegelijk nieuwe verbindingen aangaan

De spirituele dimensie

- Waarom is dit gebeurd?
- Wat betekent dit verlies?
- Hoe moet ik nu verder leven?
- ➔ Existentieel perspectief = betekenisloosheid
- ➔ Centrale taak = nieuwe betekenis vinden

Dit kan gebeuren via:

- Persoonlijke waarden
- Religie
- Verbondenheid met iets groters dan zichzelf
- Filosofie

De zoektocht nr betekenis is sterk beïnvloed door:

- De fysieke dimensie
- De cognitieve dimensie
- De emotionele dimensie
- De sociale dimensie

## 8. Betekenisgeving

### Wat is betekenisgeving?

= vormen v mentale voorstelling v mogelijke verbanden tss gebeurtenissen, ervaringen, relaties, situaties

- ➔ Wnr een gebeurtenis niet logisch verklaard kan worden, of wnr een rationele verklaring onvoldoende troost biedt, proberen mensen vaak betekenis te geven aan wat hen is overkomen

= mensen willen begrijpen waarom iets gebeurde & welke plaats het krijgt in hun leven

### Het model van Crystal Park

Volgens Crystal Park beschikken mensen over eigen referentiekader waarmee ze nr de wereld kijken

- ➔ Dit noemt zij algemene zingeving (Global Meaning)
- ➔ Dit is de algemene visie die iemand heeft op zichzelf, andere mensen, het leven & de wereld
- ➔ Deze zingeving vormt cognitief kader waarmee gebeurtenissen geïnterpreteerd worden

Voorbeelden:

- “De wereld is eerlijk.”
- “Hard werken wordt beloond.”
- “Alles gebeurt met een reden.”
- “Mensen zijn in wezen goed.”



Situationele zingeving (Situational Meaning)

= wnr een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt, proberen mensen die specifieke situatie te begrijpen

Voorbeelden:

- Waarom werd ik ziek?
- Waarom verloor ik mijn job?
- Waarom verloor ik mijn partner?
- Waarom overkomt dit mij?

### **Stress door een discrepantie**

Stress ontstaat wnr er een verschil ontstaat tss:

- ➔ Algemene zingeving (hoe je normaal naar de wereld kijkt)
- ➔ Situationele zingeving (hoe je de gebeurtenis ervaart)

Voorbeeld:

- ➔ Algemene zingeving: "Goede mensen overkomt niets ergs."
- ➔ Life event: een geliefde overlijdt plots
- ➔ Situationele zingeving: "Waarom gebeurt dit met iemand die zo goed was?"

= er ontstaat een discrepantie & hierdoor ontstaat stress

### **Het proces van betekenisgeving**

= wnr er een discrepantie ontstaat, start een proces van betekenisgeving

Doel:

- Het verschil tss algemene & situationele zingeving verkleinen
- Een nieuwe betekenis vinden voor de gebeurtenis
- De wereld opnieuw als begrijpelijk ervaren

Als dit lukt:

- Daalt de stress
- Ontstaat er opnieuw een gevoel v samenhang
- Kan men zich beter aanpassen ad situatie

### **Coping en betekenisgeving**

- ➔ Mensen gebruiken copingstrategieën om betekenis te geven aan moeilijke gebeurtenissen
- ➔ Ze zoeken vaak steun in bepaalde kaders die richting geven aan hun zoektocht nr betekenis

Belangrijke voorbeelden zijn:

#### Spiritualiteit

= het streven nr & ervaren v verbondenheid met de kern vh leven

Deze verbondenheid kan bestaan met:

- Zichzelf
- Huidige moment
- Andere mensen
- Iets dat als belangrijk/heilig wordt ervaren
- De natuur

#### Rituelen

= handelingen met symbolische betekenis die een life event markeren

- Hebben een bijzondere betekenis
- Gebeuren vaak in een vaste volgorde
- Kunnen religieus of cultureel bepaald zijn

Voorbeelden:

- ➔ Een begrafenis, herdenkingsmoment, afscheidsritueel

Functie = betekenis geven aan belangrijke gebeurtenissen

#### Tradities

= gebruiken die:

- ➔ V generatie op generatie worden doorgegeven
- ➔ Binnen een groep ontstaan
- ➔ Regelmatig worden herhaald

Voorbeelden:

- ➔ Kerstmis vieren, jaarlijkse herdenkingen, familietradities

Tradities = kunnen steun & continuïteit bieden tijdens moeilijke periodes

#### Kunst en creativiteit

= bieden een alternatieve manier om ervaringen te verwerken

- Schrijven
- Teken
- Schilderen
- Muziek maken
- Dansen

Functies:

- ➔ Emoties uiten & verwerken
- ➔ Betekenis geven aan ervaringen

## **9. Sociale steun**

### **Wat is sociale steun?**

Een life event kan iemand sterk confronteren met existentiële eenzaamheid = het gevoel dat niemand exact begrijpt wat jij meemaakt of voelt

- ➔ Toch blijkt het omringen met anderen vaak zeer helpend & helend
- ➔ Niet alleen moeilijke gebeurtenissen worden gedeeld met anderen, ook positieve gebeurtenissen worden vaak samen beleefd

Sociale steun kan:

- Materieel zijn
- Informatief zijn
- Emotioneel zijn
- Combinatie v deze vormen zijn
- ➔ Steun kan komen v familie, vrienden, partner, collega's, professionele hulpverleners & de maatschappij als geheel

### **Vormen van sociale steun**

#### Materiële steun

= verwijst nr praktische of financiële hulp, iemand helpt je concreet bij een moeilijke situatie & kan dagelijkse lasten tijdelijk verlichten

- Kraamkost brengen na een geboorte
- Iemand naar huis brengen na slecht nieuws
- Helpen bij een verhuis
- Financiële ondersteuning
- Praktische hulp ih huishouden

### Informatieve steun

= helpt mensen om situaties beter te begrijpen en keuzes te maken & bestaat uit het geven v:

- Informatie
- Raad
- Advies
- Suggesties

Professionele informatieve steun:

- Advies van een arts
- Begeleiding door maatschappelijk werker
- Informatie v psycholoog
- Raad v kinesist of andere hulpverlener

Niet-professionele informatieve steun:

- Vrienden die advies geven bij een sollicitatie
- Familie die tips geeft rond opvoeding
- Kennissen die ervaringen delen over ouderschap of werk

### Emotionele steun

= zorgt ervoor dat mensen zich minder alleen voelen tijdens moeilijke momenten:

- Luisteren
- Aanwezig zijn
- Begrip tonen
- Meeleven

Vaak is het gevoel dat iemand beschikbaar is al belangrijk:

- Een luisterend oor bieden
- Begrip tonen voor emoties
- Troost geven
- Er zijn wnr iemand steun nodig heeft

## **10. Herstel**

### **Wat is herstel?**

= i dagelijks taalgebruik is herstellen meestal beter worden of genezen (bv. herstellen van de griep)

Binnen de geestelijke gezondheidszorg:

= leren leven met een ontwrichtende aandoening, beperking of kwetsbaarheid, waarbij mogelijkheden & krachten v d persoon centraal staan

- ➔ Gaat dus niet om het verdwijnen v aandoening, maar om het vinden v manier om ermee te leven & opnieuw betekenisvolle rollen op te nemen

Belangrijk:

- Herstel is een persoonlijk en individueel proces
- De nadruk ligt op mogelijkheden en krachten, niet op beperkingen
- Sociale rollen opnieuw opnemen is belangrijk:
  - Ouder zijn, werknemer zijn, partner zijn, vriend(in) zijn
- Herstel is mogelijk, ook wanneer de aandoening niet volledig verdwijnt

Herstel vraagt:

- Actieve acceptatie v kwetsbaarheden & beperkingen
- Leren omgaan met problemen
- Evolutie v patiëntidentiteit nr burgerschap

### **Verskil tussen herstel en veerkracht**

- Veerkracht = na moeilijke gebeurtenis terugveren nr het oorspronkelijke niveau v functioneren
- Herstel = je wordt niet meer exact dezelfde persoon als voordien

De ervaring laat sporen na:

- Zoals een touw met een knoop erin
- Zoals een balk met een gelijmde barst

De kwetsbaarheid blijft bestaan, maar men leert ermee leven

De persoon wordt dus:

- Veranderd door de ervaring
- Bewust v kwetsbaarheden
- In staat om opnieuw een betekenisvol leven uit te bouwen

### **Definitie van Anthony (1993)**

= omschreef herstel als een uniek & persoonlijk proces waarin iemand opnieuw hoop ontw, controle krijgt over het eigen leven & opnieuw kan deelnemen aan betekenisvolle activiteiten

➔ De persoon zelf is de deskundige van zijn of haar herstelproces

Kenmerken:

- Hoop voor de toekomst
- Betekenisvolle participatie
- Gevoel van controle
- Eigen regie staat centraal

### **Fasen van herstel**

Belangrijk:

- Het proces is niet lineair
- Mensen kunnen tss fasen heen en weer bewegen
- De duur verschilt v persoon tot persoon

#### Fase 1: Overweldigd zijn door de gebeurtenis

= ontreddeering staat centraal

➔ De gebeurtenis of aandoening lijkt het hele leven over te nemen

Kenmerken:

- Verwarring
- Ontreddeering
- Hopeloosheid
- Machteloosheid
- Gevoel v isolatie
- Verlies v controle
- Focus op overleven

= het gevoel overheerst dat het leven volledig stilstaat

Voorbeeld:

- Een diagnose krijgen v ernstige ziekte
- Geconfronteerd worden met een psychische aandoening

#### Fase 2: Worstelen met de gebeurtenis

= persoon beseft dat gebeurtenis deel uitmaakt v leven

➔ De centrale vraag wordt "Hoe ga ik hiermee leven?"

Men probeert:

- Zichzelf terug te vinden
- Manieren te zoeken om met symptomen om te gaan
- Een nieuwe identiteit te ontwikkelen

Kenmerken:

- Worsteling
- Onzekerheid
- Gebrek aan zelfvertrouwen
- Identiteitsvragen
- Zoeken nr betekenis

Typische vragen:

- Wie ben ik nog?
- Hoe zien anderen mij?
- Ben ik meer dan mijn aandoening?

### Fase 3: Leven met de gebeurtenis

= het besef dat er met de aandoening kan worden omgegaan groeit & de angst vermindert geleidelijk

- ➔ Men ontdekt beperkingen, sterke kanten & mogelijkheden
- ➔ De persoon leert een leven uitbouwen mét de aandoening

Kenmerken:

- Opbouwen v nieuwe identiteit
- Herstellen v oude rollen
- Ontw v nieuwe rollen
- Opnieuw cc maken met anderen

### Fase 4: Leven voorbij de gebeurtenis

= aandoening blijft aanwezig, maar staat niet langer centraal

- ➔ De gebeurtenis maakt nog deel uit van het leven, maar beheerst het leven niet langer

Er ontstaat opnieuw ruimte voor:

- Verbondenheid
- Persoonlijke doelen
- Talenten
- Mogelijkheden
- Toekomstplannen

Kenmerken:

- Nieuwe levensdoelen ontw
- Capaciteiten inzetten
- Deelnemen ah gewone leven
- Rekening houden met de kwetsbaarheid zonder dat die alles bepaalt

## **Herstelgericht werken**

= om herstel te stimuleren

- ➔ Daarvoor moet men afstand nemen v klassieke medische of paternalistische model
- ➔ Belangrijk uitgangspunt = de cliënt is de expert v zijn eigen herstel
- ➔ De hulpverlener ondersteunt, begeleidt & werkt samen met de persoon
- ➔ De regie blijft zoveel mogelijk bij de cliënt

## **Het CHIME-model**

Leamy en collega's ontwikkelden in 2011 het CHIME-model

- ➔ Dit model beschrijft belangrijke elementen die herstel ondersteunen

### C = Connectedness

= verbondenheid met anderen

- ➔ Mensen herstellen beter wnr ze zich verbonden voelen

- Sociale steun
- Relaties
- Erbij horen
- Deel uitmaken van gemeenschap

### H = Hope

= hoop en optimisme: vormt een belangrijke motor voor herstel

- ➔ Geloven dat herstel mogelijk is
- ➔ Vertrouwen hebben in de toekomst
- ➔ Motivatie om te veranderen

### I = Identity

= positieve identiteit ontwikkelen

De persoon leert:

- Meer te zijn dan de aandoening
- Stigma te overstijgen
- Opnieuw een positief zelfbeeld op te bouwen

### M = Meaning

= betekenis geven aan leven

Dit gaat over:

- Levensdoelen
- Sociale rollen
- Persoonlijke ervaringen
- Kwaliteit van leven

= herstel is sterk verbonden met omgeving

### E = Empowerment

= controle ervaren over het eigen leven

- Zelf keuzes maken
- Verantwoordelijkheid opnemen
- Eigen mogelijkheden ontdekken
- Opnieuw regie ervaren

## **Onderzoek naar herstelgericht werken**

Een meta-analyse van Thomas en collega's (2018) onderzocht persoonsgerichte herstelpraktijken bij mensen met psychiatrische problemen

- ➔ Resultaat = meer herstel, meer hoop & meer empowerment

Vooraf een combinatie van:

- Traditionele hulpverlening
- Inzet van ervaringsdeskundigen

bleek positieve effecten te hebben

## **Twee kernbegrippen binnen herstel**

### Empowerment

Empowerment heeft zijn oorsprong in:

- Burgerrechtenbewegingen
- Vrouwenrechtenbewegingen
- Patiëntenbewegingen

Doel:

- Mensen opnieuw kracht geven
- Stigmatisering tegengaan
- Eigen regie versterken

Empowerment is:

- Individueel proces
  - Eigen mogelijkheden ontdekken
  - Kwetsbaarheden leren kennen
  - Controle krijgen over het eigen leven
- Sociaal-maatschappelijk proces
  - Discriminatie tegengaan
  - Uitsluiting verminderen
  - Stigma bestrijden

### Ervaringsdeskundigheid

Ontstaat uit persoonlijke ervaringen met:

- Psychische problemen
- Verslaving
- Herstelprocessen

Een ervaringsdeskundige kan:

- Hoop geven
- Steun bieden
- Herkenning creëren
- Gemakkelijker cc maken

De gedeelde ervaring zorgt vaak voor meer geloofwaardigheid

- ➔ Mensen die zelf gelijkaardig proces hebben doorgemaakt kunnen tonen dat herstel mogelijk is
- ➔ Daardoor kunnen zij hoop versterken, motivatie vergroten & herstel ondersteunen

Ervaringsdeskundigheid helpt mensen om los te komen v stigma's & ondersteunt ontw ve herstelverhaal

### **Kernidee**

- ➔ Herstel is geen genezing, maar persoonlijk proces waarbij iemand leert leven met een kwetsbaarheid, opnieuw hoop ontw, betekenis vindt, controle ervaart over eigen leven & opnieuw een plaats inneemt id samenleving

## **11. Posttraumatische groei**

### **Wat is posttraumatische groei?**

= PTG verwijst nr positieve psychologische veranderingen die kunnen ontstaan na het meemaken ve ingrijpende traumatische gebeurtenis

Een trauma kan veel negatieve gevolgen hebben, zoals:

- Angst
- Stress
- Verdriet
- Depressieve gevoelens

Maar sommige mensen ervaren daarnaast ook een vorm van persoonlijke groei

Belangrijk:

- ➔ Het trauma zelf is niet positief
- ➔ Groei ontstaat door de manier waarop iemand met gebeurtenis omgaat & er betekenis aan geeft

## **Vijf domeinen van posttraumatische groei**

### Verdieping van relaties met anderen

- ➔ Meer verbondenheid, empathie, begrip voor anderen, compassie
- ➔ Relaties krijgen vaak meer diepgang en betekenis

### Ontdekking van nieuwe mogelijkheden

- Een nieuwe studie beginnen
  - Nieuwe interesses ontw
  - Een andere job kiezen
  - Nieuwe doelen stellen
- ➔ Voorbeeld: iemand kiest voor een medische opleiding na het overlijden van een belangrijke persoon

### Bewustwording van persoonlijke krachten en talenten

Mensen ontdekken dat ze sterker zijn dan ze vooraf dachten & ervaren:

- ➔ Meer zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen & geloof in eigen kunnen
- ➔ “Ik wist niet dat ik dit aankon.”

### Toename van spiritueel of religieus besef

Een trauma kan mensen doen nadenken over:

- De zin van het leven
- Spiritualiteit
- Geloof
- Existentiële vragen

Gevolgen kunnen zijn:

- ➔ Een sterker geloof, meer spirituele verbondenheid, dieper begrip van wat belangrijk is in het leven

### Toename van waardering voor het leven

- Kleine dingen meer waarderen
- Meer in het moment leven
- Minder vanzelfsprekendheden te zien

Voorbeelden:

- ➔ Tijd met familie waarderen, genieten van dagelijkse momenten, meer dankbaarheid ervaren

## **Verschil tussen veerkracht en posttraumatische groei**

Veerkracht = je “veert terug”

- Herstel je na een moeilijke gebeurtenis
- Keer je terug naar je eerdere niveau van functioneren

Posttraumatische groei = je bereikt een hoger niveau van functioneren dan vóór de gebeurtenis

- Herstel je niet alleen
- Ontwikkel je jezelf verder

Er ontstaat nieuwe inzichten, mogelijkheden & persoonlijke ontwikkeling

## **Geen eindpunt**

= posttraumatische groei is geen toestand die je plots bereikt & daarna behoudt

- ➔ Dynamisch proces, voortdurende ontwikkeling, zoektocht naar nieuwe betekenis
- ➔ De groei kan zich blijven ontwikkelen gedurende het verdere leven



## DIGITALE TOOLS

### Hoorcollege 2: ouderschap

<https://perinatalehulp.be/zelfhulp>

- Helpt vrouwen met lichte tot matige depressieve gevoelens na zwangerschap
- Werkt het best bij mensen die zelf nog actief willen werken aan hun stemming
- Wordt verwacht dat p min 1 keer per week op de online zelfhulp gaat
- Er wordt gevraagd om iemand uit de omgeving mee te betrekken in traject
- Traject van een tiental weken

<https://www.kinderwens.org/vanrozenaarbrozewolk>

- Onderdeel v vzw-kinderwens (expertisecentrum rond (on)vruchtbaarheid)
- Zorgnet rond perinatale welzijn voor ouders in eerste 1001 dagen
- Bieden infosessies & zorgprogramma's gericht op het verhogen van veerkracht bij jonge ouders of wensouders

<https://wolkinmijnhoofd.be>

- Gericht op detectie, preventie & behandeling v mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap
- Tot 1j na de bevalling
- Tips en getuigenissen over depressie, angst, psychose en ook over veerkracht

<https://vaderen.be/>

- Vertrekken vanuit vragen v vaders v kinderen 0 tot 8 j
- Tools om als vader in gesprek te gaan en zo veerkrachtig het vaderschap eerlijk op te nemen

<https://appadvice.com/app/keep-in-touch-kit/1289151067>

- App voor gescheiden gezinnen zonder al te grote complicaties
- Kalender, checklists, deadlines, chatroom

<https://www.scheidingskoffer.be/>

- Voor gescheiden gezinnen
- Vragen en antwoordfiches, reflectievragen, liedjes, tips, ...

<https://steunpuntadoptie.webinargeek.com/>

- Online webinars volgen
- Info voor mensen die geadopteerd zijn, adoptieouders, professionals, ...

<https://a-buddy.be/nl>

- App die op een laagdrempelige manier lotgenoten cc voor geadopteerden
- Anoniem praten met andere geadopteerde of om een buddy aan te vragen
- Verhalen, ervaringen

<https://www.zojong.be/>

- Voor mantelzorgers en organisaties voor mantelzorgers
- Hoe je als mantelzorger voor jezelf kan zorgen & veerkrachtig ih leven kan staan

<https://www.druglijn.be/grip/grip-voor-kinderen/#/>

- Veerkracht tools voor KOPP-kinderen met ouders met een verslavingsproblematiek
- Psycho-educatie zowel visueel als om te lezen

### Hoorcollege 3: relaties

<https://vragenlijsten.mijnpositievegezondheid.nl>

- Zien hoe het echt met je gaat
- Vragenlijst op volgende domeinen:
  - Lichaamsfuncties
  - Dagelijks functioneren
  - Mentaal welbevinden
  - Meedoen
  - Zingeving
  - Kwaliteit van leven
- Vul het spinnenweb regelmatig in en stel vrage zoals: wat valt op? Wat is belangrijk? Wat wil ik veranderen? Wat kan een eerste stap zijn?

<https://www.samenveerkrachtig.be/>

- Tijdens de 10daagse vd GGZ begin oktober worden activiteiten georganiseerd om veerkracht bij iedereen te verhogen
- Buiten oktober zijn er ook activiteiten

<https://www.reactoracism.be/zorgen-voor-jezelf-als-doelwit.html>

- Mensen die met racisme te maken hebben veerkrachtiger maken
- Bieden getuigenissen v mensen die racisme op een inspirerende manier aanpakken

<https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/>

- Tools om mensen met een handicap te ondersteunen op vlak v veerkracht

<https://www.noknok.be/>

- Tool voor jongeren uit de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> graad vh middelbaar veerkrachtiger te maken
- Opdrachten en oefeningen v 12 tot 16j

### Hoorcollege 4: school & werk

<https://moodspace.be/nl>

- Info, tips & zelfhulp voor studenten om emotionele problemen het hoofd te bieden & veerkrachtig te studeren

- Aanrader tijdens examenperiode

<https://www.allesoverpesten.be/wegwijzers/wegwijzer-voor-kinderen/jongeren>

- Wegwijzers voor kinderen & jongeren is een onderdeel v de site allesoverpesten
- Je kan kinderen die gepest worden of zelf pesten hiernaar doorverwijzen

<https://www.pimento.be/>

- Richt zich op iedereen die met jongeren werkt
- Cursussen en tools voor jou als hulpverlener om met jongeren over pesten aan de slag te gaan

<https://www.vrt.be/nl/edubox/catalogus#online-pesten>

- Tools voor verschillende doelgroepen met tips over hoe omgaan met online pesten

<https://www.tegek.be/psychische-problemen/klachten/stress-overspannenheid-en-burn-out>

- Psycho-educatie op maat over burn-out

<https://www.noknok.be/>

- Tool voor jongeren uit de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> graad vh middelbaar veerkrachtiger te maken
- Opdrachten en oefeningen v 12 tot 16j

<https://geluksdriehoek.be/>

- Geluksdriehoek bestaat uit 3 bouwblokken om te werken aan je geluk
  - Jezelf kunnen zijn
  - Je goed voelen
  - Goed omringt zijn

### Hoorcollege 5: verlies

<https://waarblijftmijntijd.mantelzorg.nl/>

- Voor mantelzorgers om inzicht te krijgen in hoeveel tijd ze besteden aan zorgtaken
- Voor volwassenen die langdurig zorgen voor een partner, ouder of familielid
- Kan helpen om ovrbelasting bespreekbaar te maken & ondersteuning te zoeken

<https://mijnherinneringaanjou.be/>

- Digitale herinneringsplek waar mensen foto's, verhalen en herinneringen aan overleden persoon kunnen bewaren & delen
- Voor kinderen, jongeren & volwassenen in rouwproces
- Kan steun bieden bij het verwerken v verlies & het levend houden v herinneringen

<https://missingyou.be/>

- Vlaamse organisatie met info, lotgenotencontact & activiteiten rond rouw na verlies
- Voor jongeren & jongvolwassenen die iemand verloren hebben

- Nuttig voor iemand die zich alleen voelt in rouwproces & cc zoekt met lotgenoten

<https://www.onlinehulp-apps.be/apps-overzicht/rouwkost>

- Rouwkost biedt psycho-educatie, oefeningen & info rond rouw
- Voor jongeren & volwassenen die ondersteuning zoeken bij verliesverwerking
- Kan ingezet worden bij normale rouwreacties of als aanvulling op begeleiding

<https://www.bovendewolken.be/>

- Organisatie die professionele foto's maakt v sterrenkinderen & gezinnen na zwangerschapsverlies of het overlijden v een baby
- Helpt bij herinneringsvorming, erkenning v verlies & rouwproces